

Prefeitura Municipal de Arcos/MG
Sistema Único de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde



Plano Municipal de Saúde de Arcos 2026-2029



Prefeito de Arcos
Welligton Francelli Estevão Rodrigues Roque

Secretária Municipal de Saúde
Aline Maria Correia Arantes

Conselho Municipal de Saúde
Presidente – Fernando Fernandes

*“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível
e de repente você estará fazendo o que é impossível”.*
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Plano Municipal de Saúde de Arcos 2026-2029

Autora:

Maria Cristina Ribeiro Borges Issa
Mestre em Saúde Coletiva
MASP:01512030-1

Colaboradores/ Equipe Técnica :

Aline Cristina Miranda Araújo - Diretora de Regulação
Aline Maria Alves - Diretora de Atenção Primária em Saúde
Carlos Antônio da Silva - Diretor de Transportes
Gladson Henrique Silva - Diretor de Saúde Mental
Mara Reis - Diretora do Hospital Municipal São José
Raquel Cristina Rodrigues - Período: à Partir de Fev.2026:
Renata de Oliveira Nativo - Diretora de Planejamento
Tânia Maria Alves Carvalho - Diretora de Especialidades - Período:
Janeiro a Dez.2025.

Amanda Rilsa Alves da Silva - Referência Técnica Farmácia Alto Custo
David Vieira Rocha - Sistema de Informação
Fernanda Naiara dos Santos - Referência Técnica de Imunização
Kelly Zuquim - Referência Técnica Básica
Lucielen Cristina Silva - Referência Técnica E-Multi
Roberta Dias de Oliveira Diniz - Referência Técnica Vigilância em Saúde
Graziella Gorete Teixeira - Referência Técnica do Centro de Fisioterapia

SUMÁRIO

Apresentação

1.Caracterização do Município de Arcos.....	10
1.1 Território.....	11
1.2 Demografia.....	13
1.3 Educação.....	19
1.4 Perfil Socioeconômico.....	21
1.5 Meio Ambiente.....	23
2.Gestão e Organização dos Serviços de Saúde.....	25
2.1 Gestão e Organização dos Serviços de Saúde.....	26
3. Análise da Situação de Saúde.....	28
3.1 Análise da Situação de Saúde.....	29
3.2 Natalidade.....	30
3.3 Morbimortalidade.....	42
3.3.1 Análise da Morbidade.....	43
3.3.2 Análise de Mortalidade.....	57
3.4 Doenças de Notificação Compulsória.....	87
3.5 Cenário Epidemiológico	100
4. Panorama Vacinal.....	106
5 Rede de Atenção e Serviços de Saúde de Arcos.....	121
5.1 Rede de Estabelecimentos de Saúde.....	122
5.1.2 Atenção Primária à Saúde.....	124
5.1.3 Assistência Farmacêutica.....	126
5.1.4 Assistência Hospitalar.....	129
5.1.5 Rede de Atenção às Urgências e Emergências.....	129
5.1.6 Vigilância em Saúde.....	131
5.1.7 Atenção à Saúde Mental.....	134
5.1.8 Rede de Saúde Especializa Ambulatorial.....	135
5.1.9 Tratamento Fora de Domicílio.....	136
5.2 Rede de Recursos Humanos Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde de Arcos.....	137
6. Produção dos Serviços de Saúde.....	139

7. Financiamento.....	145
7.1 Execução Orçamentária e Financeira.....	149
8. Diretrizes do Plano Municipal.....	157
9. Considerações Finais.....	158
10. Referências Bibliográficas.....	160
11. SIGLAS.....	163

Apresentação

O Planejamento no Sistema Único de Saúde é uma função gestora que além de requisito legal é um dos mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS como a universalidade, integralidade, equidade e participação popular, pois, valoriza a autonomia dos entes federados, uma vez que todo o processo é conduzido de maneira ascendente, integrada e solidária, entre as três esferas de governo.

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é o instrumento central de planejamento que visa dar direcionalidade à gestão pública da saúde, nele está explicitado os compromissos do governo para o setor saúde para o período de quatro anos.

O Plano é elaborado no primeiro ano de cada gestão, executado a partir do segundo ano da gestão em curso e finaliza-se no primeiro ano da gestão subsequente. O Plano deve ser formulado em consonância com os demais instrumentos de planejamento governamental, em especial o Plano Plurianual (PPA) e o Programa de Metas.

O Plano Municipal de Saúde contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a integralidade dessa atenção, uma vez que ele reflete as necessidades de saúde da população a partir da análise situacional do município e das prioridades locais.

A elaboração dos instrumentos de planejamento estabelecidos pela legislação são obrigações condicionantes para o recebimento das transferências intergovernamentais e configura-se como base para a execução, o acompanhamento e a avaliação da gestão do sistema de saúde.

O Poder Público Municipal por meio da Secretaria Municipal da Saúde, tem a missão de melhorar a qualidade de vida da população, através da formulação de políticas públicas de saúde capazes de assegurar o desenvolvimento de ações e serviços de acordo com as necessidades da população, respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde.

Este material foi elaborado de forma crítica e reflexiva com o objetivo de subsidiar o planejamento de políticas e ações em saúde que respondam aos atuais desafios que interferem no sistema de saúde, bem como contribuir para ampliar a resolutividade do Sistema Único de Saúde.

O Plano Municipal de Saúde de Arcos 2026-2029 foi construído através de um processo participativo e integrado, formulado com base no plano de governo, nos instrumentos de gestão pactuados e no controle social, através do Conselho Municipal de Saúde.

O presente Plano Municipal de Saúde estabelece diretrizes que são formulações que indicam as linhas de atuação a serem seguidas; objetivos e metas de médio prazo guiadas pelas políticas de saúde estadual e pelas demandas aprovadas na última conferência de saúde, que orientam as ações que serão executadas nas Programações Anuais de Saúde.

A prestação de contas da execução do Plano de Saúde será realizada por meio dos Relatórios trimestrais - RDQA e do Relatório Anual de Gestão (RAG) que expressam os resultados alcançados na Programação Anual de Saúde. Esses instrumentos são apresentados ao Conselho Municipal de Saúde e em audiência pública.

Assim sendo, considerando a relevância deste instrumento, apresentamos o Plano Municipal de Saúde que tem por objetivo expressar as responsabilidades, compromissos e prioridades da gestão municipal em relação à saúde da população de Arcos/MG no período de 2026 a 2029.

Planejamento em Saúde e o Controle Social

Conforme preconizado pela Lei 8.142 a Conferência de Saúde é essencial para a construção do Plano de Saúde Municipal, configurando um espaço democrático onde a população, trabalhadores da saúde e gestores podem avaliar, discutir e propor políticas públicas para a saúde com base na realidade local de cada município.

Ao integrar diferentes perspectivas (usuários, gestores e trabalhadores), a conferência constroeu um sistema de saúde de forma ascendente, mais equânime e alinhado aos princípios do Sistema Único de Saúde.

Em 2025 o município de Arcos realizou a Conferência Municipal de Saúde de Arcos em conjunto com a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, este evento foi a oportunidade de reafirmar o compromisso com a saúde pública como um direito de todos e dever do Estado, fortalecendo o SUS enquanto mecanismo de equidade e justiça social.

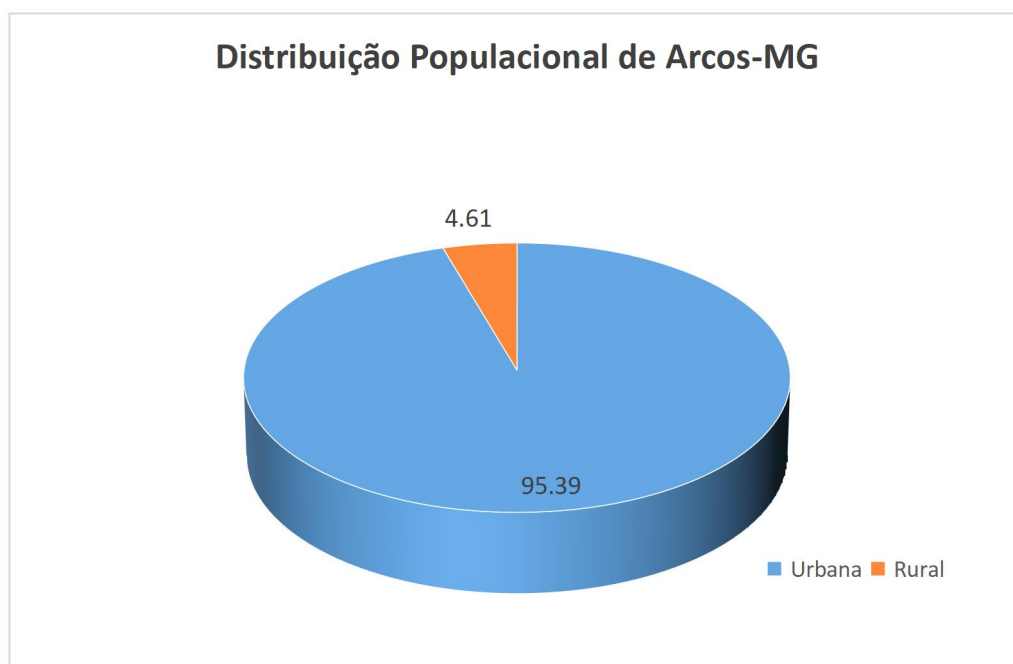
Como forma de assegurar e atender as necessidades e expectativas da participação da comunidade no processo de formulação, controle e avaliação das políticas públicas de saúde, o relatório final da conferência municipal de saúde de Arcos contribuiu como base principal para a elaboração das prioridades, diretrizes e metas do Plano Municipal de Saúde de Arcos para o período de quatro anos: 2026 a 2029, transformando assim as propostas aprovadas e demandas populares em políticas públicas obrigatória

Assim sendo, a Conferência de Saúde garante que o planejamento de saúde não seja apenas um instrumento técnico, mas sim um reflexo das necessidades reais da população, através do controle social.

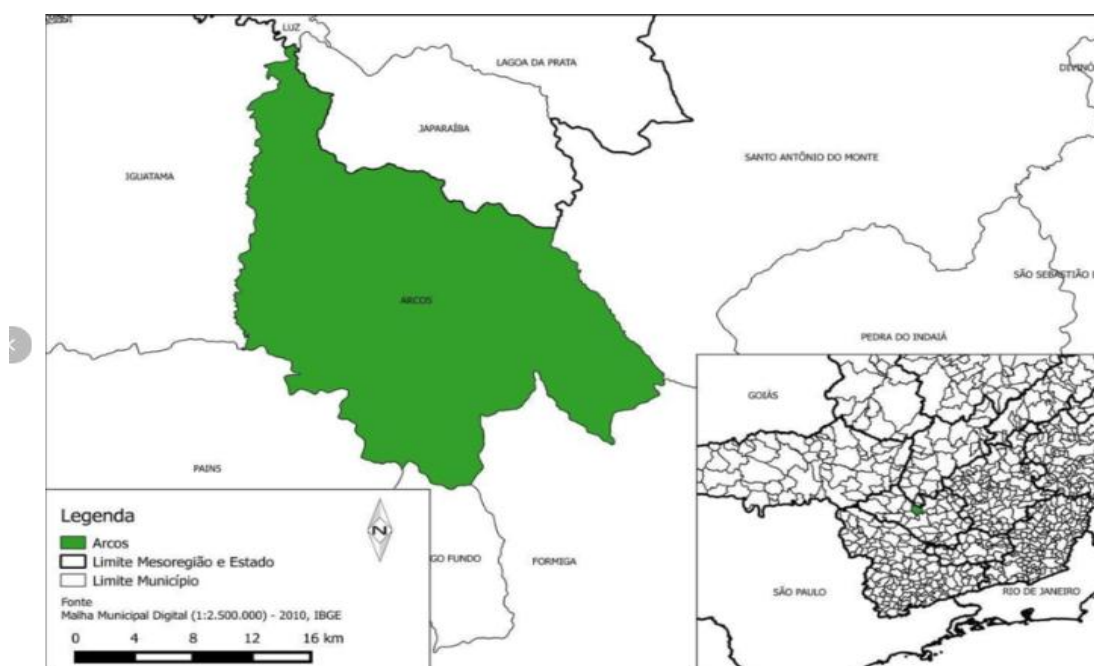
1 Caracterização do Município de Arcos

1.1 Território

A Cidade de Arcos - MG foi fundada em 17 de dezembro de 1938, está localizado na Zona do Alto São Francisco, região Centro-Oeste de Minas Gerais e conta com uma área territorial de 509,873 km². A área urbana é de 5,023km² onde está concentrada 95,39% da população e a área rural conta com 4,61% da população. A cidade está situada a 212 km da capital do Estado, Belo Horizonte.



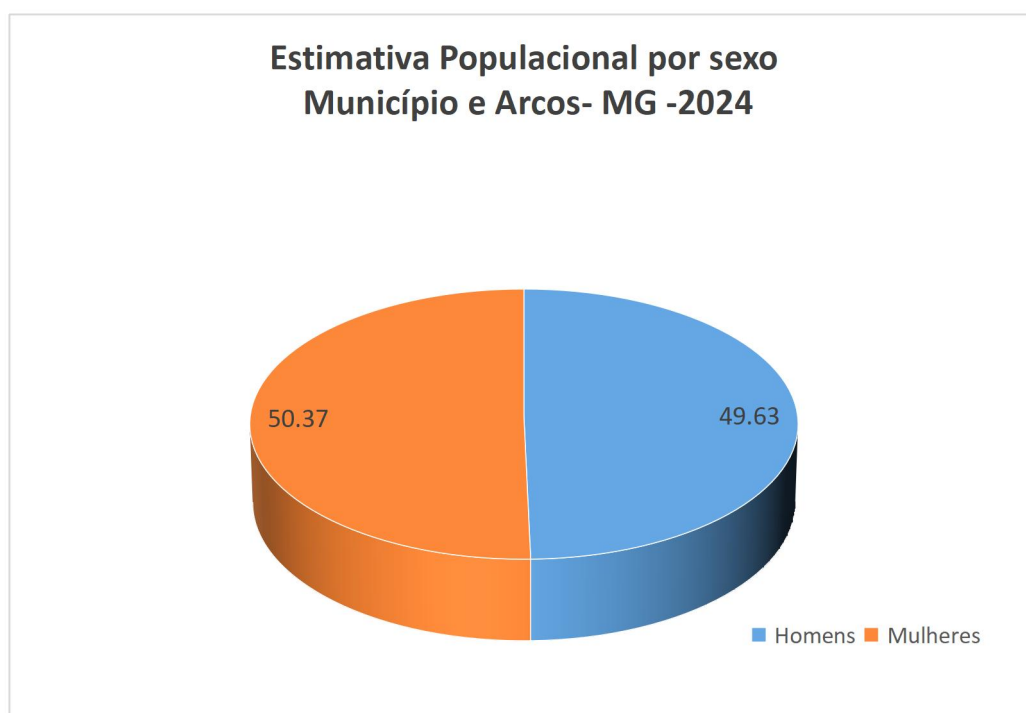
Os municípios limítrofes com o município de Arcos são: a leste: Formiga; ao sul: Pains e Córrego Fundo; a oeste, Iguatama; ao nordeste Santo Antônio do Monte; ao norte Luz e Japaraíba.



Situada às margens da BR-354, a cidade está no eixo de ligação rodoviário das principais rodovias federais do país, como BR-262, BR-040, BR-381 e MG-050. O município também se situa às margens da Linha Tronco, utilizada no escoamento de calcário das pedreiras locais, ligando a cidade ao estado do Rio de Janeiro e a cidade de Araguari, onde situa o corredor de exportação Araguari-Santos.

1.2 Demografia

Conforme dados do IBGE em 2022 o município de Arcos/MG contava com uma população de 41.416 habitantes e com uma densidade demográfica de 81,23 habitantes por quilômetro quadrado. A estimativa populacional para ano de 2024 foi 43.348 habitantes, composta por um contingente populacional onde 49,63% é do sexo masculino e 50,37% do sexo feminino.



Dentre esse universo populacional 0,09 % das pessoas se consideraram indígenas e 99,93% da população do município são brasileiros natos e apenas 0,07% são considerados naturalizados brasileiros.

No recorte por faixa etária o maior contingente populacional do município está entre os adultos jovens de 20 a 59 anos, considerada a população mais economicamente ativa.

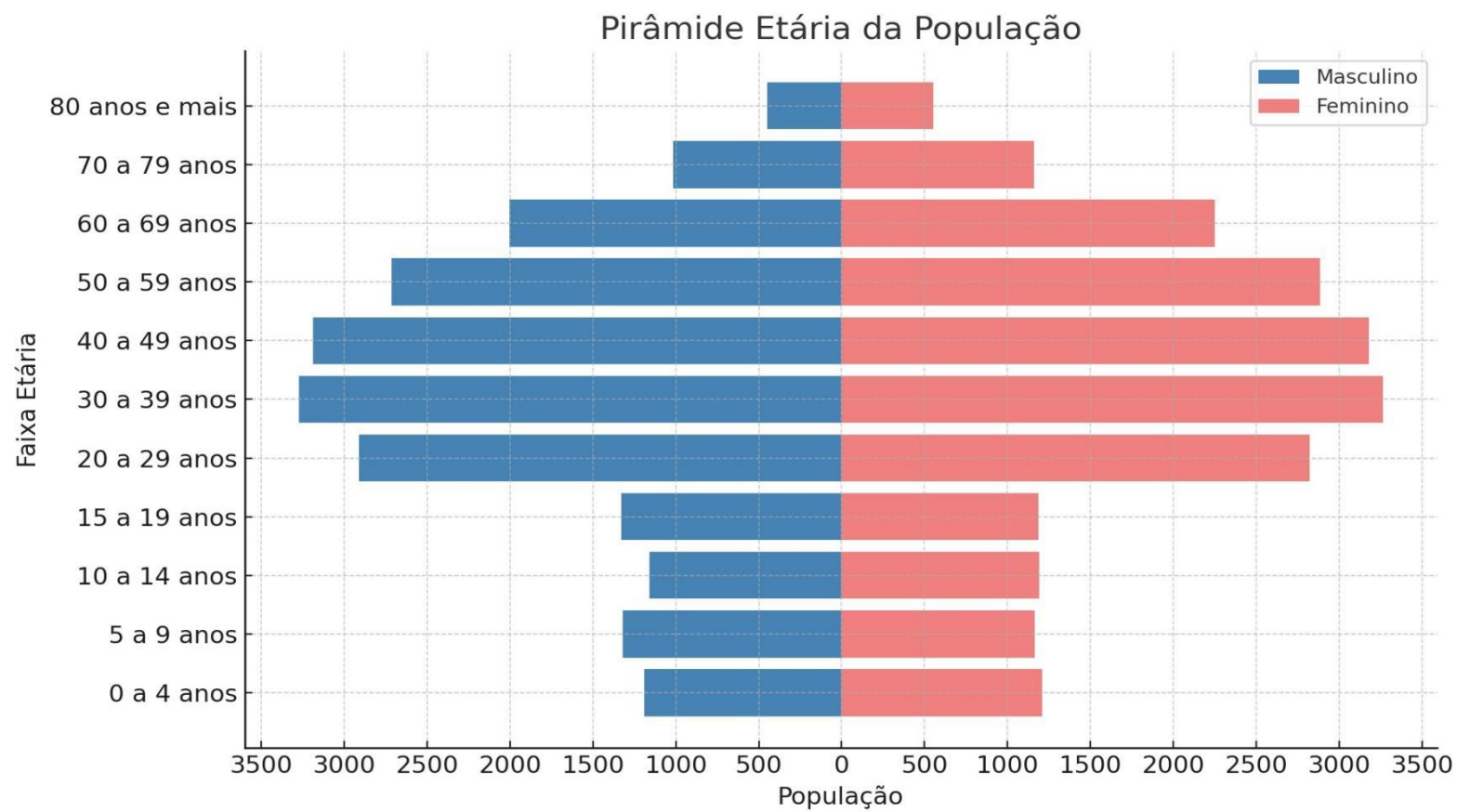
População estimada por sexo e faixa etária-Município de Arcos - MG Período: 2022			
Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	1191	1209	2400
5 a 9 anos	1321	1165	2486
10 a 14 anos	1158	1193	2351
15 a 19 anos	1329	1185	2514
20 a 29 anos	2911	2820	5731
30 a 39 anos	3274	3264	6538
40 a 49 anos	3187	3181	6368
50 a 59 anos	2713	2883	5596
60 a 69 anos	2005	2248	4253
70 a 79 anos	1017	1161	2178
80 a 89 anos	381	467	848
90 a 99 anos	65	83	148
100 e +	04	01	05
Total	20556	20860	41416

Fonte: IBGE-Censo 2022

A população brasileira é predominantemente feminina, conforme dados do Censo 2022. A proporção de mulheres ultrapassa a de homens no total, devido à maior taxa de mortalidade masculina em todas as faixas etárias. O município de Arcos acompanha o panorama nacional, pois, de acordo com as projeções populacionais do Ministério da Saúde para o ano de 2024, 21.646 pessoas são do sexo masculino e 21.702 são do sexo feminino, configurando 56 mulheres a mais.

Embora as mulheres têm uma vida mais longa que a dos homens, isso não significa que elas vivem melhor e com mais qualidade. Tendo em vista que esse envelhecimento acontece em um país em desenvolvimento e que não se preparou para receber um contingente maior de idosos, o envelhecimento vem acompanhado da pobreza e da desigualdade social. Essa situação afeta ainda mais as mulheres idosas que vivenciam a desigualdade socioeconômica, a falta de autonomia , a violência, a pobreza, à exclusão social e a discriminação que vem em dose dupla, pela idade e gênero, muitas vezes tornando-as invisíveis para a sociedade.

Assim sendo, as mulheres idosas enfrentam uma série de desafios que impactam diretamente na sua qualidade de vida e bem-estar, então se por um lado temos o aumento da expectativa de vida das mulheres, por outro, temos grandes desafios na conquista de mais qualidade de vida nesses anos de vida.



Fonte: IBG/Censo:2022

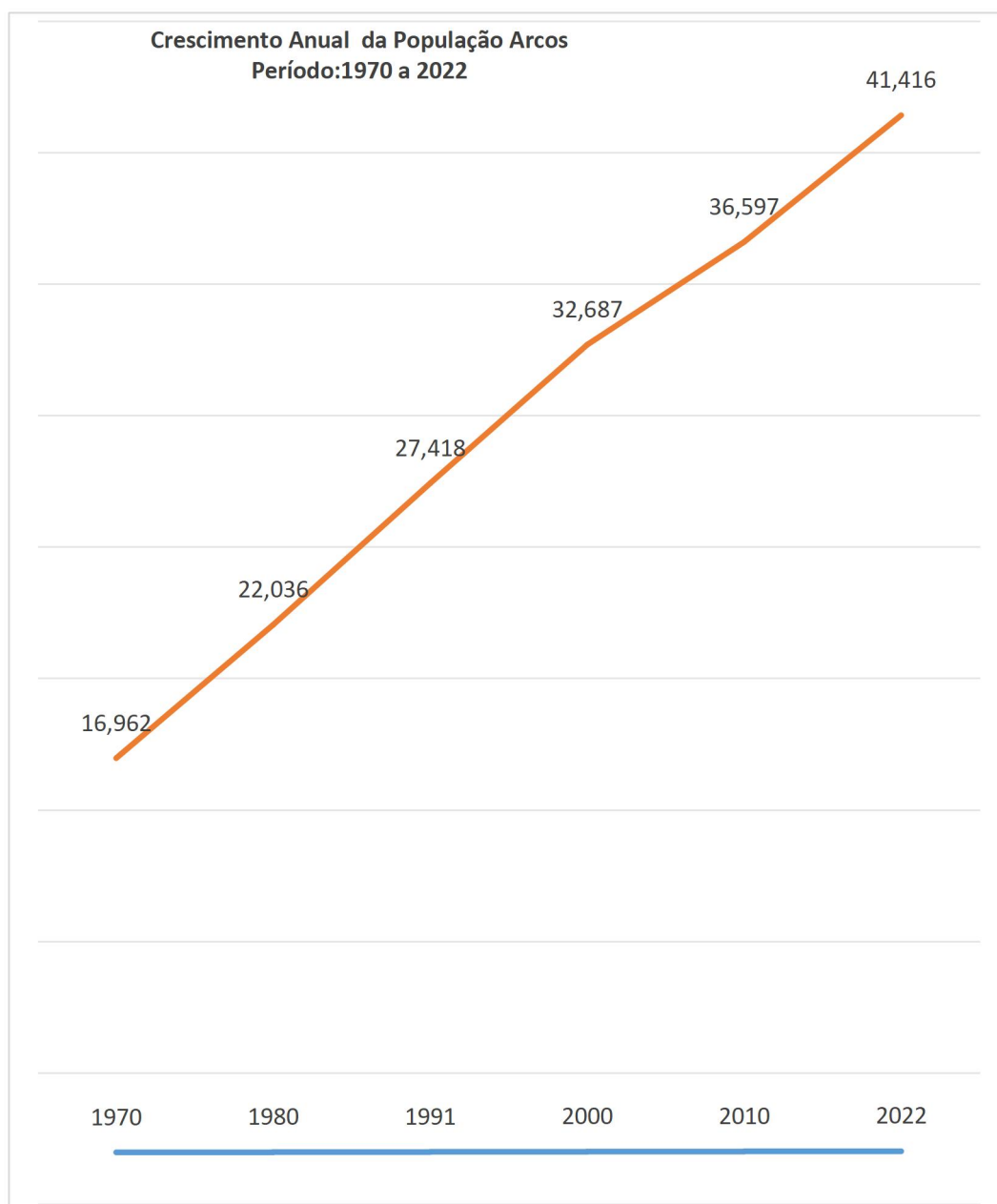
Conforme a transição demográfica vai ocorrendo, a pirâmide etária vai se transformando, passando a ter um formato cujo centro é tão largo quanto a base.

Essa mudança se deve ao aumento da expectativa de vida, elevando dessa forma, a população adulta e idosa. Esse cenário apresentado pelo município de Arcos é compatível com as cidades e países em desenvolvimento, que conseqüentemente caminham para um progressivo envelhecimento da populacional.

Considerando que o envelhecimento da população brasileira vem acontecendo de forma mais rápida em comparação a outros países e a taxa de fecundidade também tem diminuído nas últimas décadas e que o município de Arcos/MG faz parte da região com tendência de envelhecimento populacional, a análise do comportamento de grupos etários com características e necessidades similares é crucial para o planejamento e intervenções das políticas públicas, pois, permite que as ações governamentais sejam direcionadas e específicas conforme a necessidade de cada grupo.

Essa análise possibilita a identificação de desafios e prioridades, como o envelhecimento populacional e o desenvolvimento infantil, adaptando as políticas para promover o bem-estar e a inclusão de todos.

A Taxa de crescimento anual da população de Arcos/MG entre os anos de 1970 a 2022 foi de **1,04 %**,(IBGE,2022).



Fonte:IBGE - Censo 2022.

1.3 Educação

A educação é um indicador muito importante e está ligada diretamente à saúde da população, ela funciona como alicerce, uma vez que, quanto maior o nível de escolaridade melhores as condições de saúde.

A educação tem uma influencia direta na capacidade das pessoas em tomar decisões assertivas, e no empoderamento sobre sua saúde ao adotar estilos de vida saudáveis, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida. Já a falta de educação pode dificultar o acesso aos cuidados básicos com a saúde gerando mais riscos e desigualdades.

Conforme dados do IBGE, em 2022, no município de Arcos/MG, a taxa de alfabetização foi de 96,66% e os não alfabetizados 3,34% da população. A faixa etária com maior alfabetização está entre as pessoas de 15 a 24 anos e as mulheres encontram-se no grupo da maioria de alfabetizados e com maior nível de escolaridade.

No ano de 2023 o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública foi sete e cinco para os anos finais.

O número médio de anos de estudo foi de 9,7 anos e as pessoas sem instrução ou com nível fundamental incompleto: 32,46 %, já o número de pessoas com nível superior completo foi de 15,73 %

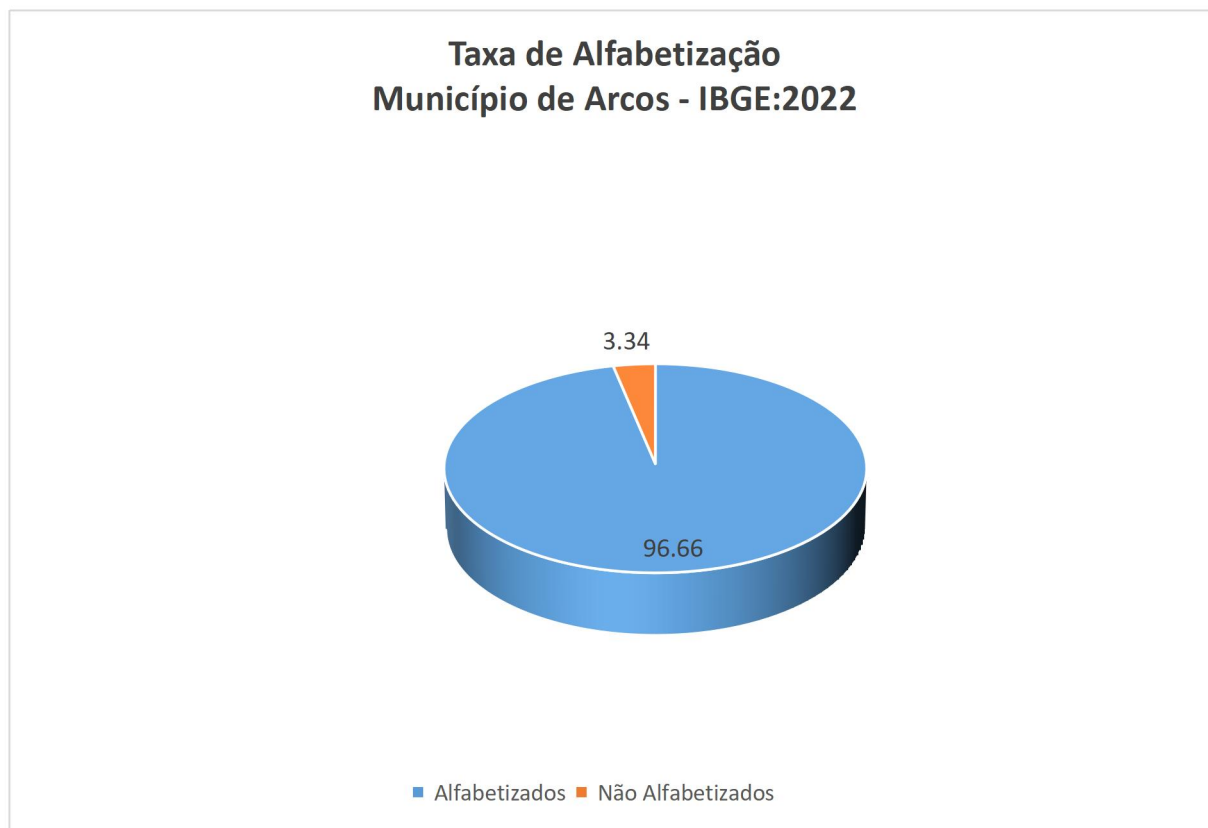
Em 2024 o município de Arcos contava com 28 escolas, sendo 14 municipais, 6 estaduais, 1 federal e 7 privadas. Nesse universo 19 escolas são de ensino fundamental e 08 escolas de ensino médio.

Nas escolas municipais, 600 crianças estavam matriculadas na creche, 787 na pré escola, onde 2.018 estavam matriculadas nos anos iniciais, 47 matrículas nos anos finais e 166 matrículas na educação especial.

As intervenções públicas na saúde da população visa atender às demandas de saúde, considerando o estabelecimento de vínculos através de ações realizadas nas escolas, onde a troca de saberes, potencialidades e experiências fortalece os atores e os serviços públicos envolvidos.

Assim sendo, considerando a educação como um fator determinante para a saúde a intersetorialidade com a educação precisa acontecer de forma contínua e articulada para integrar políticas públicas com efeitos mais

significativos na qualidade de vida da população e na transformação social.



Fonte:IBGE 2022.

1.4 Perfil Socioeconômico

A saúde é um fator intrínseco ao desenvolvimento social e econômico, sendo ao mesmo tempo um determinante, uma medida e um resultado do progresso. A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve o bem-estar como um estado de equilíbrio entre os aspectos mentais, emocionais, sociais e materiais da vida.

Considerando a equidade como um princípio de justiça social aos grupos populacionais vulneráveis e mais suscetíveis ao adoecimento físico e mental, o perfil socioeconômico apresenta como uma ferramenta que possibilita o setor da saúde propor estratégias de intervenção apropriadas, com o intuito de mitigar os efeitos nocivos à saúde permitindo um planejamento estratégico que beneficia a população de forma a atender principais prioridades.

No ano de 2023 O Produto Interno Bruto - PIB per capita do município de Arcos MG foi de R\$ 73.837,00 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010 foi de 0,749.

Com a economia baseada na mineração, indústria, comércio, serviços e agricultura. A cidade tem grandes reservas de calcário o que atrai a instalação de várias empresas de grande porte para exploração e mineração de calcário, das quais são responsáveis pela grande mão de obra gerada na cidade, tornando a indústria um dos principais motores da economia.

No ano de 2022 o salário médio mensal dos trabalhadores formais foi de 2,1 salários mínimos e a população ocupada era de 39,25%, enquanto 30% da população possuía rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário.

O bem-estar econômico pode ser alcançado pelos indivíduos, através de políticas públicas que garantam a capacidade de desenvolver conhecimento, habilidades e oportunidades de geração de renda que proporcionam recursos econômicos seguros.

A segurança financeira inclui a capacidade de indivíduos e famílias em atender às suas necessidades básicas como: alimentação, moradia, saúde, transporte e educação.

A queda do poder aquisitivo proveniente do desemprego, da ausência das transferências sociais ou da precarização das relações de trabalho tem um impacto significativo na saúde física e mental do indivíduo, criando um ciclo vicioso de estresse e dificuldades.

A falta de recursos financeiros pode levar a perda da moradia, redução do consumo de alimentos e medicamentos, desencadeando ou agravando problemas de saúde mental e física.

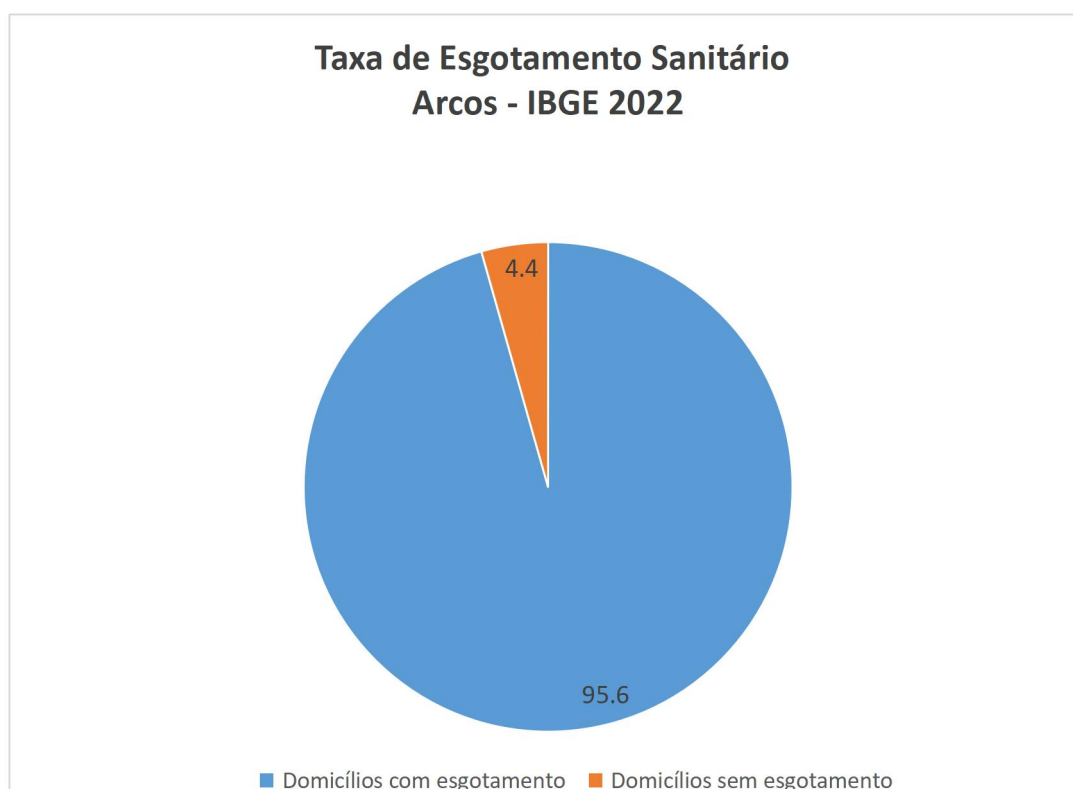
A queda do consumo de bens e serviços, a redução de investimentos nas políticas de promoção, prevenção e atenção em saúde aumenta a exposição do indivíduo aos fatores de risco, piorando os indicadores básicos de saúde e o bem-estar geral.

1.5 Meio Ambiente

De acordo com o Ministério da Saúde a saúde ambiental pode ser definida como um conjunto de ações voltadas para identificar e monitorar mudanças nos fatores ambientais que afetam a saúde humana.

O saneamento básico no Brasil ainda é um grande desafio, com impactos significativos na área da saúde. O acesso aos serviços de saneamento, como abastecimento com água tratada, coleta e tratamento de esgoto, proporciona a redução de doenças por veiculação hídrica, proporcionando um ambiente mais saudável para as pessoas.

O município de Arcos/MG apresenta 95,6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 93,8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 10,9% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada com a presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio.



Fonte: IBGE/2022

A economia do município de Arcos MG é baseada na mineração das grandes reservas de calcário, atividade considerada sinônimo de grande desenvolvimento socioeconômico. Porém, a atividade mineradora apresenta um alto potencial de impactos ambientais, como a poluição dos

recursos hídricos e do solo, a perda de biodiversidade na fauna e na flora, bem como impactos na saúde do trabalhador e nas comunidades próximas às áreas de extração, como aumento de doenças respiratórias e dermatológicas, além de problemas de saúde mental.

Nos últimos anos a cidade de Arcos/MG sofreu um intenso processo de industrialização e urbanização, acarretando modificações inevitáveis no meio ambiente e gerando um desequilíbrio no ecossistema como a diminuição de predadores naturais e ambientes propícios para o agrava das arboviroses locais.

As Arboviroses são consideradas um dos principais problemas de saúde pública e o ambiente desempenha um papel crucial na proliferação dessas doenças em municípios endêmicos. A organização do espaço urbano, a gestão de resíduos, o saneamento básico e a presença de potenciais criadouros são fatores determinantes para a incidência da doença.

A prevenção dessas doença, cujo controle se faz através do meio ambiente e do modo de vida das pessoas envolve ações em diversas frentes, desde a preservação do meio ambiente até a conscientização da população e a implementação de ações contínuas, eficazes e duradouras.

O ambiente reflete as escolhas do modo de vida e o desenvolvimento econômico de uma população, afetando diretamente as relações ecológicas entre todos os seres vivos, dessa forma é essencial a formulação de políticas públicas que mantenha o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das pessoas.

Gestão e Organização dos Serviços de Saúde

2.1 Gestão e Organização dos Serviços de Saúde

A partir do ano de 2024, o município de Arcos assumiu a gestão plena dos serviços de saúde, no âmbito do SUS. Com a descentralização o município assumiu o comando pleno dos recursos financeiros e serviços, aumentando assim, a responsabilidade e a autonomia local na regulação e organização da rede de saúde.

A organização dos serviços de saúde no âmbito do SUS, atribui a diretriz da Regionalização um papel de elemento central na estruturação dos serviços de saúde.

A Regionalização surge como expressão de compartilhamento solidário de responsabilidades da administração pública no intuito de reduzir as desigualdades e garantir a promoção de equidade social.

O Plano Diretor de Regionalização - PDR é um instrumento de planejamento de gestão que na área da saúde objetiva direcionar a descentralização com vistas à promoção de maior e mais adequada acessibilidade dos usuários considerados os princípios da integralidade, equidade e economia de escala.

O propósito de um Plano Diretor de Regionalização (PDR) da saúde é constituir um dos pilares para estruturação e descentralização dos sistemas de co-gestão e organização dos serviços de saúde em redes, tendo em vista o direcionamento equitativo da implementação das políticas públicas.

O PDR é, portanto, um instrumento de planejamento em saúde ao estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial, (PDR-MG,2019).

A Regionalização da Saúde é um princípio organizativo do Sistema Único de Saúde (SUS) para a oferta de recursos e serviços de saúde, visando organizá-los de maneira hierarquizada e integrada, considerando as características demográficas, epidemiológicas e socioeconômicas de cada região.

A foto ilustra a macro região oeste de saúde e as divisões das micro regiões de saúde quando o município de Arcos ainda pertencia a micro região de saúde de Lagoa da Prata.



27

3 Análise da Situação de Saúde

3.1 Análise da Situação de Saúde

A análise da situação de saúde é um processo analítico-sintético que permite caracterizar, medir e explicar o perfil de saúde-doença de uma população através do alisamento de séries temporais que expressam a distribuição e o comportamento das doenças e agravos em saúde.

A análise é construída a partir dos principais indicadores produzidos pelos sistemas de informações em saúde, retratando a prevalência, as sazonalidades, estimativas e tendências, bem como os principais determinantes e condicionantes desse processo.

O aperfeiçoamento da produção de informações, conhecimentos e evidências possibilita antever futuros cenários da ocorrência de doenças e agravos na população e os principais fatores desencadeantes.

Esse conhecimento é útil para orientar as ações em saúde coletiva e uma prática relevante para os diversos níveis de decisão nos serviço de saúde, comunidade, município, estado e federação.

A utilização das informações e do conhecimento produzido, são norteadores nas atividades de planejamento, definição de prioridades, alocação de recursos, avaliação dos programas implementados, promovendo assim, a formulação de políticas e estratégias mais eficazes para responder às necessidades de saúde da população, e uma gestão do SUS cada vez mais qualificada.

A análise de situação de saúde assume, ainda, um valor inestimável como instrumento de suporte ao controle social à medida que amplia o acesso às informações e aos conhecimentos através da informação à comunidade e aos profissionais de saúde.

Ademais, é um documento legítimo para os gestores de saúde, pois, ao incorpora a avaliação da situação de saúde como ferramenta fundamental de trabalho, usando as informações epidemiológicas como matéria-prima para a gestão, torna explícito o comprometimento com a melhoria da qualidade do sistema de saúde.

3.2 Natalidade

A Natalidade é o número proporcional dos nascimentos que ocorrem numa população e num determinado período. Para a demografia, a taxa de natalidade é uma medida de quantificação da fecundidade.

Conforme a serie histórica de natalidade entre os anos de 2014 a 2024 a média de número de nascidos vivos por residência da mãe no município de Arcos foi de 477 nascimento ao ano.

A Natalidade no Brasil vem diminuindo com o decorrer dos anos e o município de Arcos/MG acompanha a mesma tendência, o número de nascimentos tem diminuído consecutivamente e no ano de 2024, o município registou o menor número de nascimentos do período, demonstrando uma característica prevalente das cidades em desenvolvimento e os novos arranjos familiares.

Unidade Federaçã o	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ARCOS	471	507	457	498	480	522	497	480	485	438	412

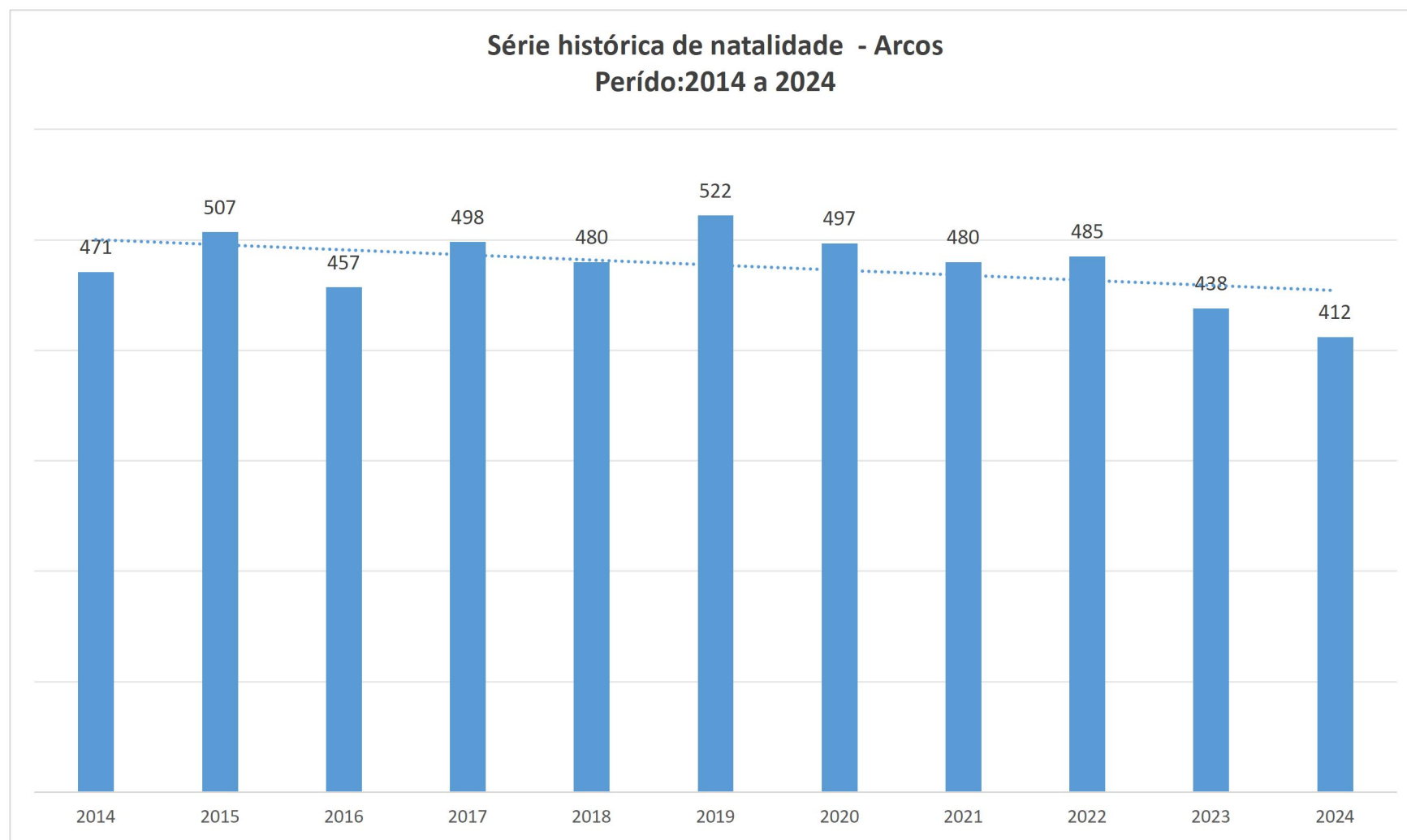
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC).

O menor número de nascimentos está relacionado a diversos fatores como: as alterações nos valores culturais e ideológicos que reduziram o tamanho ideal da família.

Os novos arranjos familiares, o avanço da urbanização que impacta diretamente a rotina das famílias, o elevando custo de vida que resultam em transformações de ordem socioeconômica, são fatores que influenciam a decisões sobre ter filhos, na atual sociedade.

As melhorias na saúde, o maior conhecimento e oferta de métodos contraceptivos, o aumento da escolaridade feminina, assim como a presença cada vez maior da mulher no mercado de trabalho também estão associados à postergação da maternidade.

Todos esses determinantes e condicionantes convertem-se no fenômeno global característico da transição demográfica no países emergentes ,no qual desenham um novo cenário epidemiológico.



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

O pré-natal é o primeiro passo para garantir uma gestão gestação segura no qual possibilita o monitoramento da saúde da gestante e o desenvolvimento do bebê.

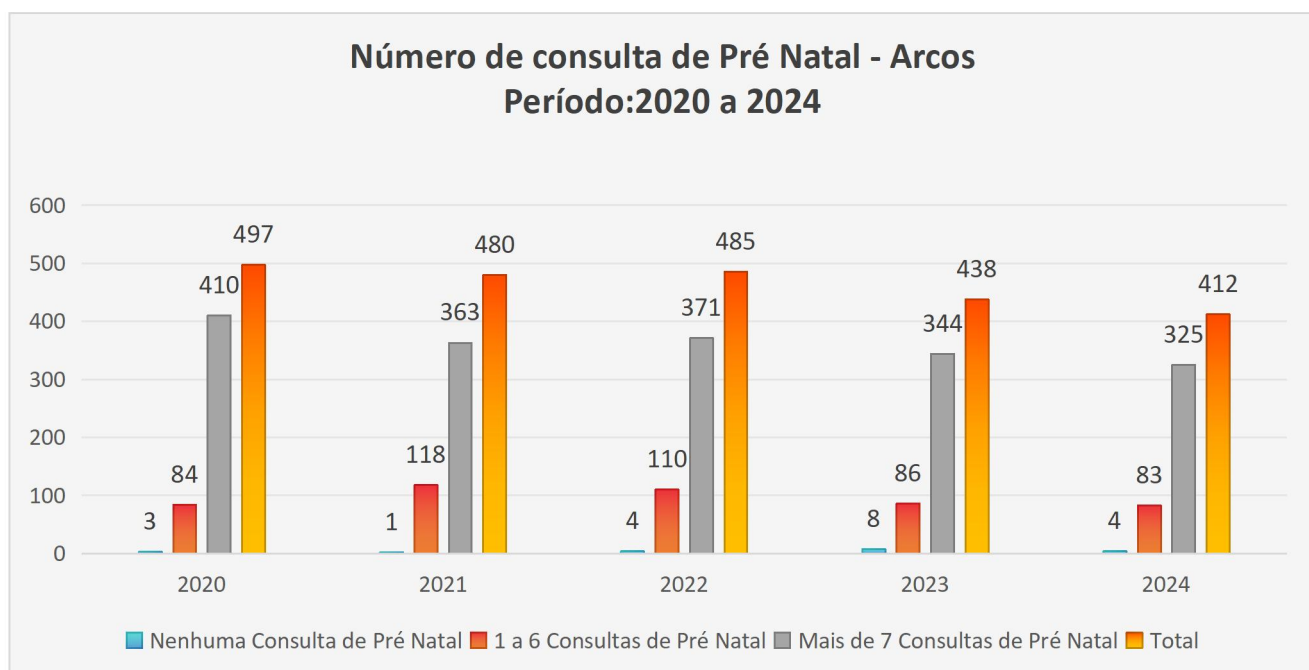
De acordo com a Organização Mundial da Saúde o maior número de consultas de pré-natal está associado a uma redução da mortalidade perinatal bem como a um aumento da satisfação da gestante.

Embora o Ministério da Saúde considere um mínimo de 6 consultas de pré-natal, o município do Arcos manteve o parâmetro de no mínimo 7 consultas, pois esse é o número estipulado nos indicadores do contrato de gestão.

Nascidos Vivos Segundo Número de Consultas de Pré- Natal Município de Arcos Período:2020 a 2024					
Número de Consultas de Pré Natal	2020	2021	2022	2023	2024
Nenhuma Consulta de Pré Natal	3	1	4	8	4
1 a 6 Consultas de Pré Natal	84	118	110	86	83
+ de 7 Consultas de Pré Natal	410	363	371	344	325
Total	497	480	485	438	412

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

No município de Arcos, no período de 2020 a 2024, conforme os registros apontados no SINASC, 77% das gestante realizaram mais de sete consultas de Pré Natal.



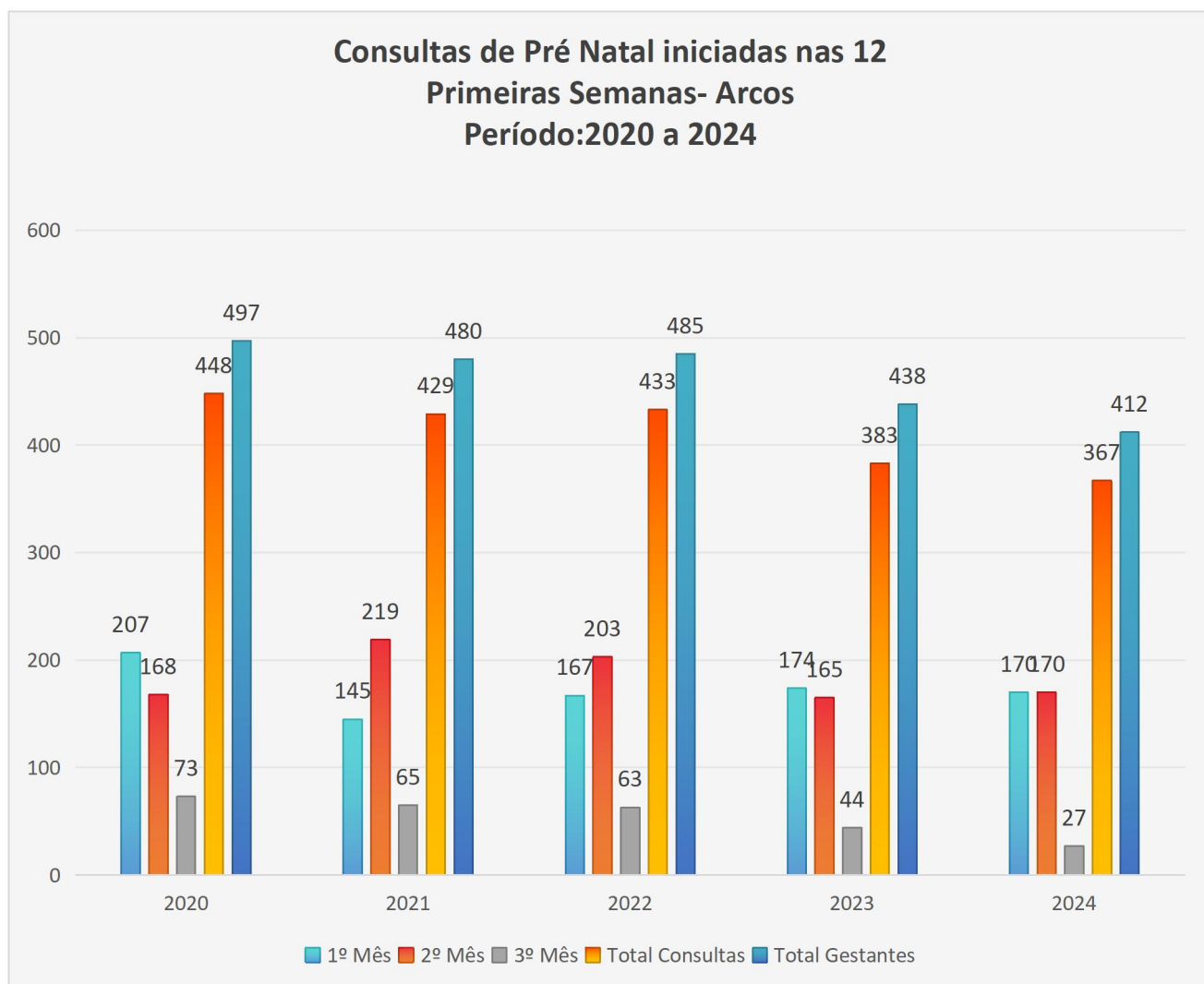
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

A captação precoce da gestante é uma iniciativa crucial para a saúde da mãe e do bebê, o ideal é que o pré-natal inicie até a 12ª semana pois, nesse período é possível identificar condições de risco, como doenças maternas preexistentes, alterações genéticos no bebê e complicações da gravidez. A detecção precoce permite a adoção de medidas preventivas e intervenções necessárias para garantir uma gestação saudável.

Gestantes que Iniciaram o Pré Natal nas 12 Primeiras Semanas de Gestação Município de Arcos Período:2020 a 2024					
Consultas de Pré Natal iniciadas nas 12 primeiras semanas	2020	2021	2022	2023	2024
1º Mês	207	145	167	174	170
2º Mês	168	219	203	165	170
3º Mês	73	65	63	44	27
Total	448	429	433	383	367
Total Geral de Gestantes	497	480	485	438	412

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

A média de gestante que iniciaram o acompanhamento nas 12 primeiras semanas da gestação no período de 2020 a 2024 foi de 89%.



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

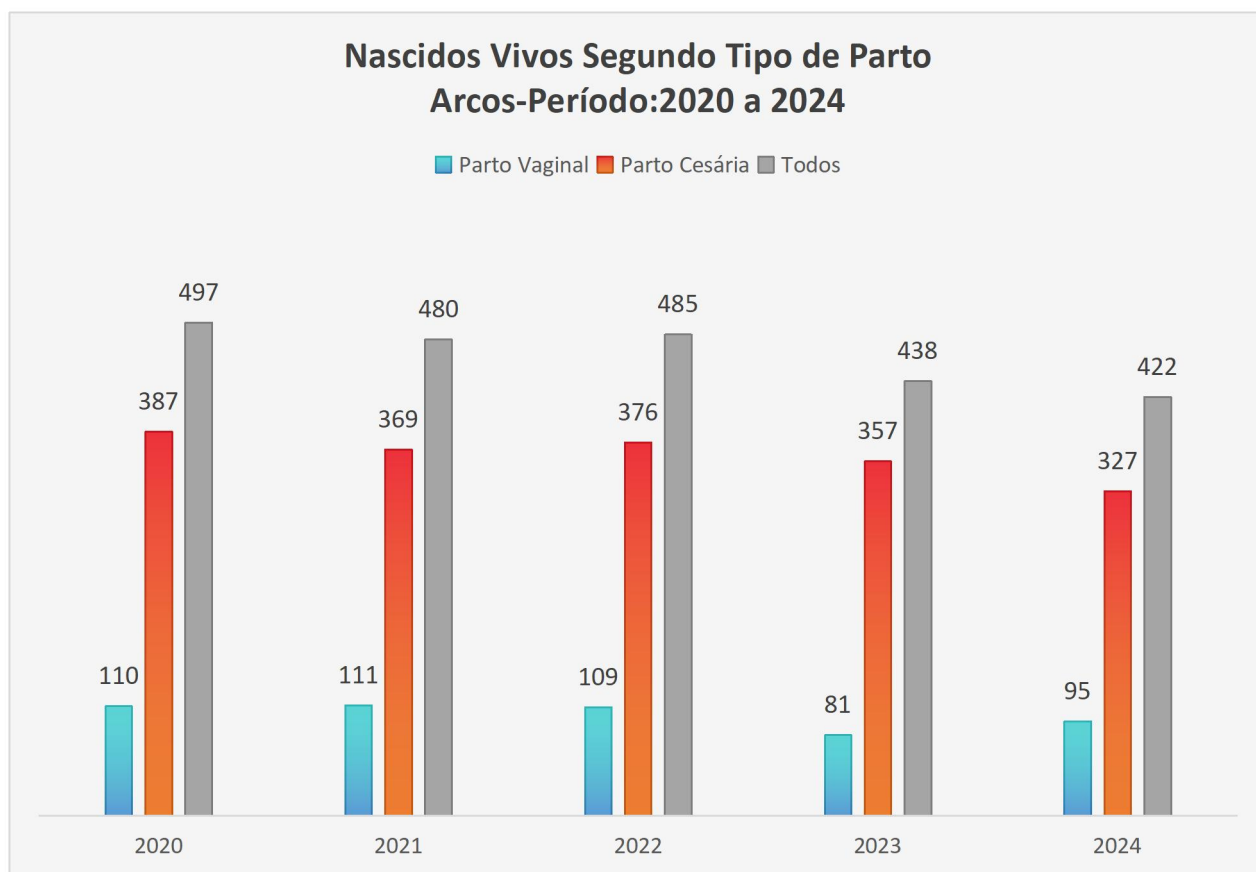
Nas últimas décadas, houve um aumento expressivo nas taxas de partos cesáreos em várias regiões do mundo, consolidando-se como um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns globalmente

As causas para o aumento das taxas de cesáreas ainda não são completamente compreendidas uma vez que as motivações para a realização do procedimento são múltiplas, fruto de uma combinação de fatores culturais, estruturais e médicos.

Nascidos Vivos Segundo Tipo de Parto Município de Arcos Período:2020 a 2024					
Tipo de Parto	2020	2021	2022	2023	2024
Parto Vaginal	110	111	109	81	95
Cesária	387	369	376	357	327
Branco/Ignorado	0	0	0	0	0
Todos	497	480	485	438	422

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

No período de 2020 a 2024 a taxa de partos por cesária no município de Arcos representou cerca de 78% do total de parto em relação ao parto normal.



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

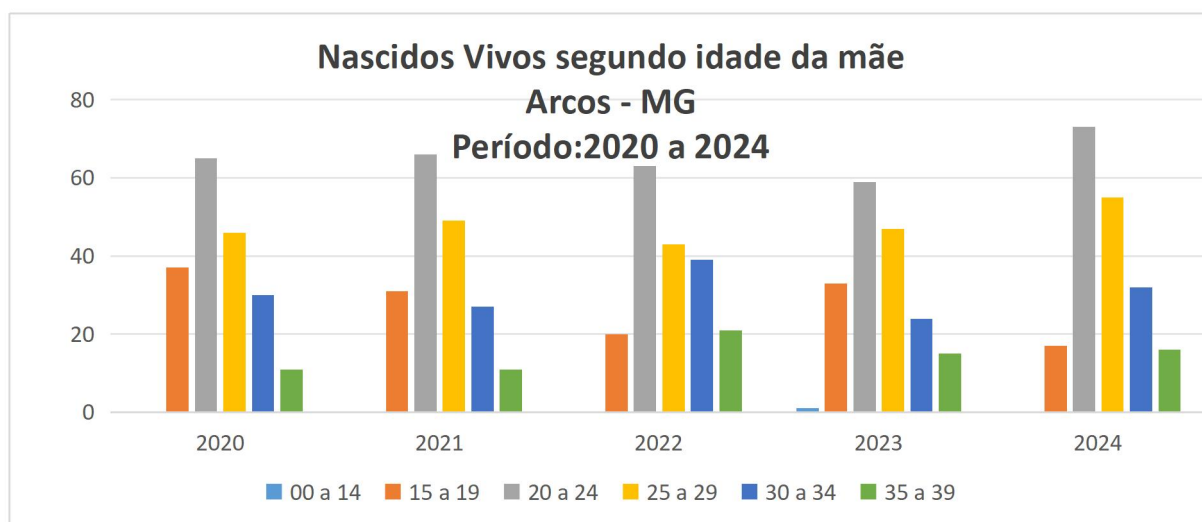
Conforme o Censo 2022/2024 houve um Aumento da Idade Média das gestantes no Brasil passou de 26,3 anos em 2000 para 28,1 anos em 2022.

O estudo apontou também o crescimento da maternidade tardia, onde a gravidez acontece após os 35 anos, muitas vezes impulsionada por escolhas profissionais, planejamento familiar e tecnologias de reprodução assistida.

Nascidos Vivos Segundo Idade da Mãe Município de Arcos Período:2020 a 2024					
Faixa Etária	2020	2021	2022	2023	2024
00 a 14	0	0	0	1	0
15 a 19	41	34	25	35	19
20 a 24	99	109	103	89	102
25 a 29	132	122	123	114	117
30 a 34	123	108	121	101	103
35 a 39	77	75	92	76	56
40 a +	25	32	21	22	25
Branco/Ignorado	0	0	0	0	0
Todos	497	480	485	438	422

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

De acordo com dados do SINASC do período de 2020 a 2024 houve uma queda na gravidez na adolescência no último ano avaliado. E o maior contingente de gestantes estão concentradas na faixa etária de 25 a 34 anos.



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

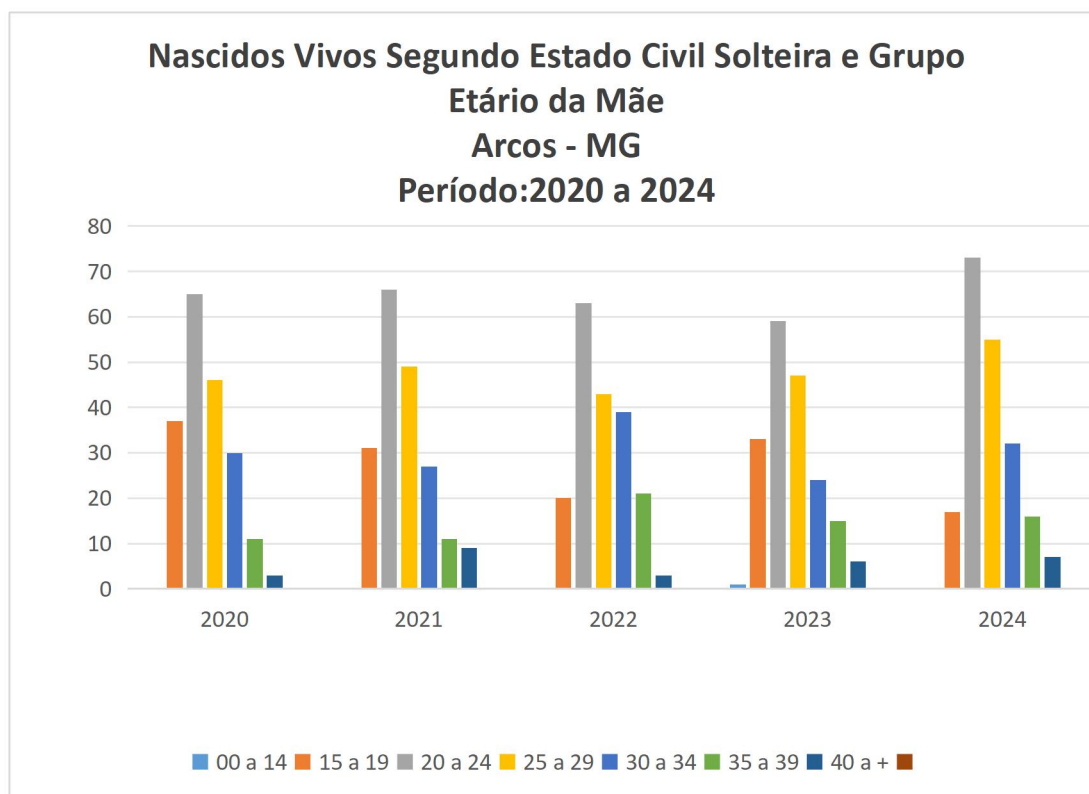
A maternidade solo é uma realidade crescente no Brasil, embora a definição solteira remete ao estado civil, mais do que a ausência de um cônjuge, essa condição enfatiza a carga de responsabilidades das mães que cuidam sozinhas de seus filhos.

A maioria dessas mães enfrenta dificuldades para conciliar trabalho e o cuidado com os filhos devido a ausência de rede de apoio, precisando se desdobrar para dar suporte afetivo, emocional e financeiro aos filhos. Os desafios são inúmeros gerando uma pressão constante ao ser a única responsável pela família afetando diretamente na qualidade de vida dessas mães e de seus filhos .

Nascidos Vivos Segundo Estado Civil Solteira e Grupo Etário da Mãe Município de Arcos Período:2020 a 2024					
Faixa Etária	2020	2021	2022	2023	2024
00 a 14	0	0	0	1	0
15 a 19	37	31	20	33	17
20 a 24	65	66	63	59	73
25 a 29	46	49	43	47	55
30 a 34	30	27	39	24	32
35 a 39	11	11	21	15	16
40 a +	3	9	3	6	7
Todos	192	193	189	185	200

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

Esse perfil de mães tem crescido exponencialmente e o município de Arcos vem registrando um aumento significativo nos últimos anos, salientando que 50% das mães que deram a luz em 2024 eram solteiras, conforme pode ser observado nos dados apresentados.



Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

Assim sendo, a maternidade solo é uma realidade desafiadora que precisa ser enfrentada com um olhar atento às condições de vida dessas mulheres, através de medidas que amenizem as vulnerabilidades tais como: admissão precoce ao pré-natal, acolhimento emocional e psicológico, acesso às creches para as crianças como forma de viabilizar oportunidades que ajudem as mães a conquistarem a autonomia financeira que são essenciais para transformar a realidade dessas mulheres e garantir uma vida digna para si e para seus filhos.

3.3 Morbimortalidade

A análise de dados de morbidade e mortalidade de uma população reflete a forma como esta população vive, as suas condições de saúde e os riscos dos quais estão expostas. Demonstra também a organização dos serviços de saúde, as condições econômicas, educacionais e os aspectos culturais prevalentes naquela população.

O resultado de tal análise fornecerá indicadores que subsidiarão parâmetros para a criação e planejamento de estratégias para a formulação de políticas de saúde pertinentes a realidade local e que causem impacto positivo na qualidade de vida dos indivíduos. O perfil epidemiológico ajuda a identificar padrões e criar medidas de saúde pública, sendo crucial monitorar as taxas de mortalidade para intervir eficazmente em cada grupo de risco.

A análise do perfil de mortalidade e morbidade hospitalar demonstraram uma visão geral das tendências de mortalidade e morbidade no município de Arcos/MG entre os anos de 2020 e 2024, com potencial para utilização no direcionamento de esforços para iniciativas de prevenção e proteção da saúde frente aos agravos de maior impacto.

A mortalidade e a morbidade são indicadores epidemiológicos que fornecem informações importantes sobre a saúde de uma população e são utilizados para avaliar a eficácia das ações de saúde e a tomada de decisões em saúde pública.

3.3.1 Análise da Morbidade

A Análise da morbidade fornece informações para a gestão em saúde, permitindo a construção de indicadores e análises epidemiológicas que contribuem para a eficiência da gestão em saúde através dos registros de todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares no SUS

As informações relacionadas à morbidade são geradas no SIH - Sistema de Informação Hospitalar que é alimentado através de registros denominado Autorização de Internação Hospitalar (AIH) no qual registra todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares financiadas pelo SUS, além de produzir estatísticas e construir indicadores de saúde; permitir a análise e a avaliação dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS.

O perfil de internações do município de Arcos descritos ao longo de cinco anos, entre 2020 a 2024, demonstra as principais causas de morbidade hospitalar, destacando a presença das principais doenças e lesões prevalentes na população no período.

Nessa série histórica foram registradas 13.057 internações e um aumento de mais de 30% no número de internações no respectivo período.

Embora o número de internações, por gravidez, parto e puerpério é significativo, a análise vai contemplar os resultados que demonstram as tendências de adoecimento da população local, com vistas a iniciativas de prevenção e proteção da saúde frente aos agravos de maior impacto.

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	185	538	257	112	264
II. Neoplasias (tumores)	240	262	303	254	258
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	88	56	74	58	59

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	75	118	106	131	100
V. Transtornos mentais e comportamentais	16	16	9	8	10
VI. Doenças do sistema nervoso	9	21	36	76	89

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
VII. Doenças do olho e anexos	8	8	15	14	92
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	4	-	4	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	257	283	331	400	395

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
X. Doenças do aparelho respiratório	201	170	296	319	327
XI. Doenças do aparelho digestivo	184	154	295	345	360
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	17	27	31	27	37

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	34	36	28	82	62
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	155	145	218	309	288
XV. Gravidez parto e puerpério	222	188	180	132	155

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	27	40	29	36	34
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	5	6	12	11	8
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	46	51	46	40	46

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	217	192	255	285	295
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	122	126	123	159	182

Causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	2.108	2.441	2.644	2.802	3.062

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 13/08/2024.

Principais causas de internações por local de residência no município de Arcos.

Período:2020 a 2024 - Segundo Capítulo da CID-10.

Ano	I. Alguma s doenças infeccio sas e parasitár ias	IX. Doenças do aparelho circulatório	II. Neoplasias (tumores)	X. Doenças do aparelho respiratório	XI. Doenças do aparelho digestivo	XIV. Doenças do aparelho geniturinári o	XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	Total Geral de interna ções

2020	185	257	240	201	184	155	217	2.108
2021	538	283	262	170	154	145	192	2.441
2022	257	331	303	296	295	218	255	2.644
2023	112	400	254	319	345	309	285	2.802
2024	264	395	258	327	360	288	295	3.062

|Em 2020 a principal causa de internação foi relacionada as doenças do aparelho circulatório, seguida pelas neoplasias e na terceira posição as lesões por evenenamento ou consequência por causas externas e em quarto lugar as doenças do aparelho respiratório.

No ano de 2021 o registro de internações hospitalares foi atípico em decorrência da pandemia de COVID-19, o grande número de pessoas afetadas e as medidas de controle na transmissão da COVID-19 afetaram a organização e a rotina dos serviços de saúde.

Dessa forma com o advento da pandemia houve um aumento abrupto nas internações por doenças infecciosas, de forma que o maior contingente de internações hospitalares no ano de 2021 foi relacionado as doenças infecciosas, provenientes da COVID-19.

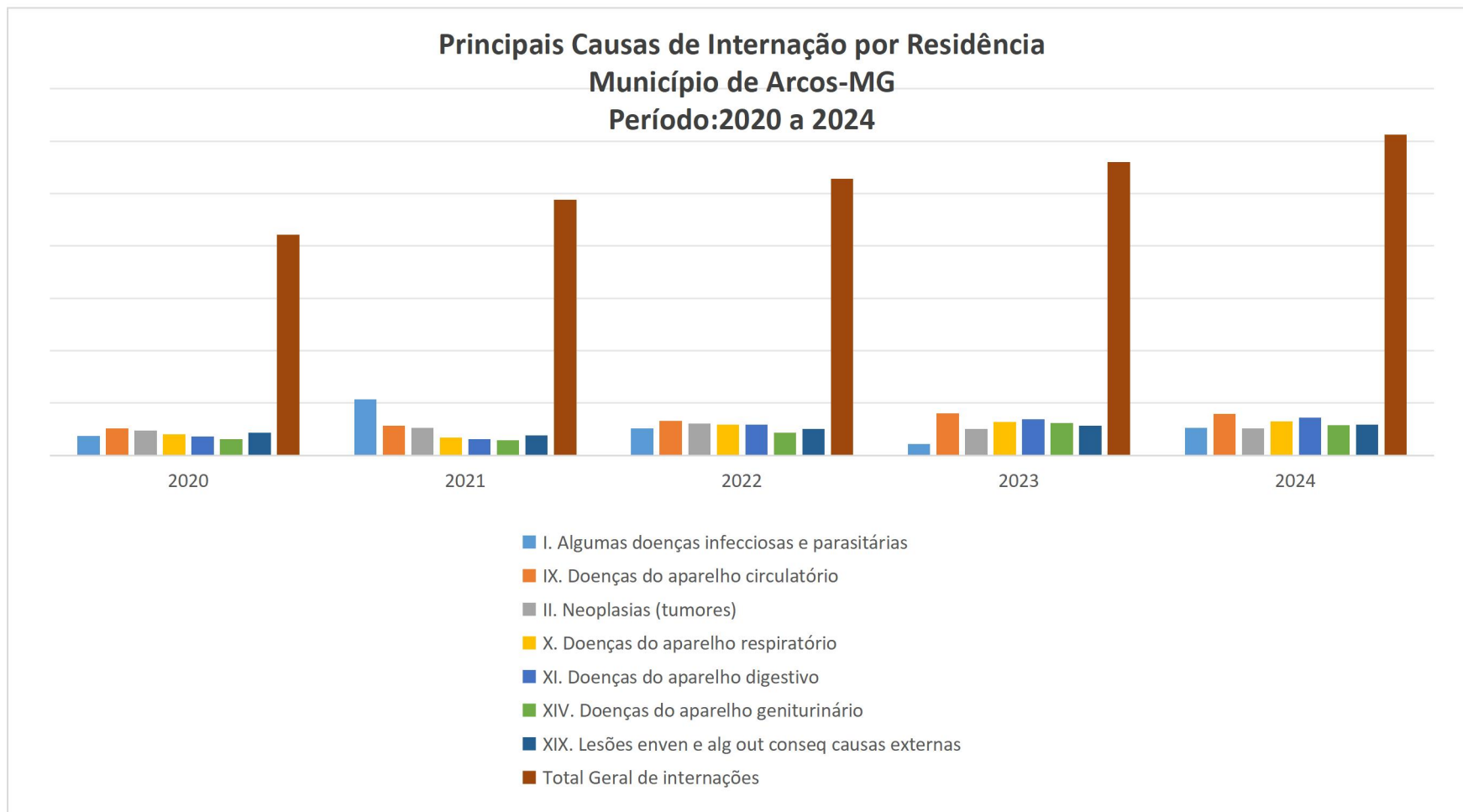
As doenças do aparelho circulatório ocuparam o segundo lugar nesse cenário de pandemia. O número de internações pelas doenças cardiovascular não reduziu com relação aos anos anteriores, pelo contrário, aumentou.

As internações decorrentes das neoplasias configuraram como a terceira causa de morbidade hospitalar no ano de 2021 e as lesões por evenenamento ou consequência por causas externas ficou no quarto lugar.

Em 2022 as doenças do aparelho circulatório voltou a liderar como a principal causa de internação hospitalar, no município de Arcos, seguida pelas das neoplasias, em terceiro lugar as doenças respiratórias e em quarto as doenças infecciosas e parasitárias, ainda como reflexo da pandemia.

Nos anos de 2023 e 2024 as doenças do aparelho circulatório prevaleceram como primeira causa de morbidade hospitalar no município, em segundo lugar as doenças respiratórias, a terceira e quarta causa de internação em 2023 foram relacionadas as doenças do aparelho digestivo e quarto lugar as lesões por evenenamento ou consequência de causas externas.

Já no ano de 2024 as posições se inverteram e as lesões por evenenamento ou consequência por causas externas ficaram em terceiro e as doenças do aparelho digestivo em quarto lugar.



Os dados sobre morbidades no município de Arcos/MG correspondente aos anos de 2020 a 2024, permite uma avaliação precisa da realidade da saúde local com informações e evidências importantes para subsidiar o processo de planejamento de ações e intervenções mais efetivas.

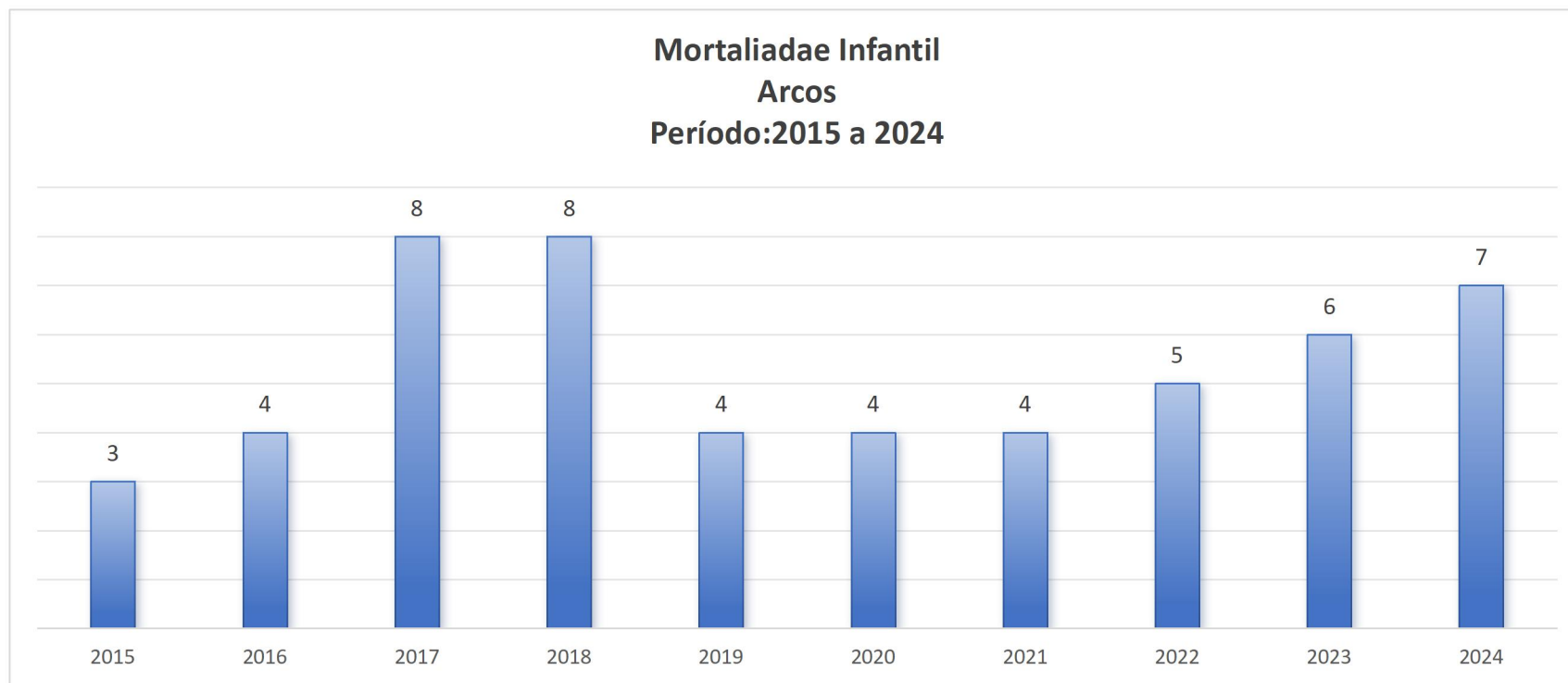
Conforme as informações do SIH, nos anos seguintes o número de internações por doenças do aparelho circulatório foi aumentado gradativamente, permanecendo como a principal causa de morbidade hospitalar.

3.2 Análise de Mortalidade

A mortalidade refere-se à ocorrência de óbitos em um determinado período de tempo e espaço. Esses dados são essenciais para avaliar a gravidade dos agravos em saúde, em particular de doenças de maior letalidade, e avanço na sociedade. A análise da mortalidade permite identificar as principais causas de óbito, subsidiando o direcionamento de recursos e a implementação de ações preventivas e de tratamento mais eficazes.

A taxa de mortalidade infantil reflete a forma como um país ou região se encontra em termos de condições de saúde, desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida, sendo um indicador crucial para avaliar a eficácia das políticas públicas em diversas áreas, como saúde, educação, saneamento, geração e distribuição de renda.

Níveis elevados de mortalidade infantil geralmente indicam baixos índices de saúde e desenvolvimento, enquanto taxas reduzidas podem sinalizar melhores condições de infraestrutura, saneamento, acesso à saúde e programas sociais eficazes, como os de pré-natal e assistência à infância.



Fonte: SIM/MS 2025.

O número absoluto de óbitos não fetais de menores de 1 ano ocorridos no município de Arcos na série histórica dos anos de 2015 a 2024 registrou uma média de 5 óbitos no período.

Com relação as causas de óbitos no município de Arcos a análise da série temporal entre os anos de 2020 a 2024 traça um perfil epidemiológico que permite identificar o quantitativo de óbitos em cada ano e as principais causas de mortalidade neste período.

A prevalência nas causas de mortalidade é variável conforme o grupo etário e demográfico, mas as doenças cardiovasculares configuram como a principal causa de óbito no geral, seguidas das neoplasias e as causas externas, como acidentes de transporte e agressões prevalecem na mortalidade entre os jovens, enquanto as quedas se destacam como um fator de risco significativo para o óbito em idosos.

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas Município de Arcos Período:2020 a 2024					
Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	27	151	37	16	16
II. Neoplasias (tumores)	57	61	56	60	62

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	1	2	2	1	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	15	15	26	25	16
V. Transtornos mentais e comportamentais	3	6	1	2	5

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
VI. Doenças do sistema nervoso	10	9	16	20	5
IX. Doenças do aparelho circulatório	63	71	71	65	83
X. Doenças do aparelho respiratório	28	23	31	36	54

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XI. Doenças do aparelho digestivo	14	21	17	17	37
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	-	-	-	3

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	2	-	4	5	3
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	11	13	11	16	21

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XV. Gravidez parto e puerpério	-	1	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	3	4	4	3	6

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	1	3	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	16	20	20	21	29

Mortalidade de Residentes, Segundo Grupos de Causas

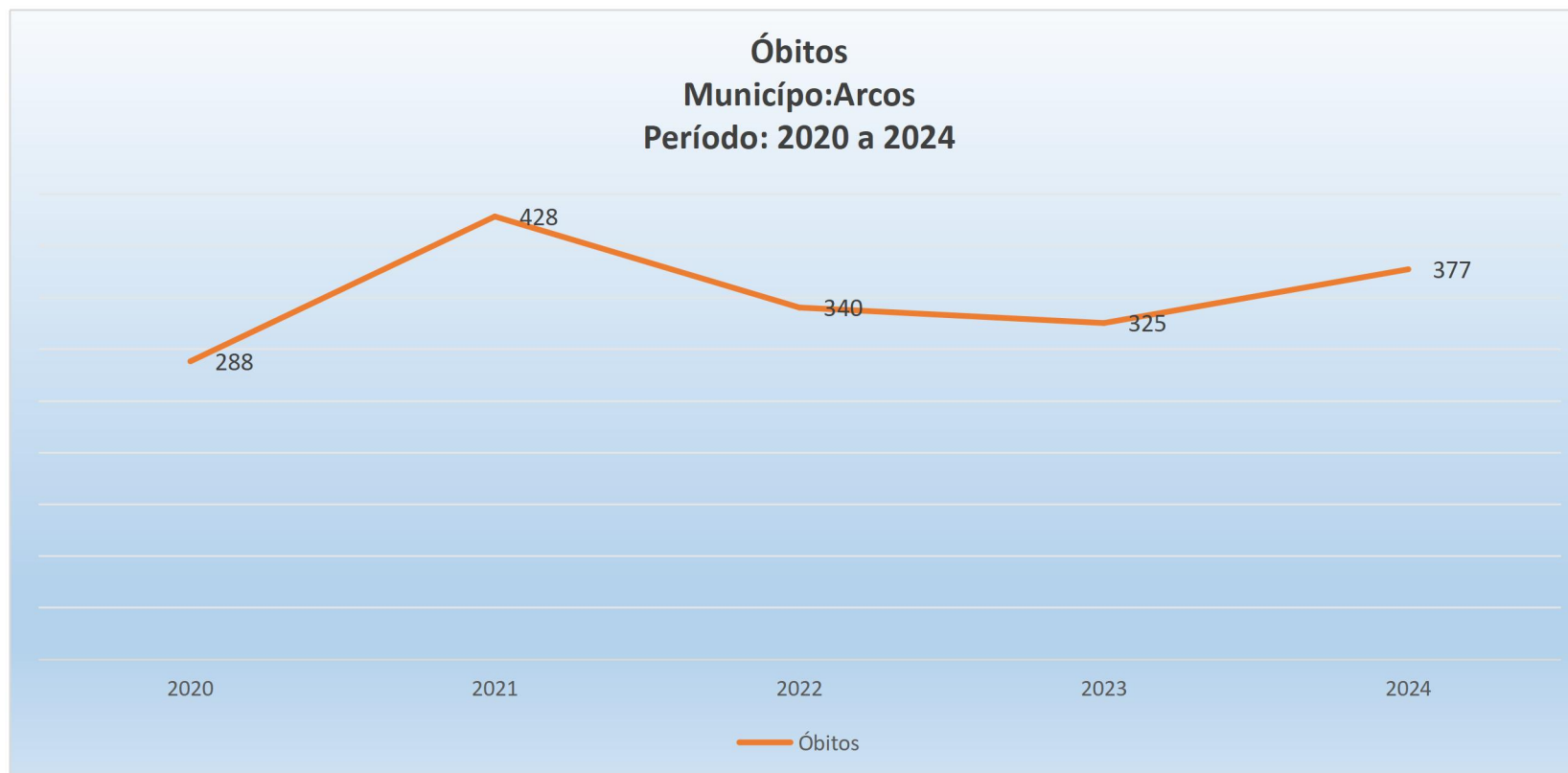
Município de Arcos

Período:2020 a 2024

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	37	31	43	35	34
Total	288	428	340	325	377

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: 09/09/2025.



Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025

No recorte da série histórica dos anos de 2020 a 2024 o ano de 2021 registrou o maior número de óbitos no município de Arcos e também no Brasil, devido ao agravamento da pandemia de COVID-19, consolidando o ano de 2021 como o pico crítico de mortes.

A prevalência nas causas de mortalidade é variável conforme o grupo etário e demográfico, mas as doenças cardiovasculares configuram como a principal causa de óbito no geral, seguidas das neoplasias e as causas externas, como acidentes de transporte e agressões prevalecem na mortalidade entre os jovens, enquanto as quedas se destacam como um fator de risco significativo para o óbito em idosos.

A Análise da Série Temporal entre os anos de 2020 a 2024 traça um perfil epidemiológico que permite identificar as principais causas de mortalidade no município de Arcos. Com exceção do ano de 2021, no contexto da epidemia as doenças infecciosas atingiram o patamar como a primeira causa de óbito. Nos demais períodos a prevalência de mortalidade geral destaca as doenças cardiovasculares como a principal causa de óbito, seguidas das neoplasias e as causas externas.

Principais Causas de Óbitos por Residência
Município de Arcos
Período:2020 a 2024

Ano	Algumas doenças infecciosa s e parasitária s	Doenças do aparelho circulatório	Neoplasias (tumores)	Doenças do aparelho respiratório	Doenças do aparelho digestivo	Doenças do aparelho geniturinário	Lesões enven e alg out conseq causas externas	Total Geral de Óbitos no ano corresp ondente
2020	27	63	57	28	14	11	37	288
2021	151	71	61	23	21	13	31	428
2022	37	71	56	31	17	11	43	340

Principais Causas de Óbitos por Residência
Município de Arcos
Período:2020 a 2024

Ano	Algumas doenças infecciosas e parasitárias	Doenças do aparelho circulatório	Neoplasias (tumores)	Doenças do aparelho respiratório	Doenças do aparelho digestivo	Doenças do aparelho geniturinário	Lesões envenenamento e outras causas externas	Total Geral de Óbitos no ano correspondente
2020	27	63	57	28	14	11	37	288
2023	15	65	60	36	17	16	34	325
2024	16	83	62	54	37	21	34	377

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.

A tabela acima retrata as principais causas de óbitos ocorridas nos anos de 2020 a 2024

Causas de Óbitos	2020	2021	2022	2023	2024
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	27	151	37	15	16
Doenças do aparelho circulatório	63	71	71	65	83
Neoplasias (tumores)	57	61	56	60	62
Doenças do aparelho respiratório	28	23	31	36	54
Lesões enven e alg out conseq causas externas	37	31	43	34	34

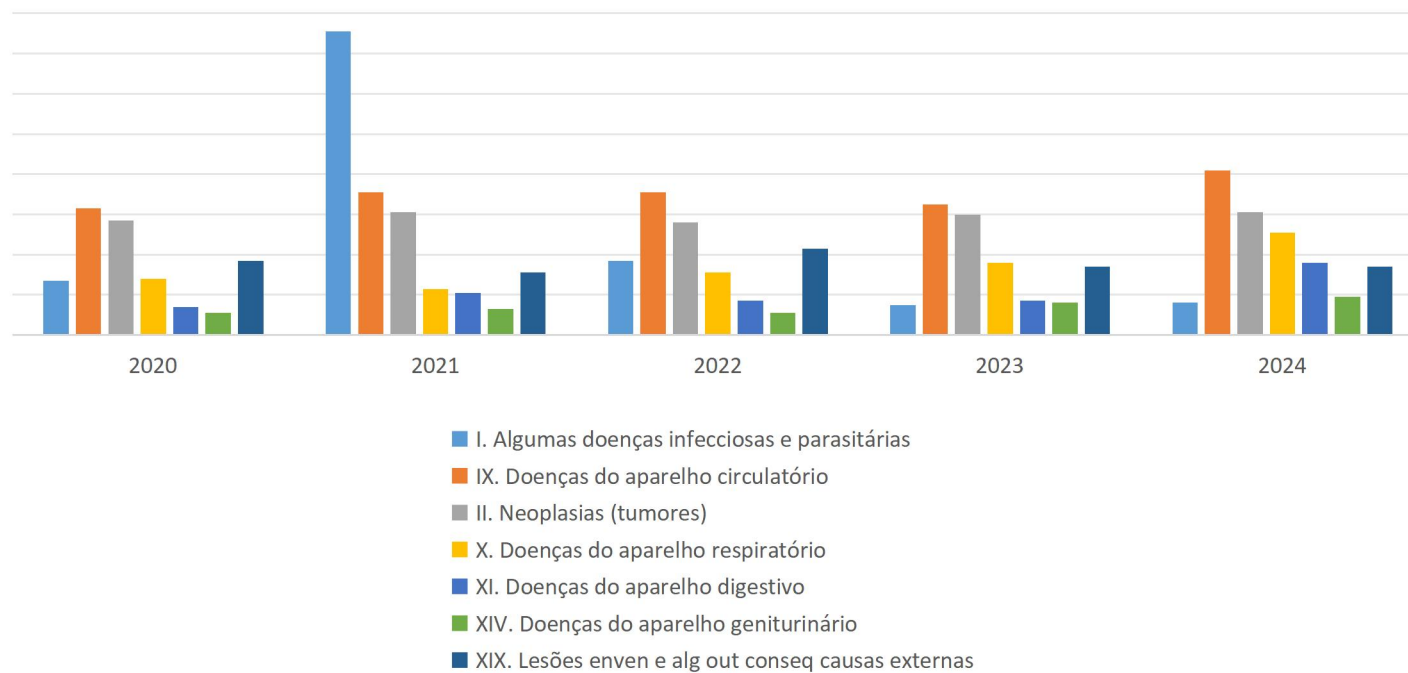
Causas de Óbitos	2020	2021	2022	2023	2024
Total Geral de Óbitos no ano correspondente	288	428	340	325	377

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.

A tabela acima retrata a frequência das principais causas de óbitos nos anos de 2020 a 2024

As tabela com a descrição das principais causas de óbitos por ano e a demonstração da frequência das causas permite uma visualização mais clara da prevalência das principais doenças ao longo do tempo e o destaque para a ocorrência de uma novo patógeno que desfigurou o cenário epidemiológico habitual, como foi o caso da pandemia de COVID - 19.

Principais Causas de Óbitos por Residência
Município de Arcos-MG
Período:2020 a 2024



Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.

No ano de 2020 as principais causas de óbito no município de Arcos/MG foram as doenças do aparelho circulatório , em segundo lugar as neoplasias,seguido pelas causas externas e em quarto lugar as doenças do sistema respiratório.

Em 2021 o cenário epidemiológico muda de perfil com a chegada da pandemia de COVID - 19,as doenças infecciosas passaram a tomar frente como a primeira causa de óbitos e as doenças do aparelho circulatório configuraram como a segunda causa,em terceiro lugar as neoplasias e em quarto as causas externas

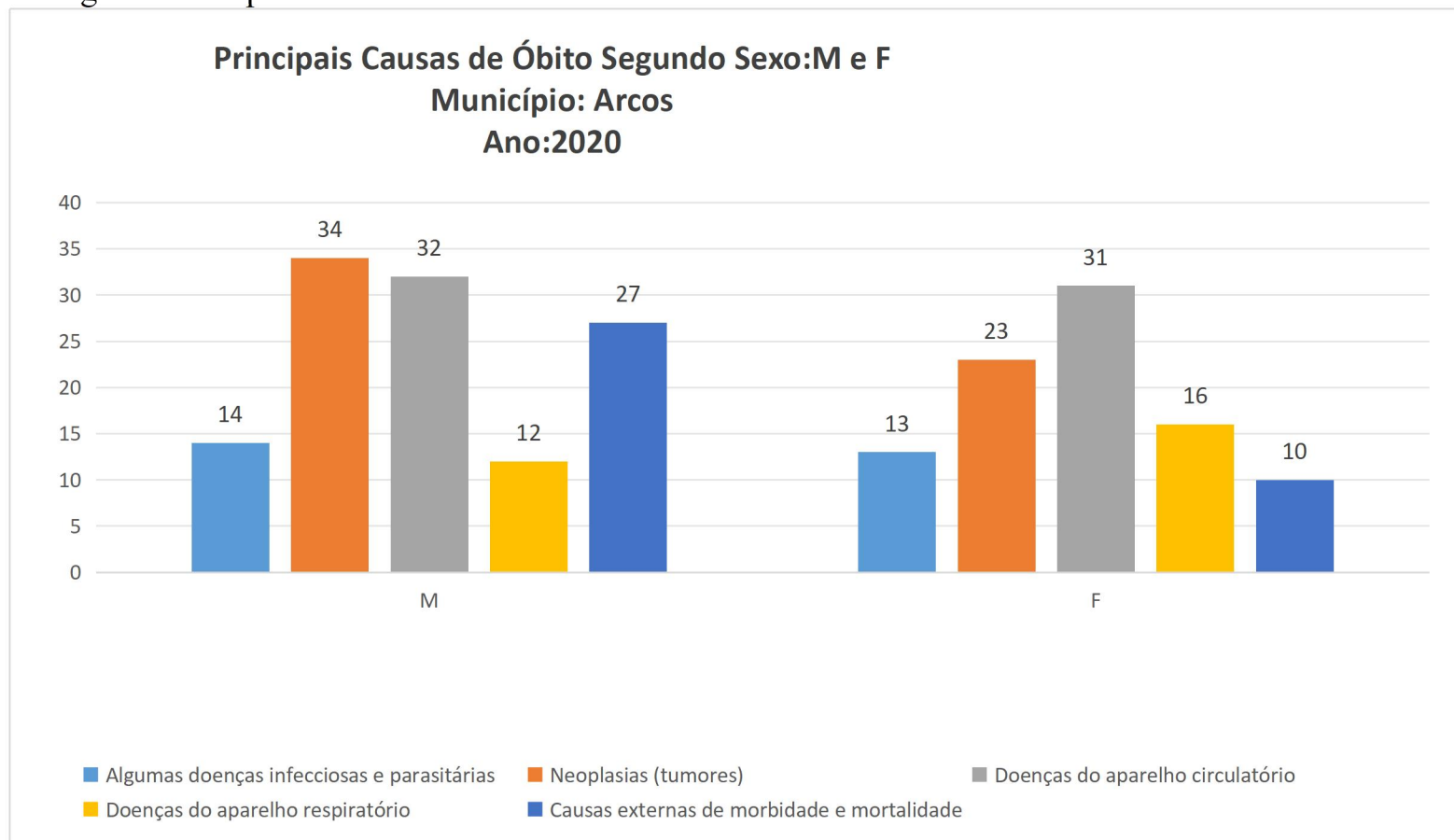
Em 2022 os óbitos advindo da pandemia de COVID - 19 começam a recuar e as doenças do aparelho circulatório voltam a liderar como principal causa de óbito no município, seguido pelas neoplasias, em terceiro as causas externas e em quarto lugar as infecciosas decorrente da pandemia de COVID-19

Conforme os dados extraídos do SIM nos anos de 2023 e 2024 houve uma prevalência no perfil epidemiológico onde o registro das principais causas de mortalidade foram respectivamente: Doenças do Aparelho Circulatório, Neoplasias, Doenças do Aparelho Respiratório, Doenças do Aparelho Digestivo e as Lesões por Causas Externas.

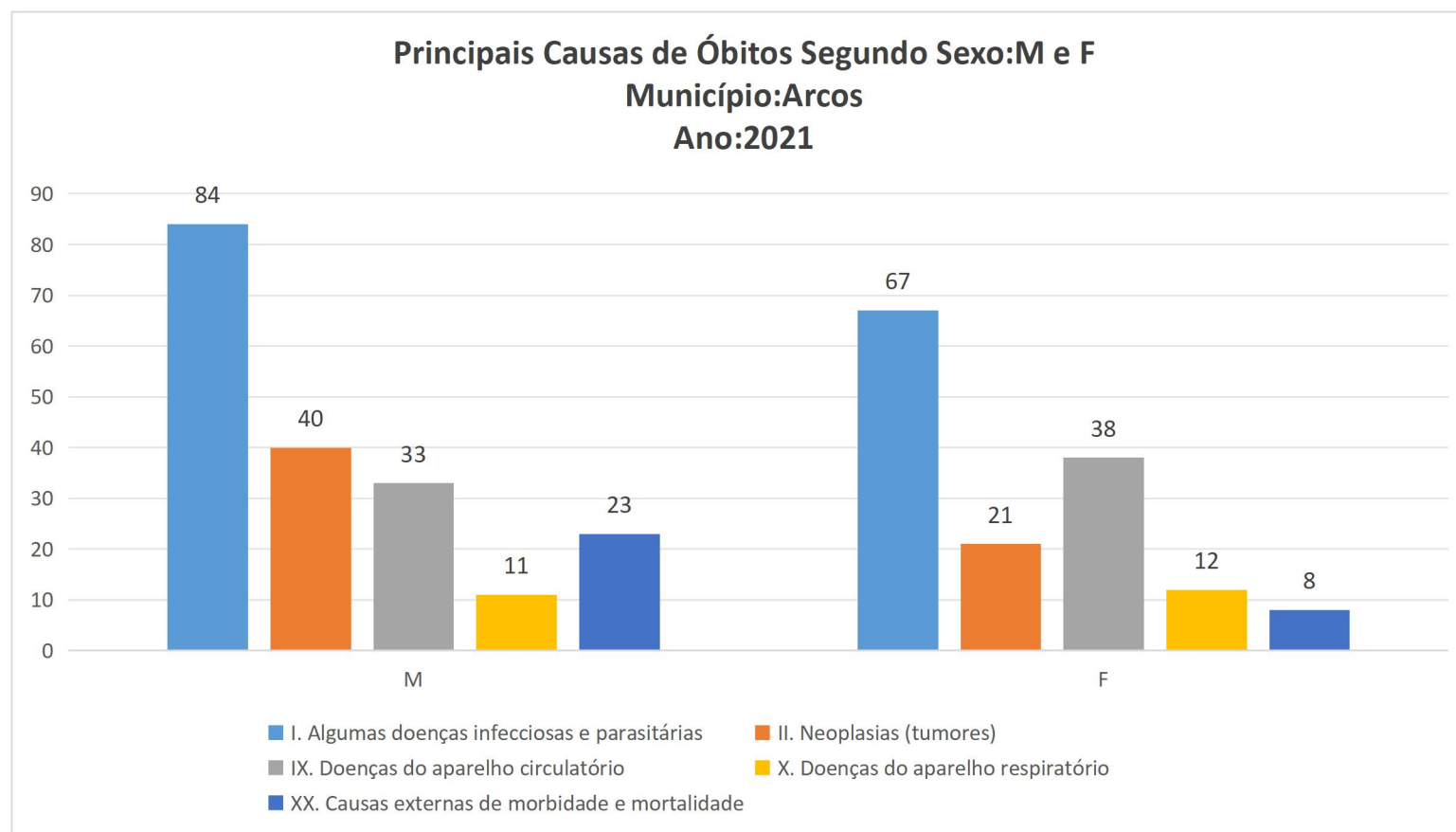
A Análise da Série Temporal entre os anos de 2020 a 2024 traça um perfil epidemiológico que permite identificar as principais causas de mortalidade no município de Arcos, onde com exceção do ano de 2021, no contexto da epidemia as doenças infecciosas atingiram o patamar como a primeira causa de óbito.

As causas de mortalidade são variáveis conforme o grupo etário e demográfico. A distribuição ligada aos fatores de gênero mostra a existência de um diferencial marcante onde a mortalidade masculina é maior em praticamente todas as idades e para quase a totalidade das causas.

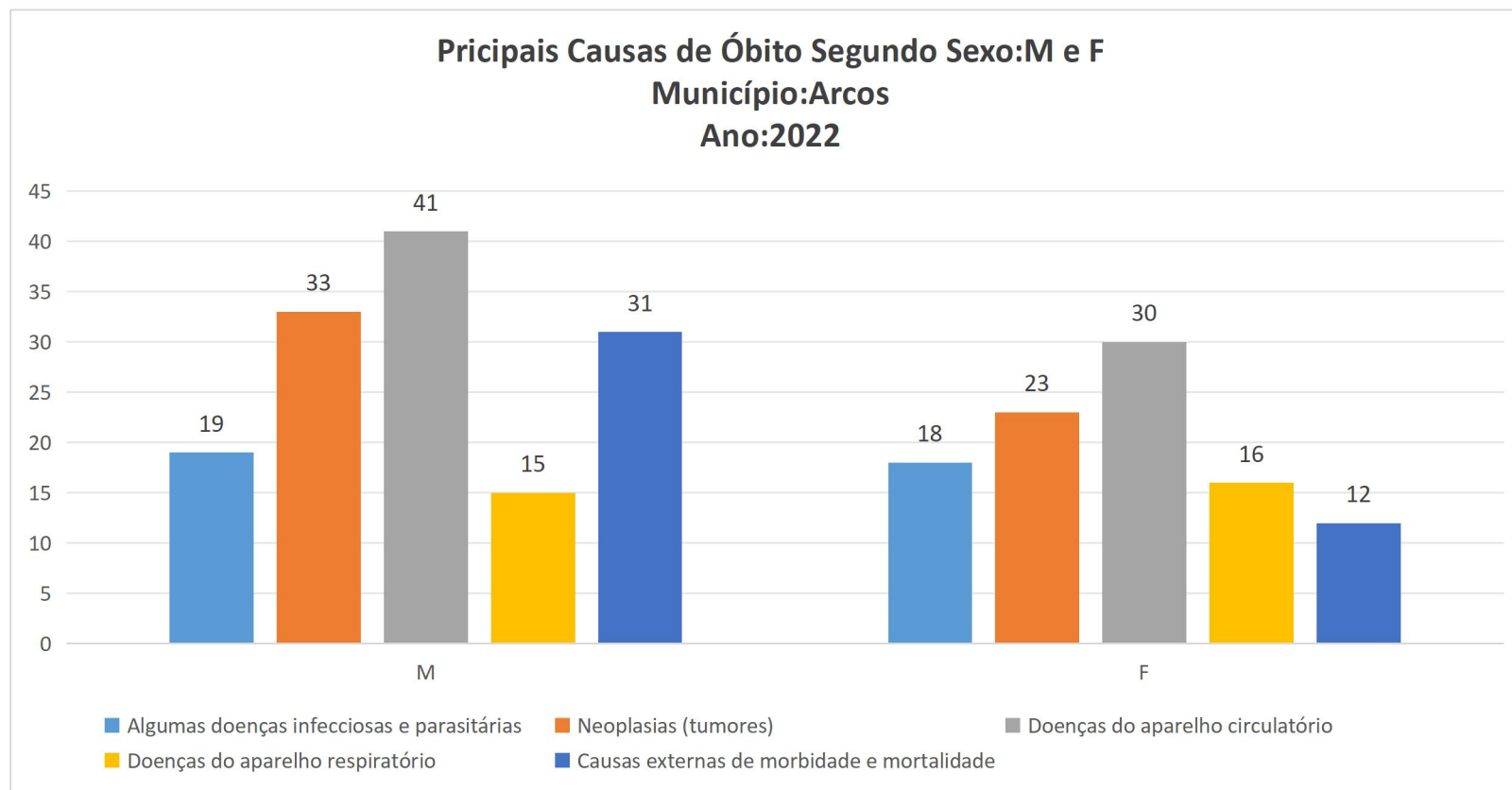
A maioria dos indicadores tradicionais de saúde mostra que a esperança de vida ao nascer e em outras idades são sempre menores entre os homens, os aspectos das diferenças entre a saúde do homem e da mulher, enfoca questões ligadas a fatores biológicos e comportamentais.



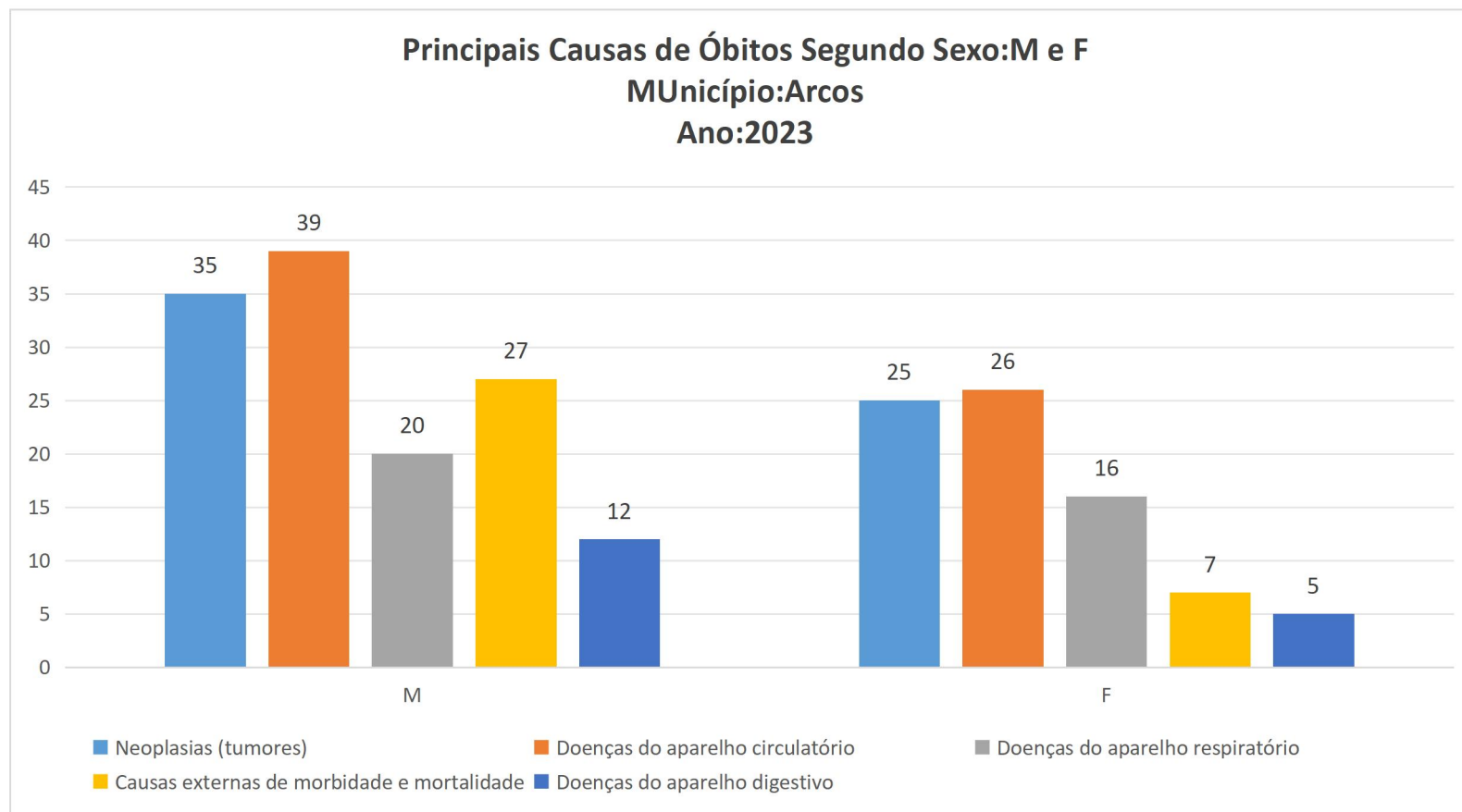
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.



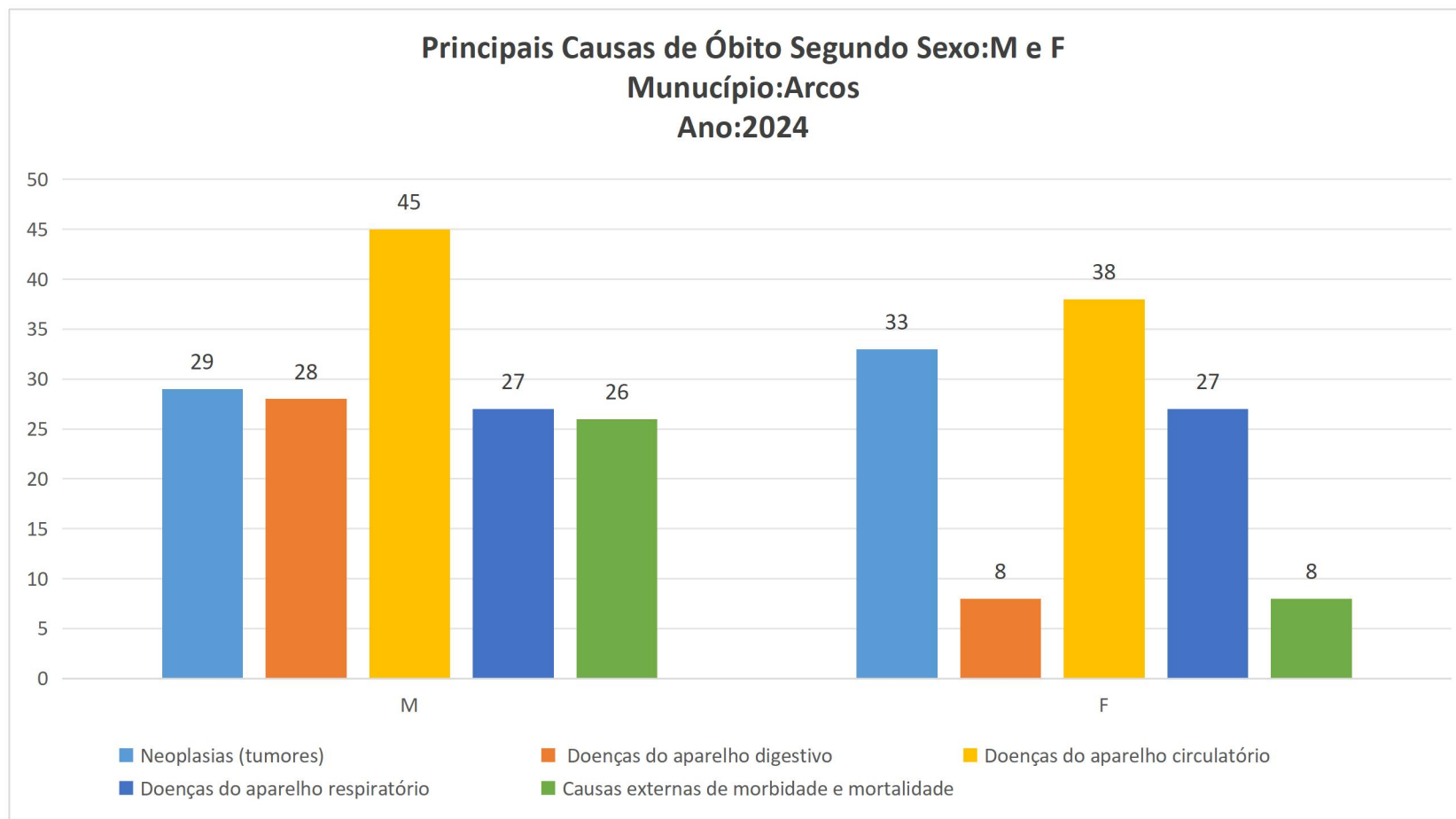
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.



Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.



Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.



Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.

No período de 2020 a 2024 no município de Arcos 75% óbitos foram do gênero masculino, prevalecendo entre as principais causas: Doenças do Aparelho Circulatório, Neoplasias, Doenças do Aparelho Respiratórios, Doenças do Aparelho Digestivo e as Lesões por Causas Externas. Em 2024 as doenças do aparelho digestivo surgiu como a terceira causa de óbito no município, 80% dos acometidos foram do sexo masculino, provenientes na maioria das vezes por situações relacionadas comportamentos e hábitos de vida.

As ocorrências dos óbitos no gênero masculino começam a ganhar evidência a partir da faixa etária dos 20 anos com as ocorrências dos acidentes de transporte e as situações de violência, mantendo a liderança nas faixas etárias seguintes.

Óbitos por Residência Segundo Causas Externas
Município: Arcos
Período de 2020 a 2024.

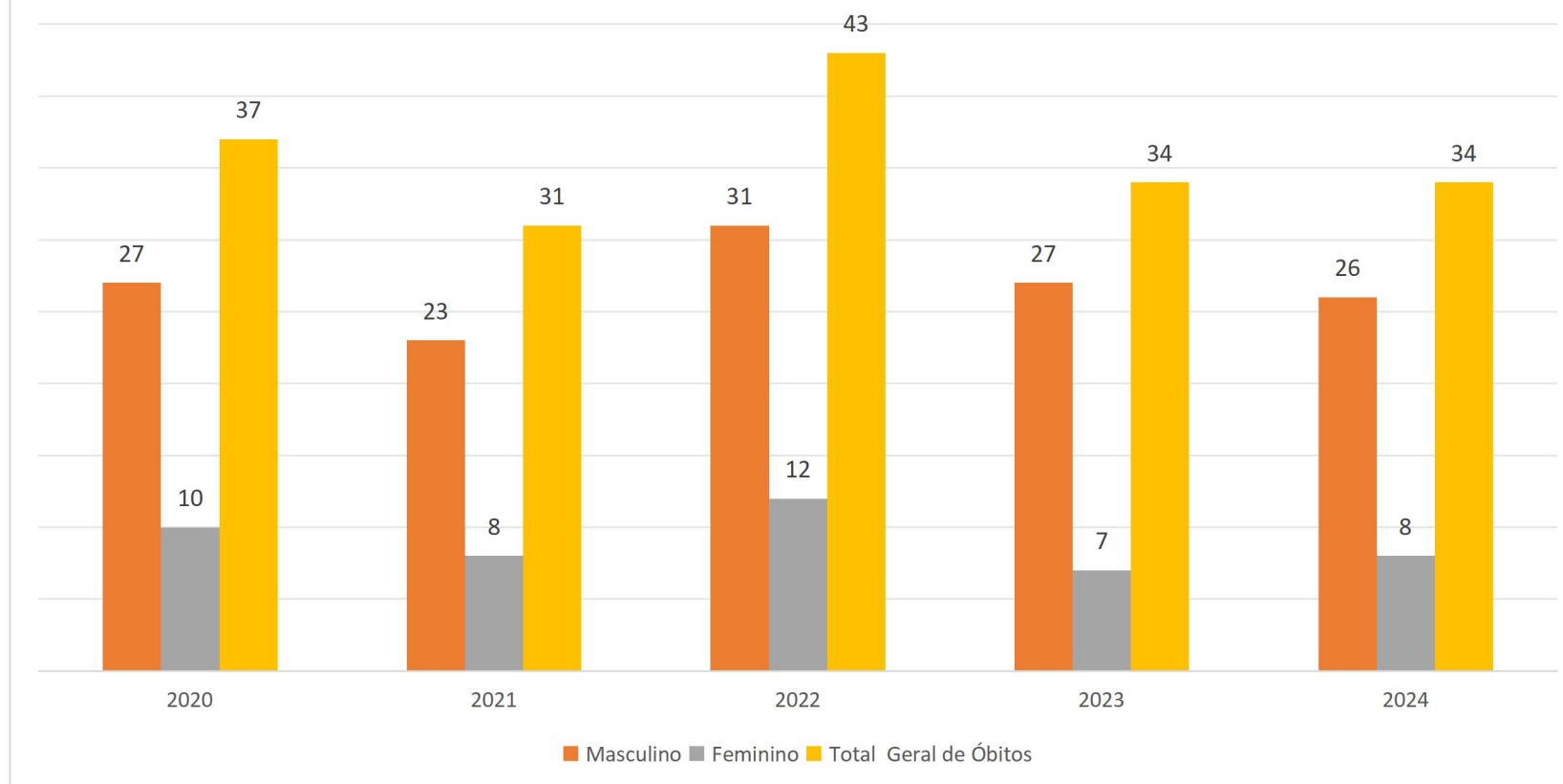
Ano	Masculino	Feminino	Total de Óbitos segundo causas externas.
2020	27	10	37
2021	23	08	31
2022	31	12	43
2023	27	07	34

Óbitos por Residência Segundo Causas Externas
Município: Arcos
Período de 2020 a 2024.

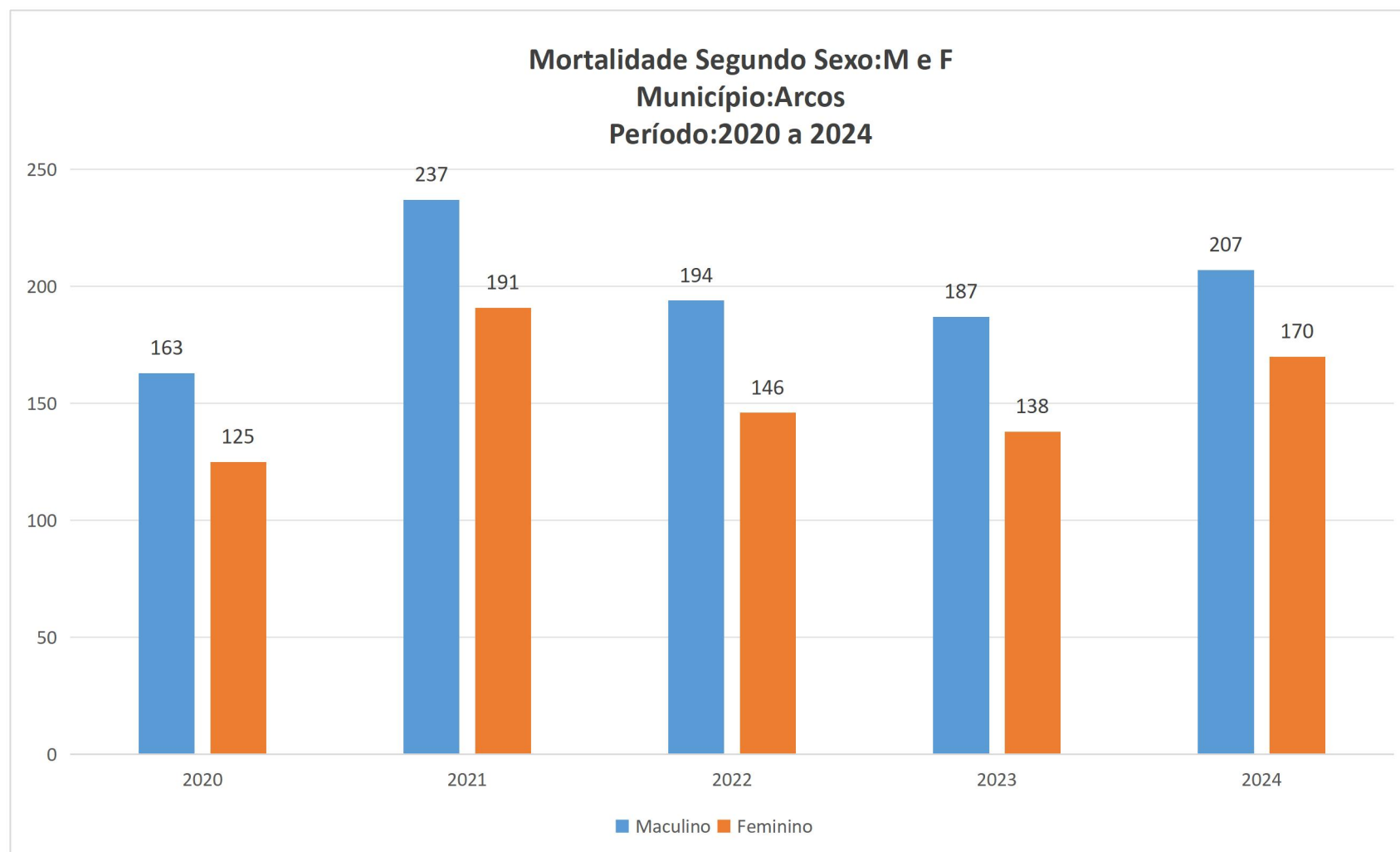
Ano	Masculino	Feminino	Total de Óbitos segundo causas externas.
2020	27	10	37
2024	26	08	34
Total	134	45	179

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.

**Óbitos por Residência Segundo Causas Externas Masc.e Fem.
Município de Arcos - MG
Período de 2020 a 2024.**



Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da consulta: 09/09/2025.



A prevalência da mortalidade masculina no município de Arcos, prevalece no período de 2020 a 2024, a queda da população masculina começa entre as faixas etária de 50 a 59 anos, quando a população feminina começa a predominar e à medida que a idade avança o contingente de idosos prevalece. A feminização da população é uma tendência demográfica, e também um fenômeno do processo de envelhecimento, pois as mulheres são maioria na população idosa, especialmente por terem maior longevidade. A longevidade feminina envolve um conjunto complexo de fatores biológicos, comportamentais e sociais.

3.4 Doenças de Notificação Compulsória.

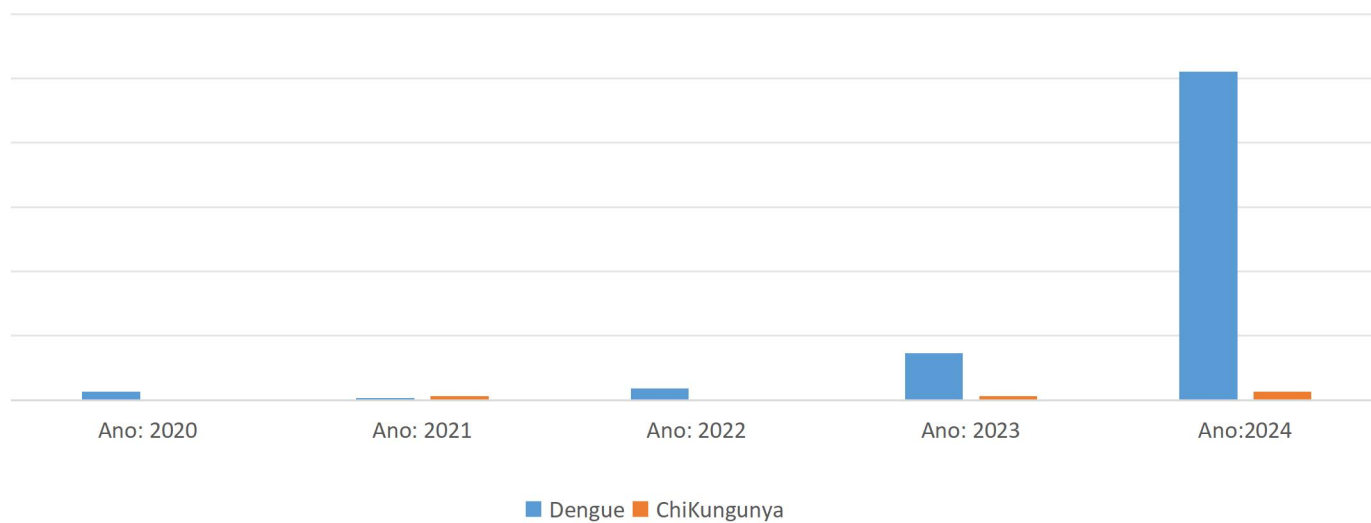
A notificação compulsória obrigatória nos sistemas de saúde é um mecanismo para a coleta de dados que permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica.

Arboviroses

Arboviroses notificadas e confirmadas Município de Arcos Período:2021 a 2024					
	Ano: 2020	Ano: 2021	Ano: 2022	Ano: 2023	Ano:2024
Dengue	68	17	90	364	2.552
ChiKungunya	02	33	01	33	65

Conforme os dados apresentados no período de 2021 a 2024 as arboviroses sempre estiveram presentes no cenário epidemiológico do município de Arcos,destacando o ano de 2024 onde as notificações por dengue cresceram exponencialmente.

Arboviroses Notificadas e Confirmadas Município de Arcos-MG
Período: 2020 a 2024



Fonte: SINAN/2025

O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por *Aedes aegypti* - LIRAA, é uma ferramenta de vigilância em saúde desenvolvida pelo Ministério da Saúde para monitorar a presença do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya é uma metodologia simplificada que proporciona uma rápida obtenção de indicadores entomológicos através do conhecimento, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes (depósitos) com larvas de *Aedes aegypti*.

Os resultados geram uma Classificação do Índice de Infestação Predial -IIP que demonstra o risco do qual o município está exposto,onde:

IIP Menor que 1	Satisfatório	Baixo Risco
IIP de 1 a 3,9	Alerta	Médio risco
IIP Maior 3,9	Risco de surto	Alto risco

Essa classificação é a principal ferramenta norteadora das ações a serem protagonizadas pelo setor público.

Esses dados visam otimizar e direcionar estrategicamente as ações de controle do vetor, proporcionando uma delimitação eficaz das áreas de risco entomológico.É também, uma importante fonte de informação para a mobilização social,permitindo à população conhecer quais os tipos de depósitos que apresentam maiores chances de servirem como criadouros para o mosquito bem como na definição da programação das ações de controle vetorial, educação em saúde, manejo ambiental.

Classificação do Índice de Infestação Predial (IIP) por Aedes aegypti Arcos/MG Período de 2021 a 2024			
Ano	IIP (%)	Classificação	Cor
2021	8,2%	Risco de surto (alto risco)	Vermelho
2022	5,5%	Risco de surto (alto risco)	Vermelho
2023	5,8%	Risco de surto (alto risco)	Vermelho
2024	3,4%	Alerta (médio risco)	Amarelo

Fonte: Informativo Entomológico/ Endemias/Arcos/MG 2025

Infelizmente não temos os registros do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti do ano de 2020, mas, diante dos resultados da Classificação do Índice de Infestação Predial -IIP nos períodos avaliados o município de Arcos sempre esteve sob risco de epidemia, uma vez que os resultados do IIP sempre estiveram além do recomendado e o número de notificações demonstram a constância de ocorrência de arboviroses no município com destaque para a dengue e chikungunya.

Mesmo com IIP de 8,2% no ano de 2021, o mais alto do período os dados demonstram que houve uma subnotificação dos casos de arboviroses decorrentes do efeito da pandemia, que direcionou todos os esforços ao contexto pandêmico vivenciado no momento.

Salientado o perfil endêmico do município de Arcos para as Arboviroses e o constante perfil de risco epidêmico a realização do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por *Aedes aegypti* é de suma importância para o direcionamento da implantação de ações pontuais e em tempo oportuno para controle e prevenção de futuras epidemias.

Síndrome Respiratória Aguda Grave

A Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG e a Síndrome Gripal - SG são definições clínicas utilizadas pela vigilância epidemiológica para identificar, monitorar e responder de forma oportuna às infecções respiratórias agudas com potencial de disseminação e impacto na saúde pública.

As notificações são provenientes dos casos que foram hospitalizados e são de suma importância para a identificação oportuna dos períodos de maior circulação de vírus respiratórios, e para o atendimento adequado dos casos de SG e SRAG que são fundamentais para reduzir complicações e óbitos por essas condições.

Síndrome Respiratória Aguda Grave-SRAG Notificadas e Confirmadas. Município: Arcos Período: 2021 a 2024				
Ano:2020	Ano:2021	Ano:2022	Ano:2023	Ano:2024
81	678	135	55	44

Fonte:SRAG/2025

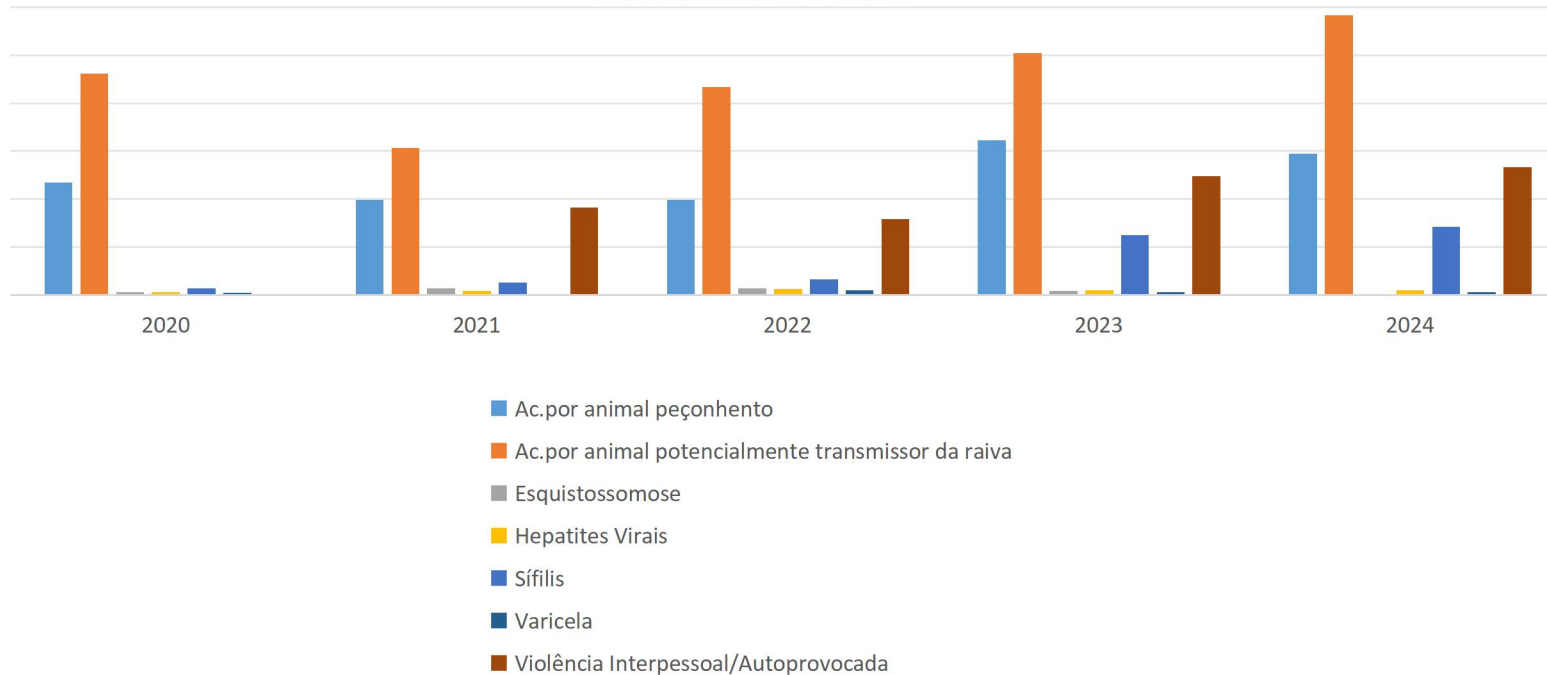
Agravos,-Doenças e Eventos de Saúde Pública de Notificação de Compulsória

Agravos, Doenças e Eventos de Saúde Pública de Notificação de Compulsória Município de Arcos Período de 2020 a 2024					
Agravo	Ano:2020	Ano:2021	Ano:2022	Ano:2023	Ano:2024
Acidente por animal peçonhento	117	99	99	161	147
Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva	231	153	217	252	292
Caxumba (Parotidite Epidêmica)	3	1	1	-	1
Coqueluche	-	-	-	-	1
Doença de Chagas	-	1	1	1	-
Doença de Chagas Aguda	-	-	1	-	-
Doenças causadas por protozoários complicando a gravidez, o parto e puerpério	-	1	3	1	1
Doença Aguda pelo Vírus Zika	-	1	-	-	1
Esquistossomose	3	7	7	4	1

Hepatites Virais	3	4	6	5	5
Leptospirose	-	-	-	1	-
Meningites-Doenças Meningococicas	-	-	1	2	2
Outras afecções originadas no período perinatal	-	-	1	-	-
Sífilis Congênita	-	1	-	2	-
Sífilis em Gestante	4	4	-	10	8
Sífilis não Especificada	3	9	16	52	63
Síndrome de Guillain-Barre	-	1	-	-	1
Toxoplasmose	5	2	1	1	-
Toxoplasmose Congênita	-	-	-	1	-
Varicela	2	1	5	3	3
Violência Interpessoal/Autoprovocada	-	91	79	124	133
Total	371	376	438	621	659

Fonte: SINAN/2025

Principais Agravos de Notificação Compulsória
Arcos - MG
Período:2020 a 2024



Conforme a análise temporal do período de 2020 a 2024, e o perfil epidemiológico das notificações, evidenciamos um aumento substancial na ocorrência da Violência Interpessoal e Autoprovocada. É notório que as notificações representam uma pequena parcela dos casos, mas ainda assim elas fornecem um cenário de evidências sobre a violência, proporcionando um olhar mais atento aos grupos mais vulneráveis e criando subsídios para condução de medidas de promoção da saúde e da cultura de paz, de prevenção e controle das causas externas, principalmente em relação à violência doméstica, sexual e outras violências que permanecem com pouca visibilidade

Os dados do SINAN também salienta o aumento das infecções por sífilis no município, esses registros vão ao encontro do perfil epidemiológico da sífilis no Brasil, no qual a doença ainda permanece um grande desafio para a saúde pública.

O aumento das notificações das infecções por sífilis pode ser atribuído à diversos fatores, desde o aumento das pessoas testadas e diagnosticadas, como também a falta de conscientização sobre a doença, as desigualdades no acesso aos serviços de saúde, as dificuldades no diagnóstico e tratamento precoce, resistência ao uso de preservativos, além do estigma persistente em torno das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Nesse contexto um destaque importante é a transmissão vertical, na qual a doença é transmitida da mãe com sífilis para a criança, e que se não tratada oportunamente durante a gestação, a criança pode ser afetada e evoluir para a sífilis congênita, gerando consequências graves ao bebê ou até mesmo o óbito. Esse tipo de contágio é evitável, desde que a gestante infectada receba o tratamento adequado e em tempo oportuno.

A prevenção da sífilis é fundamental e o uso da camisinha masculina ou feminina é a única forma de evitar a doença. A ampliação da testagem possibilita o diagnóstico da doença e o tratamento.

A adesão ao tratamento dos parceiros sexuais apesar de ser um grande desafio é de suma importância na a interrupção da cadeia de transmissão da doença.

A captação precoce da gestante no pré-natal é uma das estratégias mais eficientes, uma vez que o diagnóstico e tratamento em tempo oportuno são cruciais para evitar a sífilis congênita.

Os acidentes por animais são de grande interesse em saúde pública pelo alto número de notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo acidentes por animais peçonhentos um dos agravos mais notificados. Animais peçonhentos são reconhecidos como aqueles que produzem ou modificam algum veneno e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou predador.

Os acidentes ofídicos possuem grande relevância em virtude de sua grande frequência e gravidade, atingindo na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais.

A partir das análises das notificações no SINAN, a vigilância epidemiológica é capaz de identificar o quantitativo de soros antivenenos a serem distribuídos aos municípios, além de determinar pontos estratégicos de vigilância, estruturar as

unidades de atendimento aos acidentados, elaborar estratégias de controle desses animais, e a necessidade de políticas públicas específicas para essas populações mais vulneráveis.

Conforme os dados apresentados houve um grande número nos registros de Acidente por Animal Potencialmente transmissor da raiva. A raiva é de extrema importância para saúde pública, devido a sua letalidade de aproximadamente 100%, por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato) e pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro antirrábico humano, a realização de bloqueio de foco, bem como a vacinação anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que consequentemente previne também a raiva humana.

Outro tema de grande relevância são as notificações da esquistossomose, tendo em vista o perfil endêmico do município de Arcos e a ocorrência da doença continua a comprometer a saúde e a qualidade de vida da população.

A esquistossomose apresenta comportamento silencioso e duradouro, é uma doença, inicialmente assintomática, que pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. A magnitude de sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas e a sua evolução, conferem a esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde pública.

A prevenção da esquistossomose consiste em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros intermediários infectados. O controle da esquistossomose é baseado no tratamento coletivo de comunidades de risco, acesso a água potável e saneamento básico e educação em saúde.

Desta forma o Programa de Controle à Esquistossomose (PCE) merece um olhar mais atento, com a reativação do programa no município de Arcos, para o enfrentamento mais adequado da endemia e a possibilidade de desenvolver um controle mais efetivo da doença

3.5 Cenário Epidemiológico

Compreender o perfil epidemiológico de saúde-doença na população é essencial para a formulação de políticas de saúde, alocação de recursos e crucial para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde.

Nas últimas décadas o Brasil vem passando por um processo de transformação rápida e intensa no seu perfil demográfico, socioeconômico e epidemiológico, que têm modificado o perfil de adoecimento e morte da população.

A diversidade de doenças e problemas de saúde que compõem o atual cenário epidemiológico brasileiro cria um perfil complexo do processo saúde-doença que reflete na super posição de causas de morte relacionadas com diferentes condicionantes e determinantes.

O perfil de saúde da população é caracterizado por uma tripla carga de grandes grupos de problemas de saúde que atualmente se super põem no nosso perfil epidemiológico, as doenças transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis os acidentes e as violências.

Essa evolução do cenário epidemiológico é influenciada por diferentes determinantes e em ritmos diversos, tal como o crescimento populacional que representa uma importante conquista social, resultante da melhoria das condições de vida, da ampliação ao acesso aos serviços médicos preventivos e curativos, avanços na tecnologia médica, aumento da cobertura de saneamento básico, maior nível de escolaridade e renda, entre outros fatores determinantes.

O resultado dessas conquistas é o aumento da expectativa de vida e consequente envelhecimento populacional, que vem acompanhado do grande aumento das doenças e condições crônicas.

A transição demográfica brasileira é marcada pela queda da fecundidade e mortalidade, resultando em um rápido envelhecimento populacional que apresenta características peculiares que ocorre de maneira desigual e com profundas implicações sociais no processo de envelhecimento.

Esse processo teve um impacto significativo e trouxe mudanças no perfil demográfico e epidemiológico, gerando demandas que pedem respostas das políticas sociais que inclui a necessidade de novas formas de cuidado e assistência, em especial, os cuidados prolongados e a atenção domiciliar à população idosa.

O grupo das Doenças e Agravos Não Transmissíveis representam a maior causa de morbimortalidade no Brasil, no mundo e no município de Arcos.

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), é um conjunto de doenças crônicas não transmissíveis, que compreendem dois grandes grupos de eventos caracterizadas principalmente pelas doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias e diabetes mellitus, e as causas externas, tais como os acidentes e as violências.

DCNT são doenças multifatoriais que se desenvolvem no curso da vida e que possuem longa duração. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus são as principais causas de óbitos e incapacidades e constituem um dos maiores problemas para a sociedade e para os sistemas de saúde.

Já as ocorrências de acidentes englobam tantos os acidentes automobilísticos, prevalecente na população jovem quanto as quedas são um fator de risco significativo para o óbito em idosos.

As Doenças e Agravos Não Transmissíveis estão relacionadas a diversos fatores condicionantes e determinantes sociais, entretanto a maioria é ocasionada por fatores de risco modificáveis, tais como o controle do tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física.

Tendo em vista o impacto desses indicadores na vida das pessoas e no sistema de saúde é imprescindível o investimento incessante nas ações de controle e prevenção das doenças não transmissíveis através do conhecimento do padrão de ocorrência, tendência e fatores determinantes e condicionantes, com a finalidade de recomendar e adotar medidas

eficientes que estimulem ações e estratégias que visem a promoção da saúde da população.

A maioria das ações para o controle das Doenças e Agravos Não Transmissíveis derivam da Atenção Básica e demandam uma baixa densidade tecnológica com investimento no empoderamento do indivíduo nos cuidados da sua saúde. Os resultados dessas ações repercutirão de forma positiva na redução dos custos de saúde, na queda dos índices de mortalidade e principalmente na melhora da qualidade de vida da população.

A urbanização acelerada, sem a infraestrutura adequada, são determinantes, comuns a países de desenvolvimento recente, que explicam uma parte importante do nosso perfil epidemiológico atual, no caso do conjunto das causas externas, e ganhando maior relevância, os acidentes de trânsito constituem uma das mais importantes causas de mortes prematuras e de incapacidades que se constituem em um grande desafio para a saúde pública pelo crescimento de hospitalizações e mortes decorrentes de Acidentes de Transporte Terrestre na última década, particularmente relacionadas com as motocicletas (BRASIL, 2013).

O desenvolvimento das cidades, a urbanização e o estilo de vida moderno está intrinsecamente ligado ao aumento da frota de veículos nas cidades.

A grande quantidade de veículos circulantes nos municípios esbarra em diversos fatores advindos do crescimento rápido das cidades sem infraestrutura viária adequada. O crescimento da frota em um espaço inadequado causa uma desordem que agrava problemas de congestionamento, estresse, poluição sonora e ambiental, e o aumento de acidentes de trânsito.

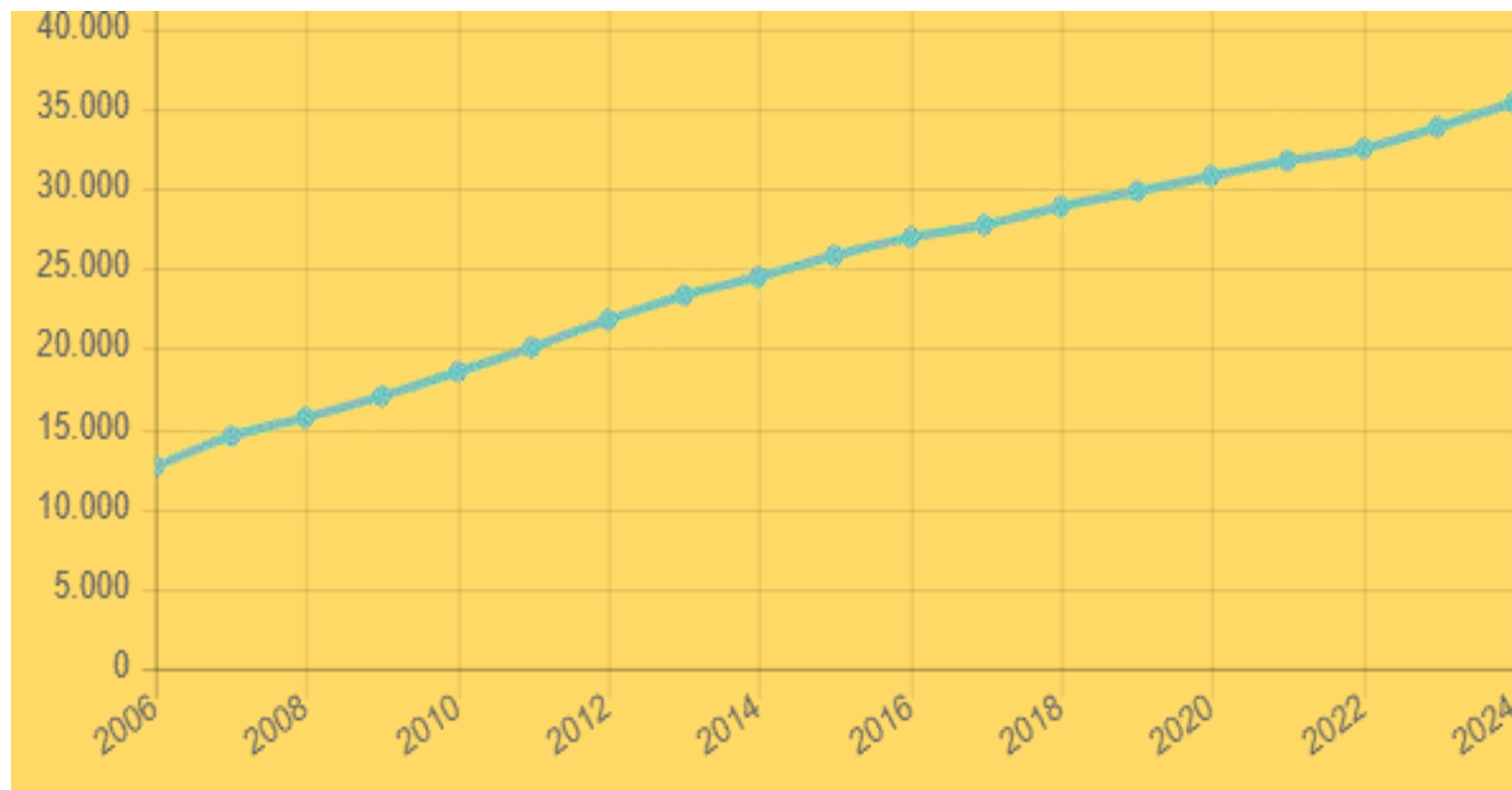
A carência de transporte público para o deslocamento rápido e eficiente leva os indivíduos a procurar um meio de transporte rápido e barato, com isso quantidade de veículos nos municípios é impulsionada principalmente pelas motocicletas, que cresceram exponencialmente nos últimos anos, engrossando a quantidade de veículos circulantes nas diversas cidades.

Essa modalidade de transporte nas cidades aumenta os riscos e a vulnerabilidade em acidentes contribuindo para o crescimento no número de mortes e acidentes no trânsito.

No período de 2014 a 2024 foram registros 128 óbitos por acidente de trânsito no município de Arcos/MG, conforme a análise da série histórica apresentada, onde o perfil predominante das vítimas é do sexo masculino, adultos jovens na faixa etária de 20 a 39 anos.

Os acidentes de trânsito configuram hoje um relevante impacto na sociedade, e engloba vários impactos sejam na saúde física do indivíduo, social ou emocional e econômico . Os sinistros de trânsito são um desafio para a saúde pública, tendo em vista que as principais vítimas são os jovens em idade economicamente ativa e o alto aporte de recursos financeiros gastos com internações e reabilitação. Além da perda de vidas de forma precoce, cujo valor é inestimável.

Conforme dados do IBGE entre os anos de 2014 a 2024 houve um aumento de 11.860 veículos no município de Arcos/MG, levando em consideração que o espaço urbano continua o mesmo, cabe destacar a importância da criação de políticas voltadas para educação e conscientização da segurança no trânsito, assim como os investimentos em infraestrutura e no comportamento das pessoas, como medidas para reduzir a morbimortalidade no trânsito.



Fonte IBGE/2022

Já as doenças transmissíveis são as enfermidades causadas por agentes infecciosos como vírus, bactérias ou fungos que são transmitidas de várias formas, tais como: contato direto entre indivíduos ou indireto através de alimentos e água contaminada ou ainda por vetores.

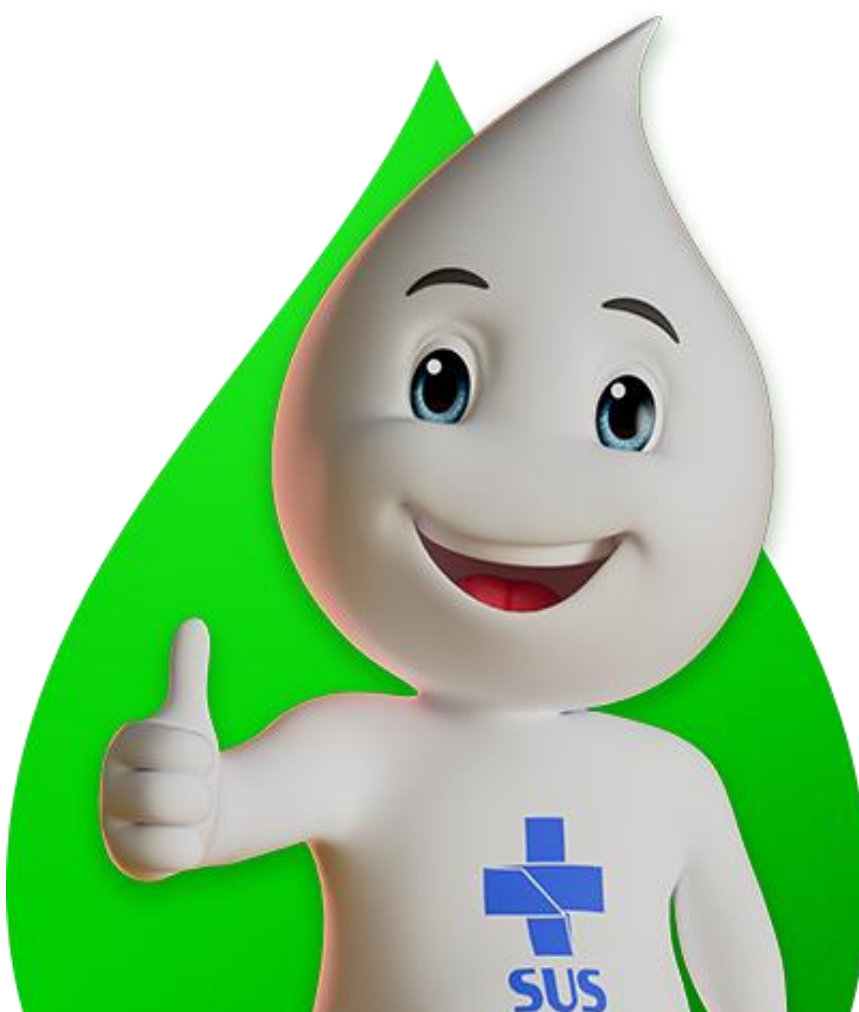
As doenças transmissíveis já foram a principal causa de morte dos brasileiro, porém, as melhorias sanitárias, o desenvolvimento de novas tecnologias, como as vacinas e os antibióticos, a ampliação do acesso aos serviços de saúde e as medidas de controle fizeram com que esse quadro se modificasse bastante até os dias de hoje.

Apesar da redução significativa da participação desse grupo de doenças no perfil da mortalidade do nosso país, ainda há um impacto importante sobre a morbidade, principalmente por aquelas doenças para as quais não se dispõe de mecanismos eficazes de prevenção e/ou que apresentam uma estreita associação com causas ambientais, sociais e econômicas.

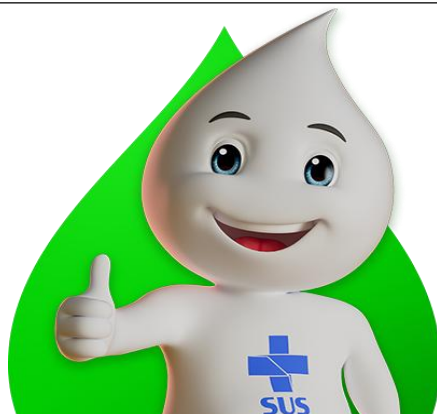
O controle de doenças transmissíveis envolve um conjunto de ações de saúde pública que tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde, bem como tratamento das doenças infecciosas e seus fatores de risco, evitando sua disseminação.

O investimento no saneamento básico e na vacinação são estratégias de prevenção de alta eficiência que reduz a incidência e prevalência de doenças, até que essas deixem de ser um problema de saúde pública.

4 Panorama Vacinal



4 Panorama Vacinal do Município de Arcos
Período: 2023 a 2025



Registro de Vacinas de Crianças de 0 a 1 ano de idade
Município de Arcos
Período de 2023 a 2025

Vacina	Ano:2023	Ano:2024	Ano:2025
BCG	89,38%	98,77%	97,51%
Hepatite B	86,12%	97,23%	96,10%
Febre Amarela	75,95%	76,65%	73,71%
Poliomielite VIP	88,92%	90,68%	87,46%

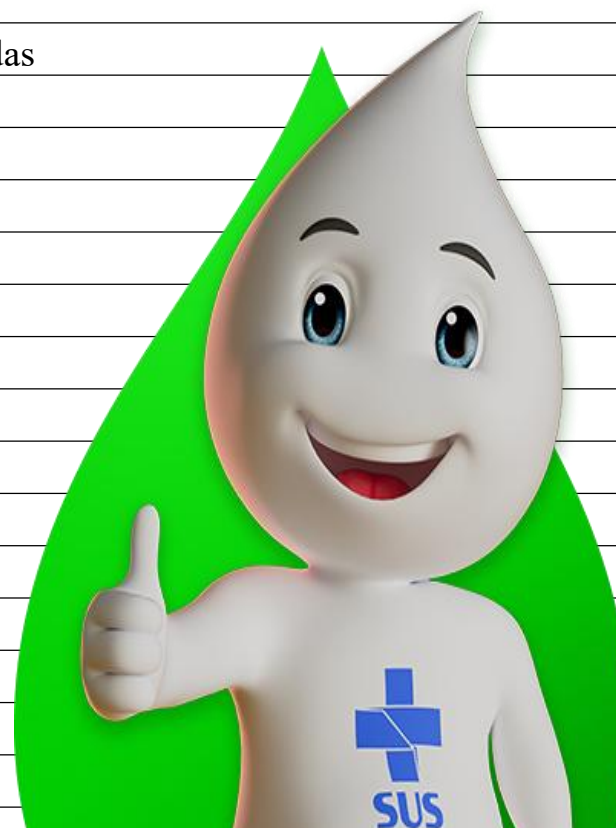
Pneumo 10	91,15%	93,27%	92,89%
Menigite C	91,07%	89,37%	90,48%
Penta (DTP+Hep.B+ Hib)	87,94%	90,48%	87,89%
Rotavírus	88,39%	89,65 %	90,16%
Hepatite A	85,63%	86,17%	84,36%
DTP	80,46%	86,69 %	84,08%
Tríplice Viral 1º Dose	90,75%	95,98%	92,58%
Tríplice Viral 2 Dose	69,12%	80,62%	78,03%
Pneumo 10	86,31%	93,22%	88,90%
Poliomielite Oral Bivalente	80,60%	*	*
Poliomielite VIP Reforço	*	88,19%	85,28%
Varicela	74,00 %	73,30%	77,43%
Menigite C 1ºReforço	89,81%	92,20%	89,89%

Fonte:PNI/MS:2026.

Conforme os dados expostos o ano de 2024 apresentou as melhores taxas de cobertura vacinal na faixa etária das crianças de 0 a 1 ano de idade,considerando que as vacinas contra a Meningite C e Varicela estiveram em falta no respectivo ano.

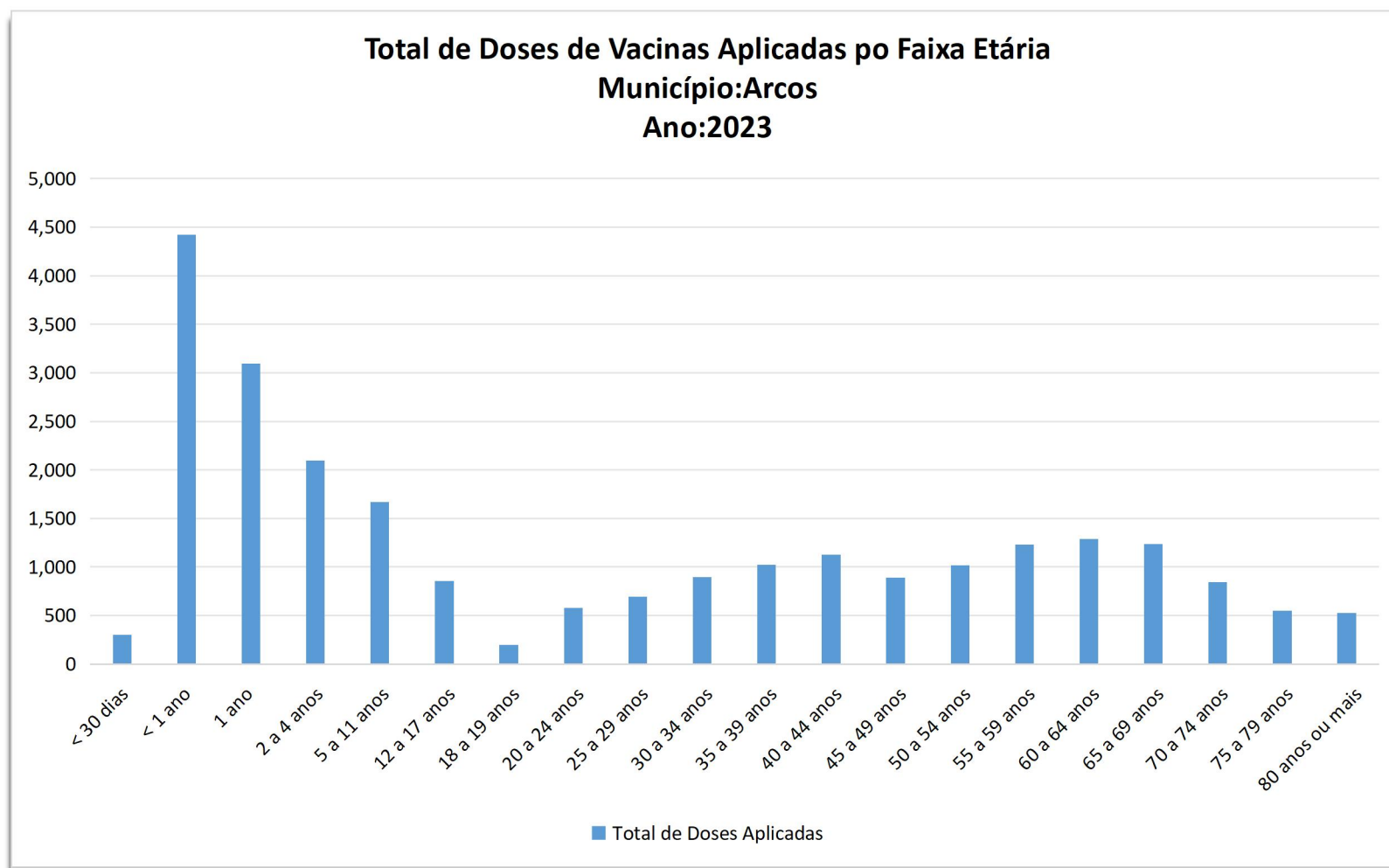
Panorama Vacinal Ano:2023

Total de Doses de Vacinas Aplicadas Conforme Faixa Etária Município:Arcos Ano:2023		
Faixa Etaria	Doses Aplicadas	
< 30 dias		299
< 1 ano		4.421
1 ano		3.094
2 a 4 anos		2.096
5 a 11 anos		1.669
12 a 17 anos		854
18 a 19 anos		194
20 a 24 anos		576
25 a 29 anos		695
30 a 34 anos		894
35 a 39 anos		1.022
40 a 44 anos		1.125
45 a 49 anos		890
50 a 54 anos		1.015
55 a 59 anos		1.228



60 a 64 anos	1.285
65 a 69 anos	1.236
70 a 74 anos	846
75 a 79 anos	550
80 anos ou mais	526
Total de Doses Aplicadas	24.515

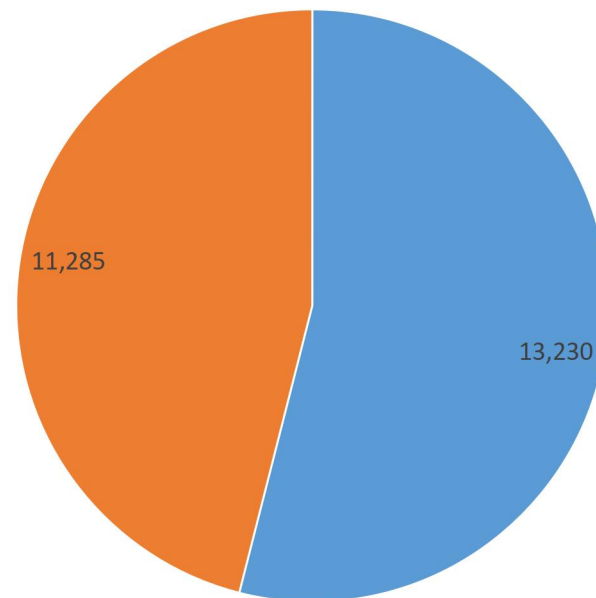
Fonte:PNI/MS:2026.



Fonte: PNI/MS:2026.

Total de Doses de Vacinas Aplicadas Conforme Sexo
Município:Arcos
Ano 2023

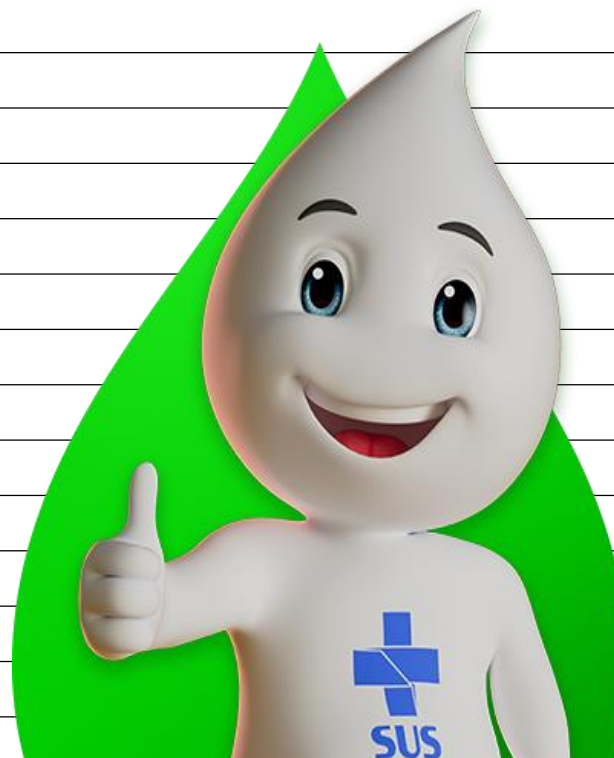
■ Feminino ■ Masculino

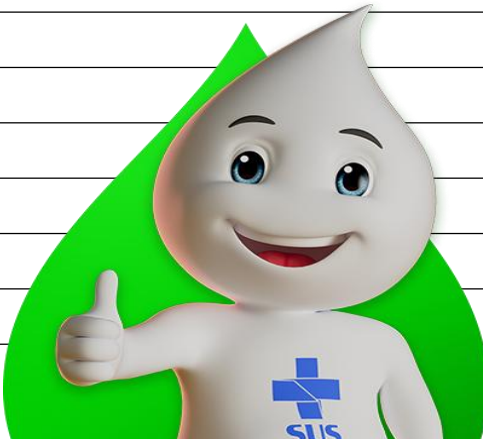


Fonte:PNI/MS:2026.

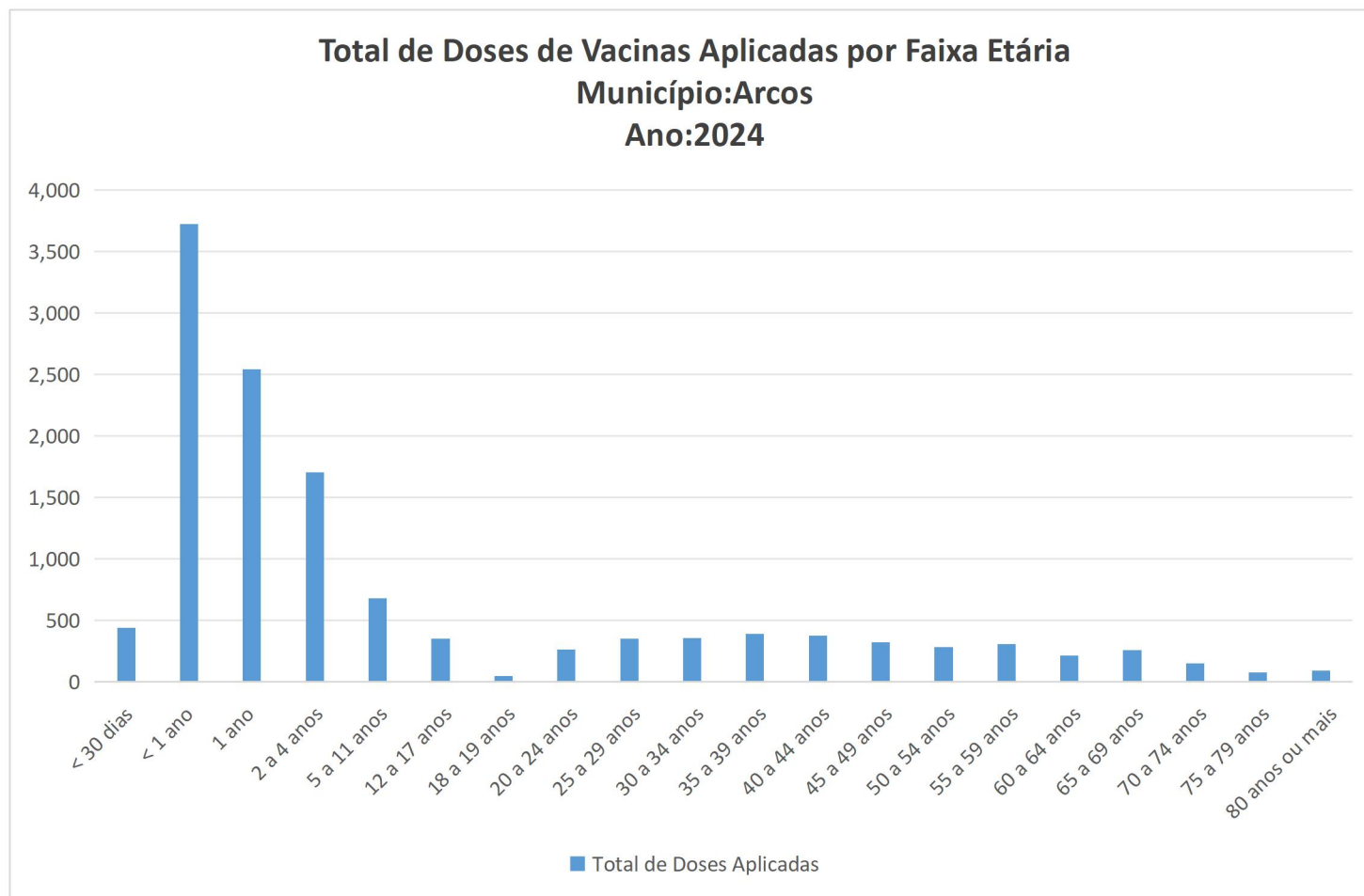
Panorama Vacinal :Ano 2024

Total de Doses de Vacinas Aplicadas Conforme Faixa Etária Município:Arcos Ano:2024	
Faixa Etaria	Doses Aplicadas
< 30 dias	440
< 1 ano	3.726
1 ano	2.545
2 a 4 anos	1.704
5 a 11 anos	680
12 a 17 anos	350
18 a 19 anos	49
20 a 24 anos	265
25 a 29 anos	351
30 a 34 anos	359
35 a 39 anos	393
40 a 44 anos	379
45 a 49 anos	322
50 a 54 anos	283



55 a 59 anos		306
60 a 64 anos		216
65 a 69 anos		261
70 a 74 anos		151
75 a 79 anos		76
80 anos ou mais		91
Total de Doses Aplicadas		12.947

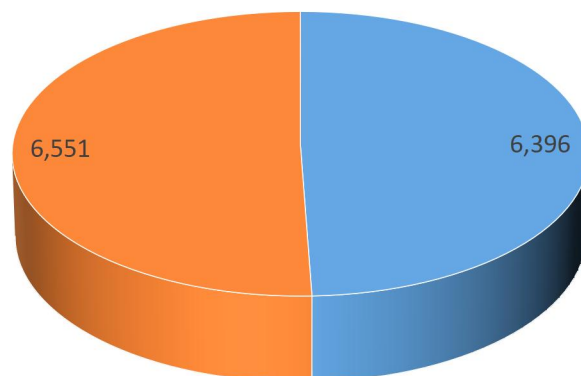
Fonte:PNI/MS:2026.



Fonte: PNI/MS: 2026.

Total de Doses Aplicadas Conforme Sexo
Município:Arcos
Ano:2024

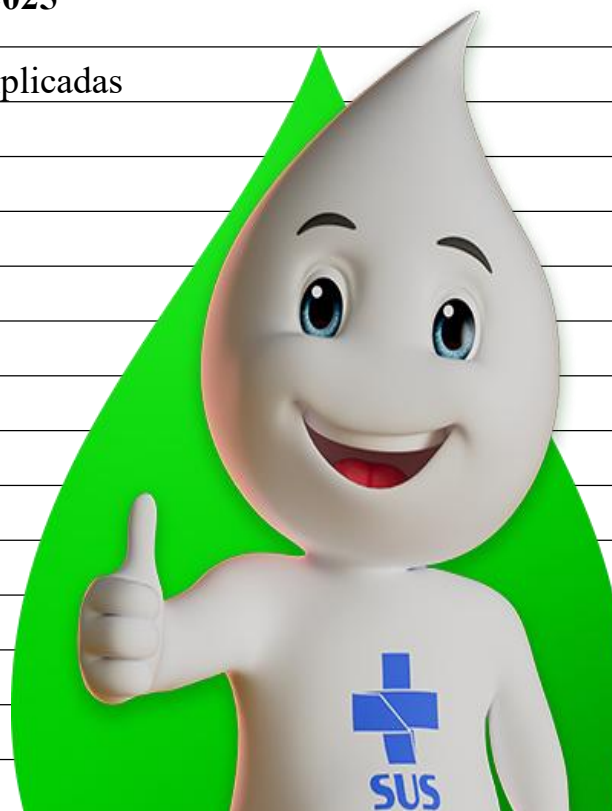
■ Feminino ■ Masculino



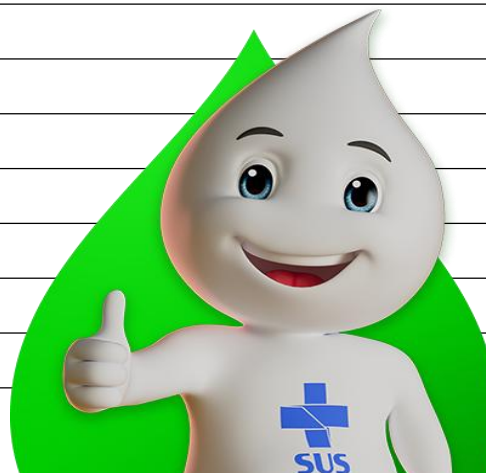
Fonte:PNI/MS:2026.

Panorama Vacinal :Ano 2025

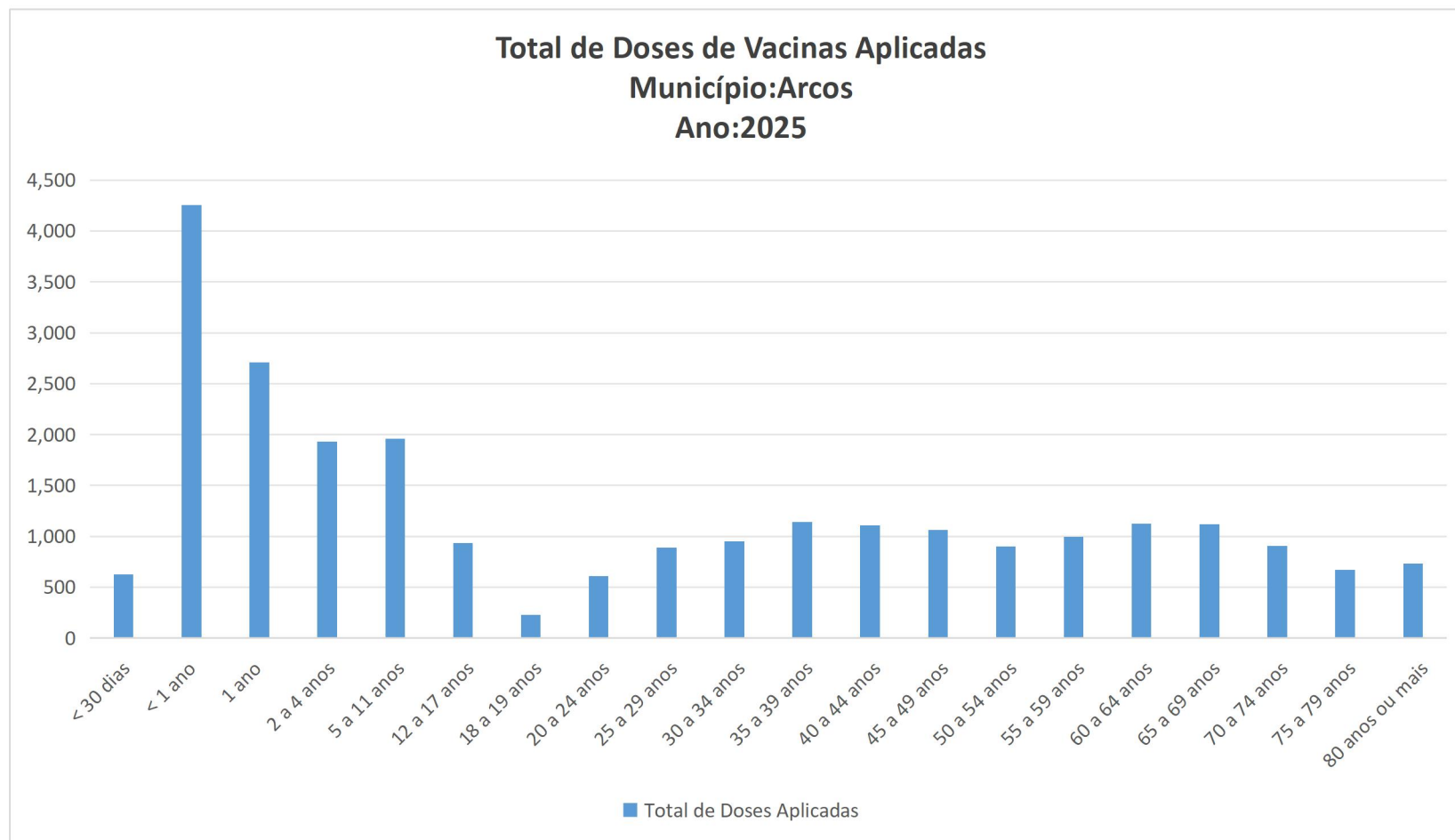
Total de Doses de Vacinas Aplicadas Conforme Faixa Etária Município:Arcos Ano:2025		
Faixa Etaria	Doses Aplicadas	
< 30 dias		625
< 1 ano		4.257
1 ano		2.710
2 a 4 anos		1.930
5 a 11 anos		1.961
12 a 17 anos		932
18 a 19 anos		229
20 a 24 anos		607
25 a 29 anos		888
30 a 34 anos		949
35 a 39 anos		1.140
40 a 44 anos		1.106
45 a 49 anos		1.063



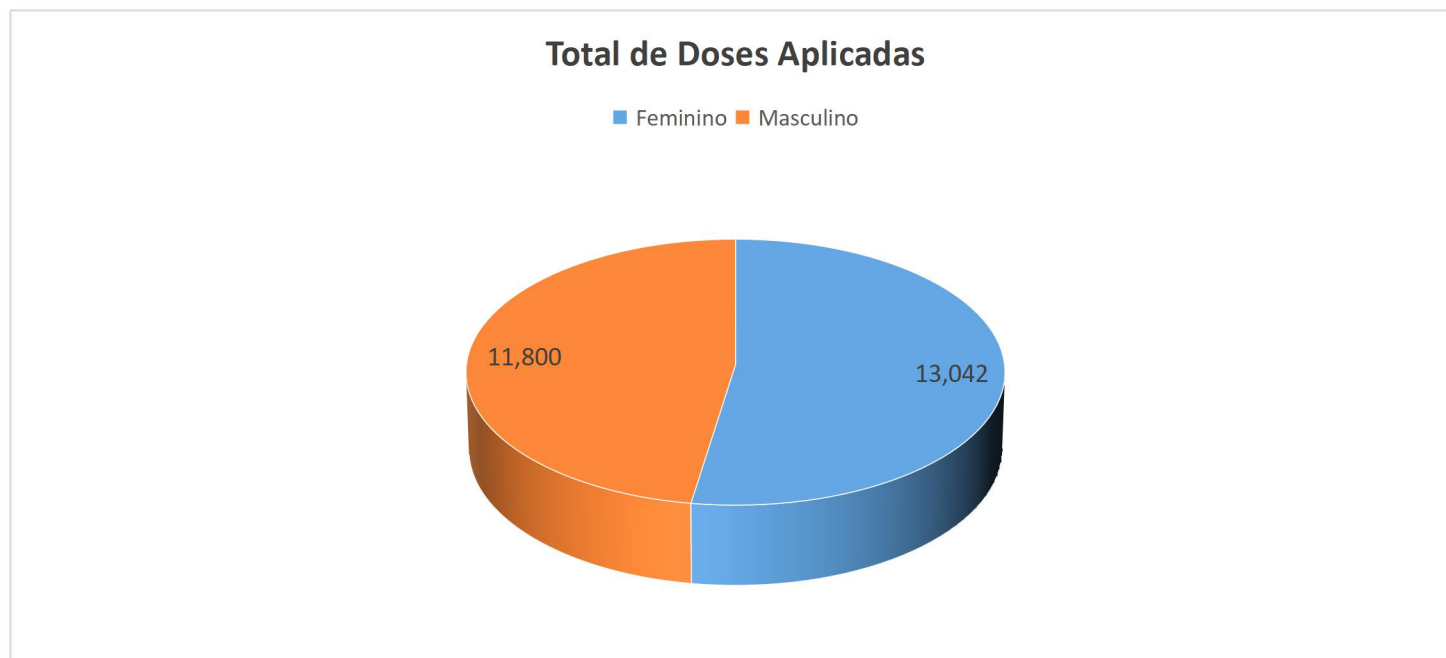
50 a 54 anos		901
55 a 59 anos		996
60 a 64 anos		1.122
65 a 69 anos		1.117
70 a 74 anos		906
75 a 79 anos		671
80 anos ou mais		732
Total de Doses Aplicadas		24.842



Fonte:PNI/MS:2026.



Fonte: PNI/MS:2026.



Fonte:PNI/MS:2026.

O aumento da homogeneidade da cobertura vacinal de rotina é fundamental na prevenção das doenças imunopreviníveis.O PNI -Programa Nacional de Imunização oferta vacinas em todo território nacional nos serviços de saúde de forma gratuita para toda população. Assim sendo a manutenção da credibilidade da população no programa de vacinação através da divulgação de informações relevantes é um ponto de grande importância para o o incentivo à descoberta de novas vacinas e a garantia da manutenção das doenças já erradicadas no Brasil.

5 Rede de Atenção à Saúde de Arcos

5 Rede de Atenção e Serviços de Saúde de Arcos

No Brasil, a organização do SUS sob os moldes de redes de atenção configura -se como uma estratégia para a consolidação dos princípios da universalidade, da equidade e da integralidade.

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) organizam-se por meio de pontos de atenção à saúde, locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção primária, secundária e terciária.

A articulação eficiente da rede de atenção à saúde garante o acesso a todos os níveis de atenção de forma igualitária e equinamente proporcionando a longitudinalidade do cuidado.

5.1 Rede de Estabelecimentos de Saúde

O município de Arcos conta com uma rede local de serviços à saúde composta pela Rede de Atenção Primária, Secundária e Terciária distribuídas conforme a explanação abaixo:

Rede de Atenção Primária
12 Equipes de Saúde da Família
01 UBS - Ilha
10 Equipes de Saúde Bucal vinculadas à UBS
01 Equipe de Saúde Bucal anexa à SMS
01 Equipe Multidisciplinar em Saúde (e-Multi Ampliada)
01 Equipe de Atenção Primária Prisional

Rede de Assistência Hospitalar
Hospitalar Geral - Santa Casa de Arcos

Rede de Atenção às Urgências e Emergências
Serviço de Atendimento Médico Móvel - SAMU - 192 -24 h
Hospital Municipal São José -Pronto Socorro 24 horas por dia

Rede de Atenção Psicossocial
CAPS I - Centro de Atenção Psico Social

Rede de Assistência Farmacêutica
01 Farmácia de Minas: Medicamentos Básicos, Estratégicos e Especializado
01 Farmácia Regional anexa UBS Brasília
01 Farmácia Regional anexa UBS Jardim Bela Vista
01 Farmácia Regional anexa UBS Santo Antônio
01 Farmácia Regional anexa UBS Zona Norte
01 Farmácia anexa ao Hospital Municipal São José
01 Farmácia anexa ao CAPS
Rede de Assistência Especializada
Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Ginecologia e Obstetrícia
Pediatria
Pneumologia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Urologia
Psiquiatria
Clínica de Fisioterapia Geral
Imaginologia - Ultra Som
Imaginologia - Mamografia
Imaginologia - RX
Laboratório de Análise Clínicas

Rede de Vigilância em Saúde
Vigilância Epidemiológica
Vigilância Ambiental - Endemias e Zoonoses
Vigilância Saúde do Trabalhador
Vigilância Sanitária

5.1.2 Atenção Primária à Saúde

Nas RAS o centro de comunicação é a Atenção Primária à Saúde (APS), sendo esta, a ordenadora do cuidado.

É considerada o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

O município de Arcos conta com 96.89% de cobertura de Atenção Básica, com 13 Unidades Básicas de Saúde: sendo 12 Equipes de Saúde da Família, e um Posto de Saúde no distrito da Ilha.

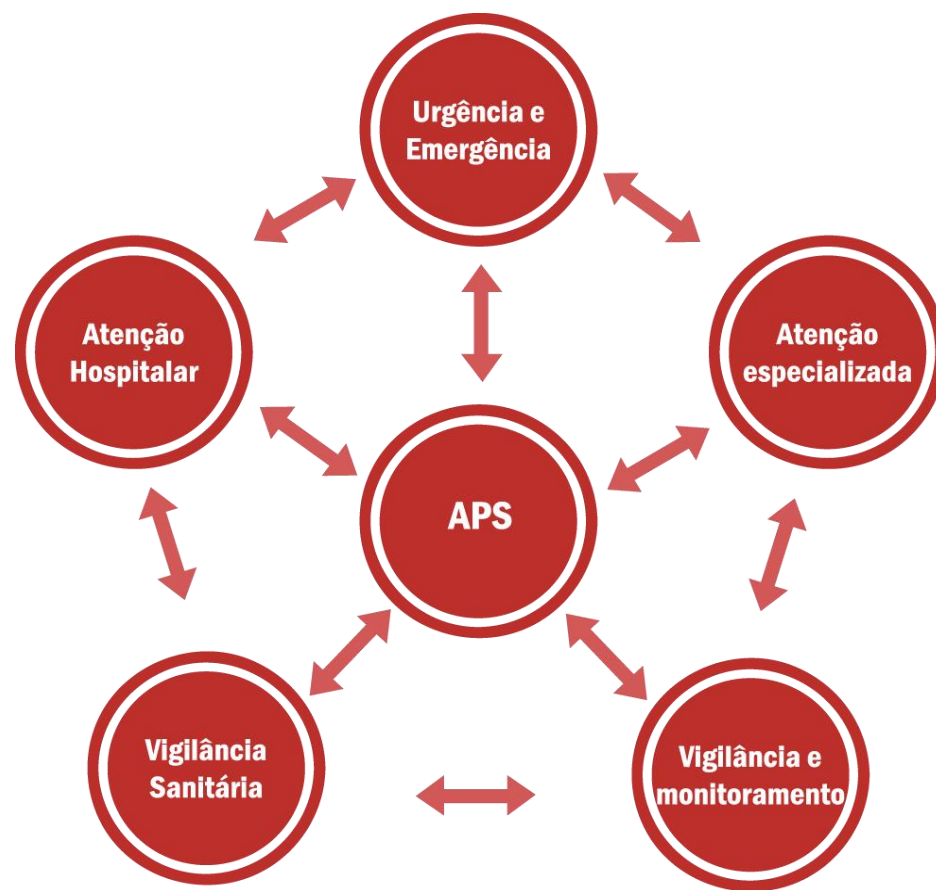
As Equipes de Saúde Bucal estão distribuídas no distrito da Ilha, nas ESF e na Secretária Municipal de Saúde.

Atenção Primária à Saúde (APS), trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde - SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

A APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

O município de Arcos conta com 96.89% de cobertura de Atenção Básica, com 13 Unidades Básicas de Saúde: sendo 12 Equipes de Saúde da Família, e um Posto de Saúde no distrito da Ilha. As equipes de Saúde Bucal estão distribuídas no distrito da Ilha, nas ESF e na Secretária Municipal de Saúde.

O município conta também com uma equipe de atendimento Multidisciplinar em Saúde (e-Multi). Este serviço conta com atendimento dos seguintes profissionais: psicólogo, educador físico, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social e fisioterapeuta.



5.1.3 Assistência Farmacêutica

A Assistência Farmacêutica (AF) é o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial. O medicamento é um fármaco elaborado com a finalidade de prevenir, tratar, curar, ou servir de diagnóstico para doenças.

Os objetivos da Assistência Farmacêutica são: garantir o acesso a medicamentos essenciais, eficazes e de custo efetivo; promover o uso prudente e seguro de medicamentos; promover o uso racional de medicamentos.

As principais ações da Assistência Farmacêutica são o fornecimento de medicamentos e insumos essenciais e a educação sobre o uso correto dos mesmos.

A Assistência Farmacêutica é composta por vários componentes, incluindo:

Básico (CBAF)	Medicamentos utilizados no âmbito da atenção básica em saúde,
Estratégico (CESAF)	Medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde e destinados ao tratamento de doenças que, por sua natureza, possuam abordagem terapêutica estabelecida, com perfil endêmico, que tenham impacto socioeconômico e sejam consideradas problemas de saúde pública.
Especializado (CEAF)	Tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, para algumas situações clínicas, principalmente, agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade e são fornecidos pelo Estado.

O município de Arcos conta com uma Farmácia de Minas, quatro farmácias regionais anexas as Unidades Básicas de Saúde do PSF Brasília, Jardim Bela Vista, Santo Antônio e Zona Norte, uma no Hospital Municipal São José e outra no CAPS.

A Assistência Farmacêutica do município apresenta a seguinte estrutura organizacional:

UNIDADE	ATRIBUIÇÃO
Farmácia de Minas Componente Básico e Estratégico CBAF e CESAF	Dispensação dos medicamentos básicos, estratégicos, central de abastecimento farmacêutico e distribuição para as farmácias regionais
Farmácia de Alto-custo Componente Especializado e Judicial CEAF	Montagem de processos e dispensação de medicamentos do Componente Especializado e dispensação de medicamentos de processos judiciais
Farmácia CAPS CBAF	Dispensação de medicamentos Básicos para atendimento da Saúde Mental
Farmácia Regional Norte (UBS Zona Norte) CBAF	Dispensação de medicamentos Básicos
Farmácia Regional Sul (UBS Brasília) CBAF	Dispensação de medicamentos Básicos

Farmácia Regional Leste (UBS Santo Antônio) CBAF	Dispensação de medicamentos Básicos
Farmácia Regional Oeste (UBS Jardim Bela Vista) CBAF	Dispensação de medicamentos Básicos
Farmácia Hospitalar (Hospital Municipal São José)	Dispensação de medicamentos para uso interno nos atendimentos de urgência/emergência
Farmácia Regional São José - CBAF	Dispensação de alguns medicamentos Básicos
Central de Abastecimento Farmacêutico das UBSs	Almoxarifado dos medicamentos de uso interno nas UBS municipais

5.1.4 Assistência Hospitalar

O município de Arcos conta com um Hospitalar Geral - Santa Casa de Arcos, que é uma instituição filantrópica de atendimento à saúde composta com 56 leitos, dos quais 70% são destinados às internações de pacientes pelo SUS, sendo os demais para internações particulares e convênios os 40 leitos destinados ao SUS, conta com 26 leitos Clínicos e Cirúrgicos 04 leitos de Saúde Mental e 10 leitos de UTI Adulto.

5.1.5 Rede de Atenção às Urgências e Emergências

Conforme classificação do Ministério da Saúde a Rede de Atenção às Urgências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas.

Diante da complexidade da necessidade da assistência o atendimento é 24 horas e destinados às diferentes condições de saúde: agudas ou crônicas agudizadas; sendo elas de natureza clínica, cirúrgica, traumatológica entre outras.

No município de Arcos a Rede de Atenção às Urgências é composta pelo SAMU 192 e pela UPA 24h - Hospital Municipal São José.

O serviço móvel de Urgência e Emergência - SAMU 192 - do município de Arcos é uma Unidade de Suporte Básico que presta o serviço pré-hospitalar móvel da Rede de Atenção às Urgências (RUE) do SUS, funcionando 24h para oferecer socorro rápido em emergências clínicas, traumáticas, obstétricas e psiquiátricas e demais demandas da população.

O SAMU é composto por ambulâncias, motorista socorrista e técnico de enfermagem que é acionado via ligação gratuita (192) do qual é direcionada a uma Central de Regulação, onde médicos reguladores orientam os primeiros procedimentos de estabilização no local e transporte para a unidade de saúde referenciada.

É gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste - CISURG Oeste mediante contrapartida financeira do município.

A Unidade de Pronto Atendimento- UPA 24h - Hospital Municipal São José é um serviço de urgência e emergência de complexidade intermediária que funciona ininterruptamente para estabilizar pacientes com casos clínicos, cirúrgicos ou traumáticos, suturas, medicação e observação, além de oferecer exames de raio-X e laboratório de análise clínicas

A Unidade de Pronto Atendimento- UPA 24h oferta assistência qualificada aos usuários, de forma integrada, articulada e sinérgica pautada na qualificação profissional, da informação, do processo de acolhimento e da regulação do acesso a todos os âmbitos da atenção hospitalar.

A UPA -24h mantém acesso constante com à Central de Regulação da Macro Oeste para o encaminhamento dos usuários para garantir o encaminhamento dos pacientes que necessitam de atendimento maior complexidade.

5.1.6 Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde atua diretamente nas ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à situação de saúde da população, a partir de um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados, no qual permite o planejamento e a implementação de medidas mais efetivas, baseada em evidências.

Congrega um espaço de construção de conhecimentos e técnicas que contempla uma rede de serviços ampla e eficiente, que atua de forma articulada e independente, distribuindo -se entre os seguintes eixos de atuação: Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Divisão de Vigilância



Vigilância Epidemiológica

Tem por finalidade promover a detecção e prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis bem como os agravos à saúde e seus fatores de risco, gerir e apoiar a operacionalização do Programa de Imunizações contribuindo para o controle, eliminação e/ou erradicação de doenças imunopreveníveis, bem como a contenção de surtos e epidemias.

Vigilância Ambiental

A Vigilância em Saúde Ambiental é considerada um conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde; coordenar as atividades de vigilância relacionadas aos contaminantes ambientais, sejam eles presentes na água, no ar ou no solo; desde que sejam de importância e repercussão na saúde pública.

A Vigilância em Saúde Ambiental é responsável também pela coordenação das atividades relacionadas aos riscos decorrentes de desastres naturais e tecnológicos, sejam eles advindos de acidentes com produtos perigosos ou advindos de barragens; assim como de outros eventos capazes de causar doenças e agravos à saúde humana.

Vigilância Sanitária

Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Atua na normatização, regulação, capacitação, por meio de ações de orientação e informação, estimulando a população à adoção de práticas sanitárias que busquem a promoção da saúde e prevenção de agravos e de doenças.

È responsável também pelo estabelecimento de parâmetros que priorizem ações que visem prevenir, diminuir ou eliminar os riscos sanitários de interesse coletivos da população, que estão acima de interesses individuais, de forma articulada com os diversos setores da saúde e de outras áreas e esferas de gestão.

Vigilância Saúde do Trabalhador

Vigilância dos fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionado aos processos ambientais e do trabalho, através de ações e políticas de saúde que proporcionam a prevenção, a promoção e a intervenção nos fatores de risco que interferem na saúde do trabalhador.

5.1.7 Atenção à Saúde Mental

O Centro de Atenção Psico Social - CAPS é um serviço especializado com sede no município de Arcos, é o componente central da Rede de Atenção Psicossocial focada no cuidado comunitário, humanizado e na desinstitucionalização. Proporciona o suporte integral e contínuo dos usuários, articulando fatores sociais, econômicos e emocionais.

O serviço conta com uma equipe multidisciplinar que oferece atendimentos de Psiquiatria, Psicologia, Terapia Ocupacional e Assistente Social.

5.1.8 Rede de Saúde Especializa Ambulatorial

A atenção especializada no município de Arcos é composta pela média complexidade e está distribuída nos ambulatórios de especialidades. No qual são contemplados as especialidades de pediatria, ortopedia, cardiologia, pneumologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia, oftalmologia entre outras especialidades médicas. O município conta também com o Centro de Fisioterapia que fornece atendimentos a toda população.

A maioria dos atendimentos das especialidades são procedentes da atenção primária que encaminha os pacientes conforme protocolo pré estabelecido.

5.1.9 Tratamento Fora de Domicílio.

Como forma de garantir a integralidade da assistência os serviços inexistentes no município ou de maior complexidade são referenciados mediante pactuação com os demais pontos de atenção a saúde fora do domicílio.

O município conta com uma frota de veículos que proporciona o acesso aos serviços de saúde fora do domicílio onde Também são disponibilizados três casas de apoio nas cidades de Belo Horizonte, Divinópolis e Barretos-SP para os usuário que necessitam permanecer fora de suas residências durante o período de tratamento de saúde.

Todo este aparato são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde integrados por um sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão de diferentes especificidades que permite percorrer os trajetos para o acesso aos diferentes pontos de atenção à rede de atenção à saúde visando a garantia da integralidade e da humanização do cuidado no SUS.

5.2 Rede de Recursos Humanos Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde de Arcos

Os recursos humanos na área da saúde envolve múltiplas dimensões, composição, formação e qualificação profissional para garantir um funcionamento das diversas instâncias envolvidas no processo de assistência.

Diante da ampla estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de Arcos/MG serão apresentados os profissionais ligados diretamente ao processo de assistência ,conforme disponibilizado no CNES.

Categoria Profissional	Quantitativo
Agente Comunitário de Saúde	69
Agente de Combate às Endemias	55
Arteterapeuta	01
Assistente Social	02
Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas	01
Auxiliar de Saúde Bucal	14
Biomedico	03
Condutor de Ambulância	16
Educador Físico na Saúde	04
Enfermeiro	20
Farmacêutico	11
Fisioterapeuta	11
Fonoaudiólogo	02
Odontólogo	20
Médico Cardiologista	01
Médico Clínico	16
Médico Dermatologista	01
Médico Endocrinologista e Metabologista	01
Médico Equipe Saúde da Família	12
Médico Ginecologista	01
Médico Ortopedista e Traumatologia	02
Médico Otorrinolaringologista	01
Médico Pediatra	05
Médico Pneumologista	01

Médico Psiquiatra	02
Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem	05
Médico Urologista	01
Nutricionista	03
Técnico de Enfermagem	102
Técnico de Radiologia e Imaginologia	06
Psicólogo Clínico	17
Veterinário	02

Fonte: cnes.saude.gov.br/ano:2025

6 Produção dos Serviços de Saúde

6 Produção dos Serviços de Saúde

Pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde a Saúde Pública brasileira tem vivenciado diversas transformações ao longo dos anos e a organização dos serviços de saúde tem passado por um processo significativo, evoluindo de modelos centralizados e hospitalocêntricos para as Redes de Atenção à Saúde (RAS) integradas, regionalizadas e hierarquizadas, visando universalidade, equidade e integralidade do cuidado.

O aumento nos atendimentos de saúde no Brasil tem sido impulsionado pela ampliação de ações estruturantes no SUS com uma crescente diversificação dos serviços na rede de assistência à saúde, o que consequentemente gera um volume exponencialmente maior de dados e informações sobre os serviços prestados.

Produção da Farmácia de Minas Município de Arcos Período: 2022 a 2025				
	Ano: 2022	Ano: 2023	Ano: 2024	Ano: 2025
Doses de Medicamentos Dispensadas	1.966.808	4.101.247	5.039.325	4.938.987
Atendimento Farmacêutico Individual	28.8 39	45.444	55.849	59.123

Produção Serviços de Saúde na Atenção Básica
Município de Arcos
Período: 2022 a 2025

	Ano: 2022	Ano: 2023	Ano: 2024	Ano:2025
Atendimento Médico Individual		63.081	182.706.669	27.285
Atendimento Individual do Enfermeiro		25.398	96.594.681	14.529
Atendimento Individual do Cirurgião Dentista				570
Atendimento Individual do Psicólogo		3.478	911.010	528
Atendimento Individual do Nutricionista		1.529		
Atendimento Individual do Fisioterapeuta		4.063		

Atendimento Individual do Fonoaudiólogo				
Atendimento do Educador Físico		02		
Assistente Social	*	*	*	
Visita Domiciliar do Agente Saúde		154.930	61.163	122.359

Fonte:sisab.saude.gov.br

*Antes de 2025 o município não contava com Assistente de Saúde nas UBS.

Produção Ambulatorial dos Serviços de Saúde Média Complexidade Município de Arcos Período: 2022 a 2025							
CBO	Código	Procedimento	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025
225125	0211020036	Eletrocardiograma	1.036	1.922	2.529	2.594	3.018
225112	0301010072	Médico Neurologista	-	-	-	632	546
225120	0301010072	Médico Cardiologista	800	876	2.886	2.765	3.227
225124	0301010072	Médico Pediatra	2.598	4.351	5.127	5.818	6.730
225127	0301010072	Médico Pneumologista	413	264	338	791	1068
225135	0301010072	Médico Dermatologista	764	972	858	311	817

225155	0301010072	Médico Endocrinologista e Metabologista	639	922	1.030	1035	985
225250	0301010072	Médico Ginecologista	529	1.071	1247	1252	115
225275	0301010072	Médico Otorrinolaringologista	2.404	156	588	683	625
225320	0204030188	Mamografia Bilateral para Rastreamento	64	0	0	0	398
225320	020502xxxx	Ultrassonografia	0	473	1.155	361	4839
223410	020201xxxx	Exames Laboratoriais	656	54.630	78.337	11.1897	75.539
225320	020401xxxx	Radiografias	71.107	9.213	11.792	15.973	16.072
223268	0301010048	Cirurgião Bucomaxilofacial	8.108	354	334	159	172
225270	0301010072	Médico Ortopedista e Traumatologia	276	2.834	3.951	4.637	4.055
225285	0301010072	Médico Urologista	234	887	1.179	1.177	867
225125	0301060029	Atendimento de urgência com observação até 24 horas	52.431	75.162	71.374	94.374	66.364
225125	0401010074	Pequenas Cirurgias (Exerese de tumor na pele e anexos)	951	294	-	869	-
223505	0301100012	Administração de Medicamentos Atensão Especializada.	23.456	44.238	46.529	55.530	74.855
223605	0302050027	Atendimento de Fisioterapia	2.160	4.800	6.300	7.800	12.720

Fonte:Sistema de Informação MAC/Local.2025

Conforme os dados apresentados na tabela de serviços assistenciais executados na Atenção Básica é possível identificar que não houve uma correspondente preocupação com as condições de produção dos dados e informações, uma vez que há uma deficiência no registro dos indicadores de atendimento de alguns segmentos profissionais, tendo em vista o baixo valor informado ou mesmo a carência absoluta de informação.

Esse cenário reflete uma grande discrepância com a realidade praticada e uma gama de indicadores distorcidos que gera um impacto negativo significativo na gestão pública, afetando a avaliação da qualidade e a produtividade da atenção básica, no financiamento e na qualidade do cuidado prestado aos pacientes, uma vez que a subnotificação de procedimentos esconde a real demanda de saúde da população, gerando uma falsa sensação de controle ou de necessidade de recursos.

Os principais desafios relacionados a falta de registro da produção dos serviços de saúde aponta para a necessidade de avaliação contínua do fluxo de trabalho, treinamento constante das equipes e o fortalecimento da tecnologia da informação nos estabelecimentos de saúde, bem como a integração entre os diferentes sistemas de informação que possibilita a visão integral do cuidado do paciente.

Com a expansão do Sistema Único de Saúde/SUS e as formas de gestão adotadas atualmente, a utilização de indicadores assistenciais no monitoramento do desempenho dos sistemas de serviços de saúde cresceu de forma significativa, estimulando a cultura de valorização da informação clínica, administrativa e de pesquisa, compartilhada por todos. Em resumo, o registro correto da produção em saúde não é apenas uma obrigação burocrática, mas uma ferramenta vital para garantir que o sistema de saúde seja mais eficiente, seguro e focado nas necessidades da população.

7 Finanziamento

7 Financiamento

A Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo federal, estadual e municipal , financiem o Sistema Único de Saúde (SUS),de modo que o financiamento seja tripartite, e provenientes de impostos e contribuições sociais em conformidade com os princípios de descentralização e corresponsabilidade, essenciais para a garantia do acesso aos serviços de saúde.

O Fundo de Saúde constitui um mecanismo de gestão financeira de recursos, vinculados ou alocados à Secretaria de Saúde para o cumprimento de seus programas e metas, e seus projetos e atividades orçamentárias, conforme previsões contidas no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde (CONASEMS, 2016).

O Fundo Municipal de Saúde de Arcos foi criado através da lei ... como forma de garantir transferências intergovernamentais de recursos financeiros para a área da saúde estabelecida pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

A Portaria 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que trata das atuais normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde estabelece que a transferência dos recursos financeiros passa a acontecer em duas contas bancárias, sendo uma no bloco de custeio, onde os recursos são destinados para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde e o bloco de investimento.

Essa modalidade de repasse promove o fortalecimento dos instrumentos de planejamento e de orçamento, flexibilizando o fluxo financeiro, além de permitir ao gestor gerenciar e aplicar adequadamente os recursos nas ações pactuadas e programadas.

As ações e os serviços devem constar no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde que deverão ser aprovadas pelo Conselho de Saúde.

Na Atenção Primária à Saúde (APS), o cofinanciamento federal é um componente essencial, viabilizando a manutenção das equipes de Saúde da Família, Atenção Primária, Saúde Bucal e equipes multiprofissionais, além de programas estratégicos no território.

De acordo com a Portaria GM/MS nº 3.493/2024 o novo modelo de financiamento da APS busca fortalecer a Estratégia Saúde da Família, reorganizando o financiamento de forma mais clara, induzindo a qualidade e a efetividade do cuidado.

A atual forma de financiamento é baseado na seguinte metodologia:

Componente fixo: para manutenção mensal das equipes e apoio à implantação de novas equipes.

Componente de vínculo e acompanhamento territorial: vinculado ao cadastramento qualificado, ao acompanhamento dos usuários e às condições de vulnerabilidade, com parâmetros de pessoas vinculadas por equipe, variando conforme o porte populacional do município.

Componente de qualidade: baseado em indicadores de desempenho pactuados, incentivando a melhoria do acesso, da qualidade e dos resultados em saúde. Outros componentes: para programas, serviços e ações estratégicas, saúde bucal e incentivo per capita populacional.

O modelo vigente garante previsibilidade e transparência, relacionando financiamento a resultados concretos, sem restringir o atendimento por ausência de cadastro prévio, mantendo a universalidade e integralidade da APS.

O novo financiamento é um passo consistente para a valorização da APS e da Estratégia Saúde da Família, induzindo os municípios a fortalecerem seus processos de trabalho, informatização, qualificação de cadastros e monitoramento contínuo dos indicadores, com vistas a ampliar o acesso e qualificar o cuidado ofertado à população.

Quanto ao financiamento federal da média e alta complexidade no SUS, os recursos federais destinados são transferidos de forma regular e automática ao fundo de saúde municipal; mediante a apuração da produção dos estabelecimentos de saúde, registradas pelos respectivos gestores nos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar SIA/SIH.

Porém, mesmo mediante a apresentação do serviço prestado para o repasse dos recursos financeiros, o financiamento federal da média e alta complexidade (MAC) ambulatorial e hospitalar é limitado por um teto financeiro, incompatível com o serviço prestado.

Essa incompatibilidade resulta em grandes dificuldades para manter o serviço ofertado, limitando o acesso à assistência aos serviços de saúde.

O subfinanciamento crônico da média e alta complexidade (MAC) ambulatorial e hospitalar impacta diretamente o município que é pressionado a complementar o financiamento com recursos próprios para evitar a interrupção de serviços, se tornado um dos principais desafios de gestão do sistema

7.1 Execução Orçamentária e Financeira

A Lei 141/2012 estabelece os valores mínimos obrigatórios para cada ente da federação de modo que os municípios (15%), estados (12%) e União (percentual variável baseado no PIB), visando garantir o valor empenhado no ano anterior acrescido de correção.

Planejar o financiamento, dos serviços públicos de saúde de forma a garantir a universalidade e integralidade do sistema, tem se mostrado, um grande desafio diante do subfinanciamento da saúde e as restrições orçamentárias para o setor, sobretudo a falta de recursos nos municípios e a necessidade premente de superá-las fazem com que as discussões sobre o financiamento ocupem constantemente a agenda dos movimentos sociais e políticos que atuam em defesa do SUS.

A seguir são demonstrados os principais indicadores financeiro do município de Arcos no período de 2022 a 2025:

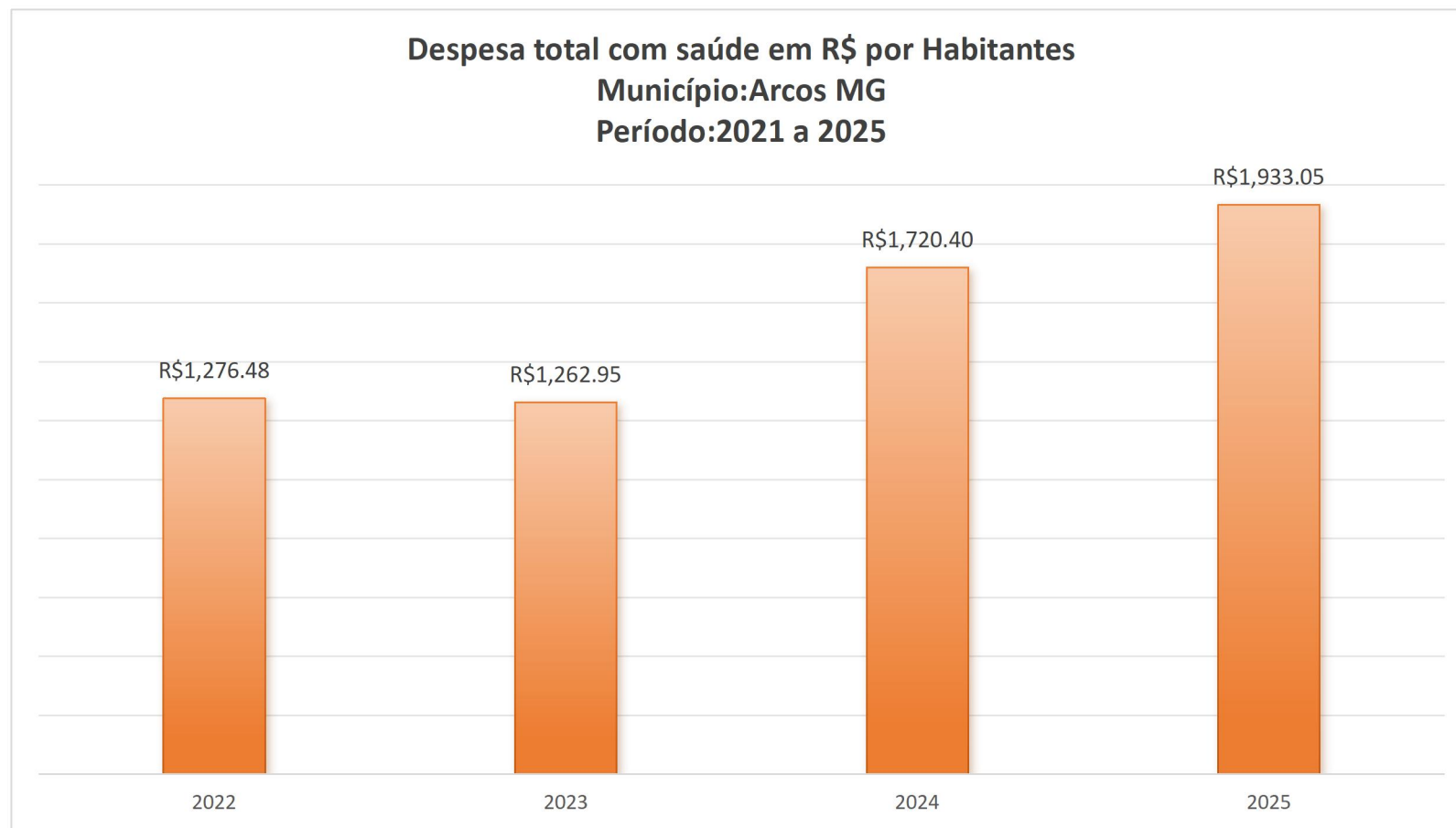
Indicador		Ano/Valor 2022	Ano/Valor 2023	Ano/Valor 2024	Ano/Valor 2025
	Indicador	%	%	%	%
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	10,88 %	13,32 %	13,06 %	12,52 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	81,35 %	78,07 %	80,98 %	81,68 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total	9,10 %	7,55 %	10,09 %	12,35 %

	de recursos transferidos para o Município				
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	52,97 %	76,25 %	73,63 %	76,57 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	12,36 %	13,64 %	16,38 %	21,48 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	63,30 %	65,41 %	66,41 %	67,77 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.276,48	R\$ 1.262,95	R\$ 1.720,40	R\$ 1.933,05

2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	49,04 %	46,84 %	41,94 %	40,55 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	5,09 %	7,57 %	6,12 %	4,91 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	17,66 %	20,32 %	14,44 %	10,71 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	5,16 %	6,85 %	9,62 %	5,02 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	10,56 %	11,07 %	16,09 %	22,47 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à	30,21 %	24,63 %	26,85 %	33,30 %

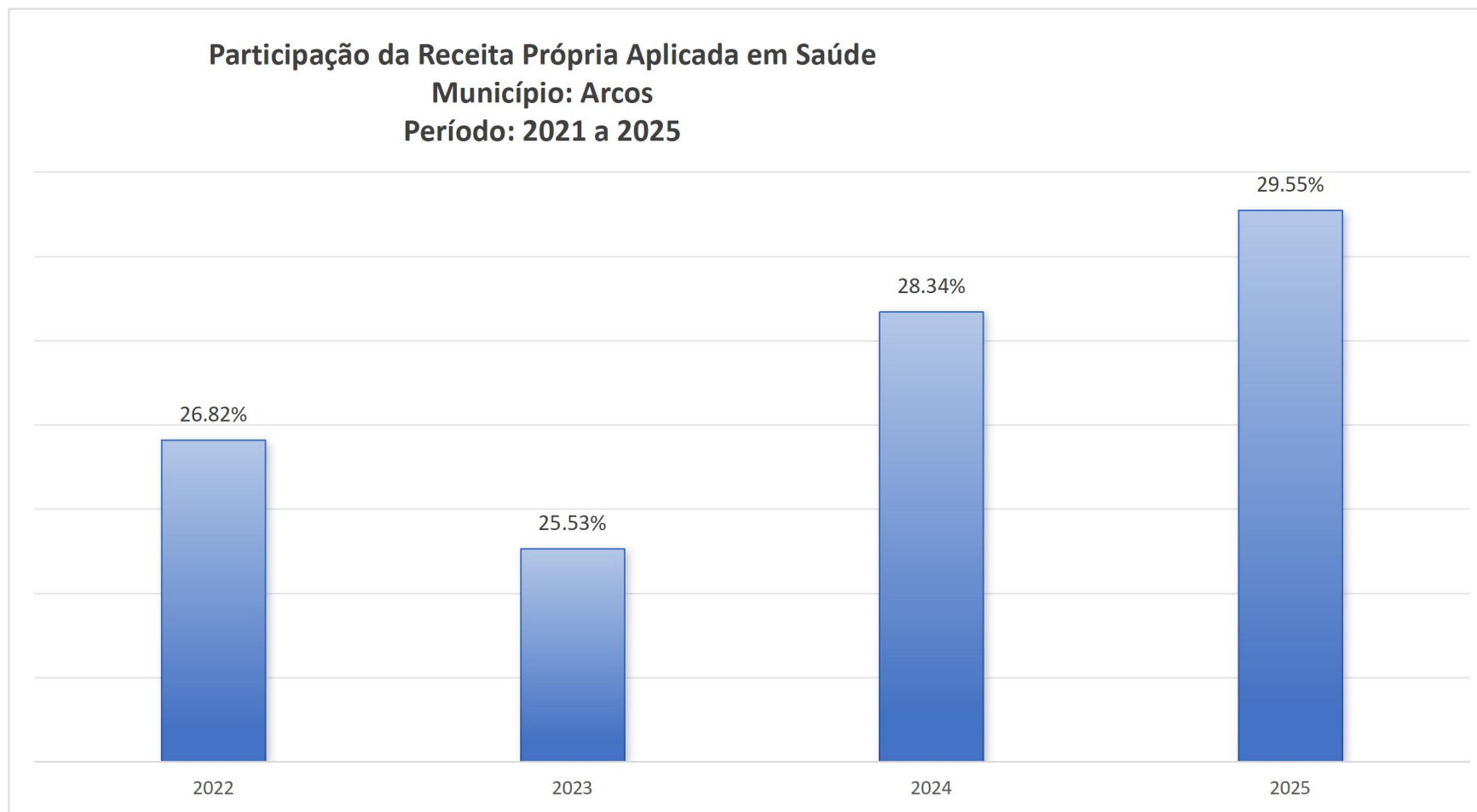
	despesa total do Município com saúde				
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	26,82 %	25,53 %	28,34 %	29,55 %

Fonte: Fonte: Digisus/2025 e 2026.

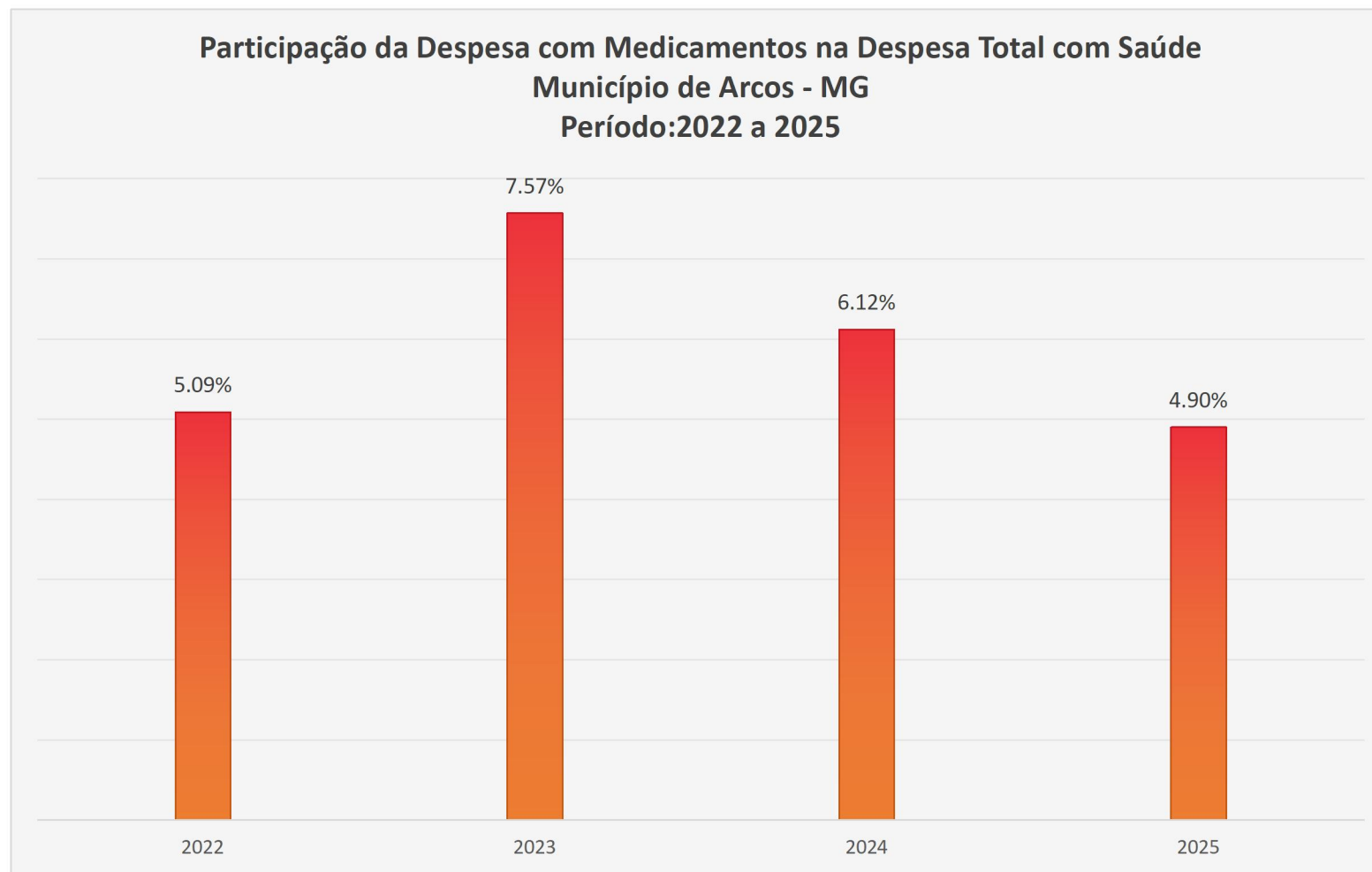


Fonte: Fonte: Digisus/2025 e 2026.

Participação da Receita Própria Aplicada em Saúde
Município: Arcos
Período: 2021 a 2025

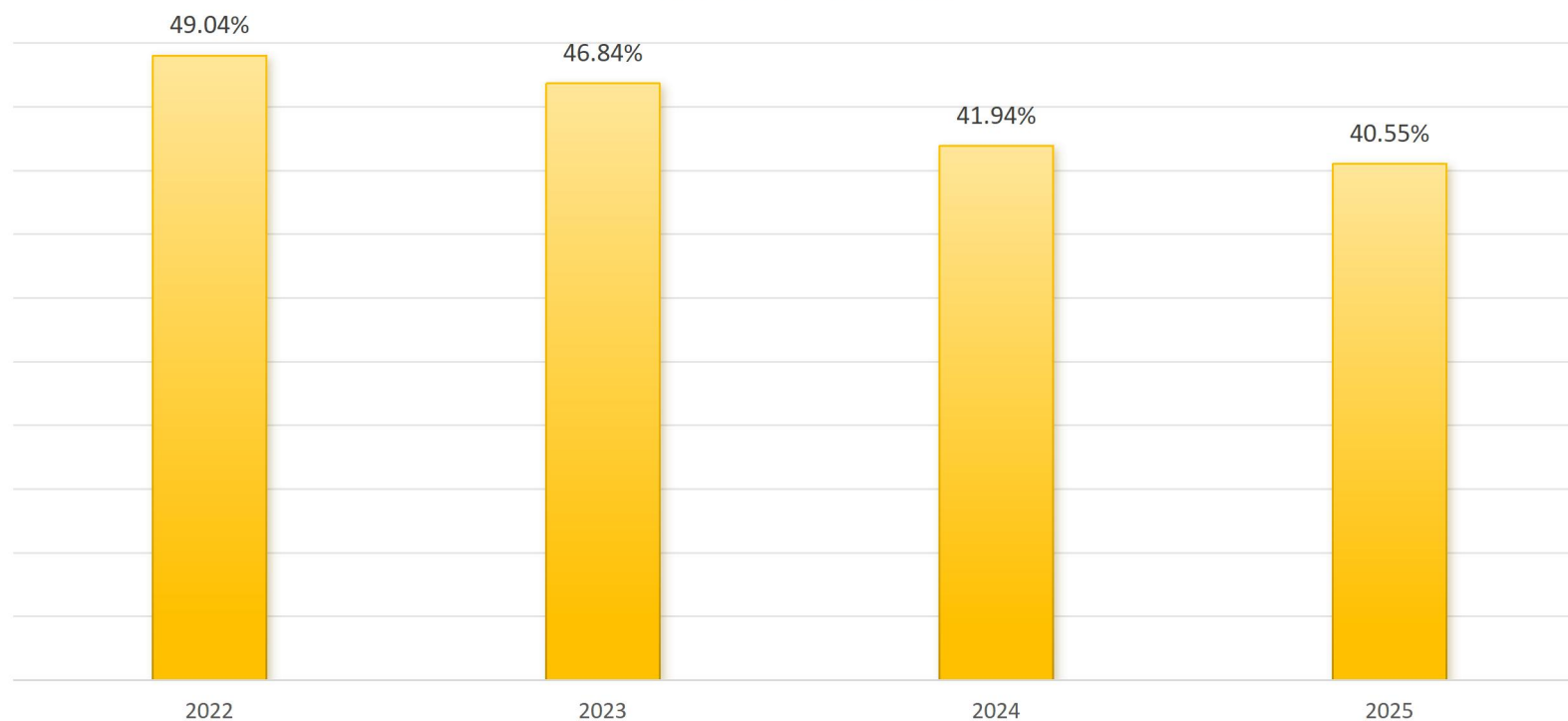


Fonte: Fonte: Digisus/2025 e 2026.



Fonte: Digisus/2025 e 2026.

Participação da Despesa com Pessoal na Despesa Total com Saúde
Município: Arcos
Período: 2022 a 2025



8 Diretrizes do Plano Municipal

Neste capítulo, são apresentados as Diretrizes, Objetivos e as Metas do Plano Saúde do Município de Arcos para os próximos quatro anos, os quais estão alinhados com o Plano Plurianual 2026-2029.

As Diretrizes,Objetivos e as Metas do Plano Saúde foram construídas a partir do relatório final da Conferência Municipal de Saúde 2025, juntamente com os diretores e referências técnicas da rede de atenção à saúde do município de Arcos.

As Diretrizes,Objetivos e as Metas do Plano estão disponíveis no DIGISUS onde estão apresentadas as metas quadrienais, conforme a anualização das Programações Anuais de Saúde.

9 Considerações Finais

O presente Plano Municipal de Saúde reafirma o compromisso da gestão pública com a promoção, proteção e recuperação da saúde da população de Arcos, através da organização da Rede de Atenção à Saúde e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

O planejamento proposto foi construído com base no diagnóstico situacional do território, nas necessidades epidemiológicas da população e no controle social.

A metodologia fundamenta-se em análises técnicas, baseada nos indicadores epidemiológicos, demográficos e socioeconômicos, extraídos de fontes seguras, atualizadas e de sistemas de monitoramento em tempo real.

A análise da situação de saúde não unificou a série temporal, pois considerou os dados mais recentes apresentados pelos sistemas de informações, com vista a uma análise fidedigna e real e da situação de saúde da população, permitindo assim a identificação de riscos, necessidades e a priorização de ações para orientar a tomada de decisão, baseadas em evidências.

Diante dos diversos-determinantes e condicionantes que envolvem a saúde, as metas descritas no plano foram estabelecidas de forma claras, mensuráveis e alcançáveis.

Como forma de avaliação do desempenho das metas propostas e do emprego dos recursos orçados, o PNS conta com os Relatórios de Gestão, instrumentalizados pelo RDQA e pelo RAG onde serão, explicitados os resultados alcançados com a execução da PAS, gerando subsídios para orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários.

Ressalta-se que o acompanhamento sistemático, a avaliação contínua dos indicadores e a transparência na gestão serão fundamentais para assegurar que as metas propostas sejam alcançadas, promovendo melhoria contínua da qualidade dos serviços e das condições de saúde da população de Arcos.

Por fim, o Plano Municipal de Saúde do Município de Arcos MG, referente ao quadriênio 2026 a 2029, é um instrumento norteador da gestão, do planejamento e da execução das políticas públicas de saúde garantindo que o conjunto de intervenções proposta produza impacto positivo e que os recursos disponíveis sejam utilizados de maneira eficiente e transparente, em benefício da saúde e do bem-estar da população.

10 Referências Bibliográficas

ARCOS.Secretaria Municipal de Saúde.**Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti**..Arcos MG:SMS,2025.

ARCOS.Secretaria Municipal de Saúde.**Sistema de Informações Ambulatorial do SUS (SIA/SUS): Produção Ambulatorial**.Arcos MG:SMS,2026.

ARCOS.Secretaria Municipal de Saúde.**Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)**..Arcos:SMS,2025.

ARCOS.Secretaria Municipal de Saúde.**Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)**..Arcos MG:SMS,2025.

BRASIL. Ministério da Saúde.CNES.**Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde**.Brasília: Ministério da Saúde,2025. Disponível em:<https://cnes.datasus.gov.br>.Acesso em:Acesso jan.2026.

BRASIL.Ministério da Saúde.Brasília.Ministério da Saúde.**Cobertura Vacinal** .Brasília: Ministério da Saúde,2026. Disponível:<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao>.Acesso em 24 de Fev.2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Informações de Saúde (TABNET): Epidemiológicas e Morbidade**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: tabnet.datasus.gov.br. Acesso em:set.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Informações de Saúde (TABNET): População residente - estudo de estimativas populacionais por município**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.Disponível :em:<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popsvsbr.def>. Acesso em:set.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle. **Sistemas de Informação da Atenção à Saúde: Contextos Históricos, Avanços e Perspectivas no SUS/Organização Pan-Americana da Saúde** – Brasília, 2015. Disponível em:

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS): Produção Hospitalar**. Brasília:

Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: datasus.saude.gov.br. Acesso em set.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde..Brasília: Ministério da Saúde.**Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde**:Brasília: Ministério da Saúde.Secretaria de Vigilância em Saúde,2023. Disponível em:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/vigilancia_doencas_agravos_na_o_transmissiveis_promocao_saude.pdf.Acesso em:set.2025

BRASIL. Ministério da Saúde.Brasília.**Sistema e Informação da Atenção Básica.SISAB**.Brasília: Ministério da Saúde,2026.Disponível :<https://sisab.saude.gov.br/>Acesso em:jan e fev.2026.

BRASIL. Ministério da Saúde.Brasília: Ministério da Saúde. **Situação da prevenção e controle das doenças transmissíveis no Brasil**.Brasília: Ministério da Saúde.Secretaria de Vigilância em Saúde,2004. Disponível em:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/saude_brasil.Acesso em:set/out.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde.Brasília: Ministério da Saúde.**Acidentes por Animais Peçonhentos**. Brasília: Ministério da Saúde.Disponível em:<https://portalsinan.saude.gov.br/acidente-por-animais-peconhentos>.https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/saude_brasil.Acesso em:set/out.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde.Brasília: Ministério da Saúde.**Caderneta da Pessoa Idosa**. Brasília: Ministério da Saúde,2023.Disponível:<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-idosa> em:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/saude_brasil.Acesso em:set/out.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde.Brasília: **Ministério da Saúde.Sistema e Informação da Atenção Básica -SISAB-** Brasília: Ministério da Saúde,2026.Disponível :<https://sisab.saude.gov.br/>Acesso em:jan e fev.2026.

BRASIL. Ministério da Saúde.DATASUS.**Sistema de Informações Ambulatorial do SUS (SIA/SUS): Produção Ambulatorial**.Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: datasus.saude.gov.br. Acesso em:Acesso nov.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <http://plataforma.saude.gov.br/natalidade/nascidos-vivos>. Acesso em: out/nov.2025

BRASIL.CONASEMS. **Orientações técnicas - Vigilância em Saúde**. Brasília, DF: Conasems, 2025. Disponível em: <https://portal.conasems.org.br>. Acesso em: 29 jan. 2026.

BRASIL.Ministério da Saúde.Brasília.**Módulo Planejamento Digisus Gestor**.Brasília: Ministério da Saúde,2025.Disponível em: <https://digisusgmp.saude.gov.br/>.Acesso em:dez.2025 e jan.2026.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Projeto Brasil Saúde Amanhã**. Rio de Janeiro,2016: Fiocruz,2016. Disponível em: <https://saudeamanha.fiocruz.br>.Acesso em:out.2025

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo demográfico 2022**: características gerais da população, resultados da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em:set.2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo demográfico 2022**: características gerais da população, resultados da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/arcs/panorama>.Acesso em:set.2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.**Projeção da População**. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: set. 2025.

MINAS GERAIS.Secretaria de Estado de Saúde. **Plano Diretor de Regionalização**.Belo Horizonte:Secretaria de Estado de Saúde de Minas

Gerais.Disponível em:<https://www.saude.mg.gov.br/estudos-assistenciais-e-regionalizacao>.Acesso em:set.nov.2025.

MINAS GERAIS.Secretaria de Estado de Saúde.**Vida no Trânsito**.Belo Horizonte:Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.Disponível em:<https://www.saude.mg.gov.br/vidano-transito>.Acesso em:set.2025.

LISTA DE SIGLAS

AF - Assistência Farmacêutica
AIH - Autorizações de Internação Hospitalar
APS - Atenção Primária à Saúde
ATB - Atenção Básica
Anvisa- Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
CIS-URG - Consórcio Intermunicipal de Saúde em Urgência e Emergência
Equipe de Saúde da Família ESF – Estratégia de Saúde Família
FMS – Fundo Municipal de Saúde
FNS – Fundo Nacional de Saúde
CMS - Conselho Municipal de Saúde
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
DANT - Doenças e Agravos Não Transmissíveis
DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis
IBGE – Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística
IPP - Índice de Infestação Predial
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LIRA - Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti
RAS - Rede de Atenção à Saúde
RAG - Relatório de Gestão
RAPS - Rede de Atenção Psicossocial
RDQA - Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SUS - Sistema Único de Saúde
MAC - Média e Alta complexidade
MS - Ministério da Saúde
OMS - Organização Mundial de Saúde
PA – Pronto Atendimento- Organização Mundial de Saúde
PAS - Programação Anual de Saúde
PIB - Produto Interno Bruto
PDR - Plano Diretor de Regionalização
PNI - Programa Nacional de Imunização
PPI -Programação Pactuada e Integrada
SIA - Sistema de Informação Ambulatorial
SIGAF – Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica
SIH - Sistema de Informação Hospitalar
SIM - Sistema de Informação Mortalidade
SINASC - Sistema de Informação de Nascidos Vivos
SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SIOPS - Sistema de Informação Orçamento Público em Saúde
SISAB - Ministério da Saúde.Sistema e Informação da Atenção Básica
SRAG - Síndrome Respiratória Aguda Grave
SG - Síndrome Gripal
UBS – Unidade Básica de Saúde
UTI - Unidade Terapia Intensiva
VISA - Vigilância Sanitária

Resumo do Plano de Saúde

Estado: Minas Gerais

Município: Arcos - MG

Região de Saúde: Formiga

Período do Plano de Saúde: 2026-2029

Data de finalização: 26/03/2026 20:44:32

Status atual do Plano de Saúde: Aprovado

Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano de Saúde

DIRETRIZ Nº 1 - DIRETRIZ Nº 1 - Propiciar a melhoria contínua da gestão pública por meio do aprimoramento da governança integrada com municípios e regiões de saúde, da desburocratização, do financiamento sustentável, transparente e eficiente, bem como da valorização dos trabalhadores de saúde, visando a qualidade no cuidado e acolhimento humanizado dos profissionais e agentes sociais do SUS, incluindo os conselheiros, representantes do controle social.

OBJETIVO Nº 1.1 - OBJETIVO Nº 1.1 - Gerir recursos com foco em resultados, respeitando as especificidades do município, por meio da qualificação das estratégias de financiamento, do fortalecimento da gestão do trabalho e da educação em saúde, valorizando e qualificando os trabalhadores do SUS, com vistas a promover a integralidade da assistência, a universalidade do acesso e o enfrentamento à precarização.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
1.1.1	Prover o setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de recursos humanos e materiais.	Número de setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde Provido de recursos humanos e materiais.	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
1.1.2	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o setor administrativo da SMS.	Número de equipamentos e materiais permanentes adquiridos para o setor administrativo da SMS.	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
1.1.3	Implementar o projeto de reforma administrativa da SMS.	Percentual de projeto de reforma administrativa implementado	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	50,00	75,00	100,00
1.1.4	Realizar capacitação permanente dos profissionais de saúde, em todos os pontos de atenção à saúde, com foco na humanização do atendimento e do cuidado.	Percentual de profissionais de saúde de todos os pontos de atenção à saúde, capacitados com foco na humanização do atendimento e do cuidado.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	50,00	75,00	100,00
1.1.5	Manter e atualizar mensalmente os cadastros no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, segundo normas do Ministério da Saúde.	Número de atualizações mensais dos cadastros no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, segundo normas do Ministério da Saúde.	12	2024	Número	48	Número	12	12	12	12
1.1.6	Monitorar, avaliar e atualizar a Programação Pactuada e Integrada (PPI) no âmbito municipal e demais municípios integrantes.	Número de monitoramentos, avaliações e atualizações da Programação Pactuada e Integrada (PPI) no âmbito municipal e demais municípios integrantes.	12	2025	Número	48	Número	12	12	12	12
1.1.7	Realizar auditoria sobre a produção de serviços de saúde, públicos e privados que prestam serviços para o SUS em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação assistencial.	Número de auditorias sobre a produção de serviços de saúde, públicos e privados que prestam serviços para o SUS em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação assistencial	12	2025	Número	48	Número	12	12	12	12
1.1.8	Monitorar e avaliar mensalmente os contratos celebrados entre a prefeitura e os prestadores, em conformidade com o planejamento da atenção à saúde e realizando as adequações necessárias.	Número de monitoramentos e avaliações mensais dos contratos celebrados entre a Prefeitura e os prestadores, em conformidade com o planejamento da atenção à saúde e realização das adequações necessárias.	12	2025	Número	48	Número	12	12	12	12
1.1.9	Monitorar e avaliar mensalmente os procedimentos realizados pelos prestadores contratados e conveniados	Número de monitoramentos e avaliações mensais dos procedimentos realizados pelos prestadores contratados e conveniados.	12	2025	Número	48	Número	12	12	12	12
1.1.10	Atualizar, acompanhar e avaliar a demanda reprimida referente aos Tratamentos Dentro do Domicílio - TDD e Tratamentos Fora do Domicílio – TFD.	Número de atualizações, acompanhamentos e avaliações da demanda reprimida referente aos Tratamentos Dentro do Domicílio - TDD e Tratamentos Fora do Domicílio – TFD.	12	2025	Número	48	Número	12	12	12	12
1.1.11	Elaborar e implantar o Manual de Regulamentação dos Serviços de Transporte Público Sanitário.	Elaboração e implantação do Manual de Regulamentação dos Serviços de Transporte Público Sanitário.	1	2025	Número	1	Número	1	0	0	0
1.1.12	Elaborar e implantar o Manual de Normatização do Tratamento Fora Domicílio - TFD.	Manual de Normatização do Tratamento Fora Domicílio – TFD elaborado e implantado.	1	2025	Número	1	Número	1	0	0	0
1.1.13	Elaborar e implantar o Manual da Carteira de Serviços do Setor de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria.	Manual da Carteira de Serviços do Setor de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria elaborado e implantado	1	2025	Número	1	Número	1	0	0	0

OBJETIVO Nº 1.2 - OBJETIVO Nº 1.2- Assessorar o gestor, coordenadores e referências técnicas na execução do objeto de contratos e convênios, disponibilizar equipamentos, materiais, insumos e medicamentos necessários para o adequado funcionamento das unidades da rede de atenção à saúde. Compras, Contratos e Convênios.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
1.2.1	Adquirir materiais permanentes e equipamentos para a rede de atenção à saúde.	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para a rede de atenção à saúde.	1	2025	Número	100	Número	1	1	1	1
1.2.2	Adquirir materiais de consumo para a rede de atenção à saúde.	Aquisição de materiais de consumo para a rede de atenção à saúde.	1	2025	Número	100	Número	1	1	1	1

OBJETIVO Nº 1.3 - OBJETIVO Nº 1.3 - Assessorar o gestor, coordenadores e referências técnicas nas demandas referentes à judicialização da saúde, contribuindo para melhoria da gestão em saúde. Judicialização da Saúde.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
1.3.1	Monitorar mensalmente o cumprimento das demandas judiciais e seus respectivos custos que compõem ao município o fornecimento de medicamentos, insumos e procedimentos assistenciais da saúde.	Monitoramentos mensais das demandas judiciais cumpridas e seus respectivos custos que compõem ao município o fornecimento de medicamentos, insumos e procedimentos assistenciais da saúde.	12	2025	Número	48	Número	12	12	12	12

OBJETIVO Nº 1.4 - OBJETIVO Nº 1.4 - Promover e fortalecer com eficiência e qualificação a prática do planejamento, monitoramento e avaliação na rede de atenção à saúde - SUS.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
1.4.1	Manter referência técnica com qualificação especializada para coordenar as atividades de gestão em saúde.	Número de referências técnicas com qualificação especializada para coordenar as atividades de gestão em saúde.	2	2025	Número	8	Número	2	2	2	2
1.4.2	Atualizar, monitorar e avaliar o cumprimento das metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde 2026 - 2029.	Atualização, monitoramento e avaliação do cumprimento das metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde 2026 - 2029.	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1
1.4.3	Elaborar o Plano Municipal de Saúde.	Plano Municipal de Saúde 2026 – 2029 elaborado.	1	2025	Número	1	Número	1	0	0	0
1.4.4	Elaborar a Programação Anual de Saúde - PAS.	PAS elaborada.	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1
1.4.5	Elaborar o Relatório Anual de Gestão - RAG.	RAG elaborado.	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1
1.4.6	Enviar o RAG ao Conselho Municipal de Saúde até o dia 30 de março de cada ano.	RAG enviado ao Conselho Municipal de Saúde até o dia 30 de março de cada ano.	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1
1.4.7	Elaborar, enviar e apresentar ao Conselho Municipal de Saúde os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior – RDQA's.	Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior – RDQA's elaborados, enviados e apresentados ao Conselho Municipal de Saúde	3	2025	Número	12	Número	3	3	3	3
1.4.8	Apresentar os RDQAs em audiência pública na Câmara Legislativa.	Número de apresentações dos RDQAs em audiência pública na Câmara Legislativa.	3	2025	Número	12	Número	3	3	3	3
1.4.9	Realizar reuniões periódicas com os coordenadores e referências técnicas dos setores da Secretaria Municipal de Saúde.	Número de reuniões realizadas com os coordenadores e referências técnicas dos setores da Secretaria Municipal de Saúde.	10	2025	Número	40	Número	10	10	10	10
1.4.10	Elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, junto aos coordenadores e técnicos da SMS.	Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO elaborada	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1
1.4.11	Elaborar a Lei Orçamentária Anual - LOA, junto aos coordenadores e técnicos da SMS	Lei Orçamentária Anual – LOA elaborada.	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1
1.4.12	Realizar a análise econômica dos setores da SMS.	Número de análises econômicas dos setores da SMS realizadas.	3	2026	Número	12	Número	3	3	3	3
1.4.13	Definir cronograma de educação permanente para a rede de atenção à saúde pública de Arcos.	Cronograma de educação permanente para a rede de atenção à saúde pública de Arcos.	3	2025	Número	12	Número	3	3	3	3
1.4.14	Contratar consultorias para qualificação da gestão e da rede de atenção à saúde pública de Arcos.	Contratação de consultorias para qualificação da gestão e da rede de atenção à saúde pública de Arcos	1	2026	Número	4	Número	1	1	1	1
1.4.15	Monitorar mensalmente os investimentos/despesas com saúde.	Monitoramentos mensais dos investimentos/despesas com saúde	12	2026	Número	48	Número	12	12	12	12
1.4.16	Enviar relatórios de receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde ao Conselho Municipal de Saúde	Número de relatórios de receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde enviados ao Conselho Municipal de Saúde.	12	2026	Número	48	Número	12	12	12	12

DIRETRIZ Nº 2 - DIRETRIZ Nº 2 - Fortalecer as instâncias de controle social ampliando os canais de interação do usuário com garantia de transparência.

OBJETIVO Nº 2.1 - OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer as instâncias de participação social e pactuação no SUS. Ouvidoria e Controle Social.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
2.1.1	Garantir recursos financeiros, para atendimento das demandas do Conselho Municipal de Saúde (CMS).	Proporção de atendimento as demandas financeiras do CMS garantidas.	100,00	2026	Proporção	100,00	Proporção	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.2	Criar um canal de comunicação, vinculado ao CMS para acolher usuários e profissionais de saúde.	Número de canal de comunicação criado e mantido	1	2026	Número	4	Número	1	1	1	1
2.1.3	Promover um evento de promoção da saúde com parcerias trimestralmente.	Número de eventos promovidos pelo CMS por ano.	4	2026	Número	16	Número	4	4	4	4
2.1.4	Criar e efetivar os conselhos locais (controle social), criando espaços de discussões entre a comunidade e a equipe de saúde para trabalharem as questões/demandas de saúde da comunidade.	Número de conselhos locais (controle social) criados e em funcionamento.	2	2026	Número	14	Número	2	3	4	5
2.1.5	Fortalecer o controle social por meio de estímulos e participação na reuniões ordinárias e extraordinárias do CMS.	Proporção entre o número de reuniões realizadas pelo CMS e número de participação da gestão.	100,00	2026	Proporção	100,00	Proporção	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6	Participar de reuniões com instâncias colegiadas e SES para estabelecer o modelo de gestão e pactuações.	Proporção entre o número de reuniões do COSEMS, da CIR e SES e número de participação da gestão.	100,00	2026	Proporção	100,00	Proporção	100,00	100,00	100,00	100,00

DIRETRIZ Nº 3 - Diretriz Nº 3: Potencializar as redes de atenção á saúde de forma integral, intersetorial, matriciada e regionalizada para fortalecer e ampliar a Atenção Primária á Saúde como ordenadora do cuidado, proporcionar oferta equânime de políticas públicas de Atenção Secundária e Terciária, reduzir os vazios assistenciais e prover acolhimento no cuidado.

OBJETIVO Nº 3.1 - Objetivo 3.1– Fortalecer a Atenção Primária á Saúde como ordenadora do cuidado, qualificando a infraestrutura, provendo equipes completas multi e interdisciplinares, ampliando a cobertura, aumentando a resolubilidade e a realização de ações intersetoriais, para aproximar os serviços da cidadã e do cidadão com vistas a garantir a universalidade e a equidade, considerando raça e genero

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.1.1	Manter as despesas com pessoal de todos os profissionais que atuam nas Equipes de Atenção Primária a Saúde no município.	Percentual de despesas com pessoal mantidas	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.2	Prover as Unidades de APS e eMULTI de recursos materiais como material de consumo alimentar e de higiene, material de escritório, material de limpeza, material médico hospitalar, medicamentos, insumos e recursos necessários	Proporção de unidades de APS providas de materiais e insumos	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.3	Prover as unidades de APS com recursos humanos por meio de contratação ou locação de mão de obra.	Proporção de unidades de APS providas	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.4	Adquirir e distribuir materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita. - Tiras de glicemia. - Seringas de insulina. - Lancetas. - Glicosímetros	Percentual de materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita adquiridos e distribuídos, conforme protocolo de atenção às pessoas com diabetes.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

3.1.5	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para as unidades de Atenção Primária. e eMulti	Proporção de unidades de APS provida	100,00	2025	Proporção	100,00	Proporção	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.6	Adquirir computadores, impressoras, tablets, e outros suprimentos de informática para todas as equipes de APS e eMULTI	Proporção de unidades de APS providas	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.7	Alcançar a habilitação no MS da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).	Unidade EAPP Habilitada no MS	1	2025	Número	1	Número	1	0	0	0
3.1.8	Adquirir Veículos para transporte dos profissionais que atuam na ATB e eMulti do município.	Número de veículos adquiridos	2	2025	Número	8	Número	2	2	2	2
3.1.9	Criar lei municipal para recebimento de gratificação para os profissionais Enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, médicos, Equipe multiprofissional, Odontólogos e ASB, recepcionistas, auxiliares de serviços gerais, que atuam na atenção primária à Saúde.	Número de Lei criada	1	2025	Número	1	Número	11	1	1	1
3.1.10	Reestruturar a área física das unidades de saúde	Proporção de unidades de saúde que tiveram suas áreas físicas reestruturadas	75,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	50,00	75,00	100,00
3.1.11	Ampliação e Reforma das UBS's São Judas ,Eldorado, Santo Antônio e Olaria.	Porcentagem de realização de reformas	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.12	Construção da Sede Própria das UBS: Zona Norte, Floresta/Pinheiros, Calcita, Esplanada e São Vicente.	Percentual de UBS em construção	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.13	Implantação de UBS itinerantes nas comunidades rurais: Calciolândia, Boca da Mata, Varões,São Domingos,Sobradinho e adajacentes	Unidades Itinerantes Implantadas	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.14	Implantar o Programa; Sábado tem Saúde, instituindo o calendário anual de atendimentos aos sábados pelas Equipes de Atenção Primária.	Implantação do Programa Sábado tem Saúde.	-	-	Número	1	Número	0	1	0	0
3.1.15	Incluir a atenção à população LGBTQIA+ na programação da Atenção Primária à Saúde	Inclusão da atenção à população LGBTQIA+ na programação da Atenção Primária à Saúde.	1	2025	Número	1	Número	1	0	0	0
3.1.16	Ampliar a oferta das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) pelas Equipes de Atenção Primária à Saúde	Percentual de Equipes que ofertam Práticas Integrativas e Complementares (PICs) na Atenção Primária.	5,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	15,00	25,00	50,00	75,00
3.1.17	Credenciamento de laboratórios para realização de exames laboratoriais eletivos, via tabela SUS.	Laboratórios credenciados	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1
3.1.18	Criação de cargo para atender às novas demandas da saúde e às exigências dos Conselhos de Classe	Cargos criados	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
3.1.19	Ampliar para 100% a cobertura da Atenção Primária à Saúde	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.20	Garantir o 70 % de atendimento da demanda programada e 30 % da demanda espontânea realizados por profissional de APS .	Número total de atendimentos conforme demanda específica X 100 Número total de atendimento por todos os tipos de demanda.	70,00	2025	Percentual	70,00	Percentual	70,00	70,00	70,00	70,00
3.1.21	Realizar mensalmente visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde a todas as famílias cadastradas na micro área	Número de visitas realizadas por família	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

3.1.22	Acompanhar, na Atenção Primária, 80% dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde nas condicionalidades de saúde.	Percentual de beneficiários do PBF com perfil saúde acompanhados nas condicionalidades de saúde na Atenção Primária	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
3.1.23	Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar/SAD	Número de SAD Implantado	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
3.1.24	Realizar o Processo Seletivo para os ACS's e ACE	Número de Processo Seletivo para ACs e ACE executados.	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
3.1.25	Redimensionar o território de abrangência das ESF favorecendo o acesso e a equidade no acompanhamento das famílias.	Número de ESF com território redimensionado.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.26	Contratação de empresa de Segurança para as UBS	Número de ESF com serviço de segurança implantado	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.27	Aquisição de Aparelho de Telefone Celular para realização de Tele Consultas	Número de Telefone Celular adquiridos conforme solicitação	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.28	Realizar reuniões periódicas com a coordenação da Atenção Primária	Número der reuniões realizadas com a coordenação da Atenção Primária	12	2025	Número	12	Número	12	12	12	12
3.1.29	Manter a cobertura populacional de acompanhamento do estado nutricional superior a 60%.	Percentual da população acompanhada; (Nº avaliação nutricional registrada ÷ População estimada) × 100.	60,00	2025	Percentual	60,00	Percentual	60,00	60,00	60,00	60,00
3.1.30	Garantir atendimento psicológico a pelo menos 60% dos usuários com demanda identificada.	Percentual de usuários que receberam atendimento psicológico. (Pacientes em atendimento ÷ Fila de espera identificada) × 100.	60,00	2025	Percentual	60,00	Percentual	60,00	60,00	60,00	60,00
3.1.31	Promover no mínimo três ações de promoção e prevenção em saúde mental.	Número de ações de promoção em saúde mental realizadas.	3	2025	Número	12	Número	3	3	3	3
3.1.32	Contratar empresa para realização de pequenos reparos estruturais na UBS, garantindo agilidade na resolução dos problemas.	Câmaras refrigeradas e equipamentos essenciais com manutenção em dia	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.33	Garantir a manutenção bimestral das câmaras refrigeradas e equipamentos essenciais.	Câmaras refrigeradas e equipamentos essenciais com manutenção em dia	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.34	Adquirir e disponibilizar equipamentos de proteção individual para os ACS's: Protetor solar, máscaras	Número de ESF que tiveram ACS complementados com EPIs	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.35	Instituir o repasse de Incentivo Financeiro por Desempenho aos profissionais da Equipe Multiprofissional (eMulti) e demais profissionais da Atenção Primária à Saúde.	Incentivo Financeiro por Desempenho aos profissionais da Equipe Multiprofissional (eMulti) e demais profissionais da Atenção Primária à Saúde Implantado	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
3.1.36	Garantir o pagamento da Insalubridade a todos os profissionais da ATB e eMULTI	Pagamento da Insalubridade efetuado a todos os profissionais da ATB e eMULTI	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

OBJETIVO Nº 3.2 - OBJETIVO 3.2: Fortalecer a atuação da APS frente às condições crônicas e evitáveis e no envelhecimento saudável.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.2.1	Reduzir, progressivamente, o percentual de internações por causas sensíveis à Atenção Primária à Saúde até 2029.	% de internações hospitalares classificadas como ICSAP (SIH/SUS, e Gestor).	41,00	2024	Percentual	30,00	Percentual	38,00	35,00	32,00	30,00
3.2.2	Contratar exames de Hemoglobina Glicada	Número de exames de Hemoglobina Glicada Ofertados	15	2025	Número	60.000	Número	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2.3	Garantir que 75% das pessoas com diabetes vinculadas à APS realizem pelo menos uma consulta presencial ou remota com médico ou enfermeiro a cada seis meses.	Percentual de diabéticos que realizaram consulta. (Diabéticos que realizaram consulta ÷ Total de diabéticos na APS) × 100.	75,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.2.4	Alcançar 75% das pessoas com diabetes com ao menos uma solicitação ou avaliação de hemoglobina glicada nos últimos doze meses.	Percentual de diabéticos com ao menos uma solicitação ou avaliação registrada nos últimos 12 meses. (Diabéticos com solicitação ou resultado registrado ÷ Total de diabéticos na APS) × 100.	75,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.2.5	Assegurar que 75% das pessoas com diabetes tenham pelo menos um registro de avaliação dos pés nos últimos doze meses.	Percentual de diabéticos com registro de avaliação dos pés. (Diabéticos com avaliação registrada ÷ Total de diabéticos) × 100.	75,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.2.6	Garantir que 75% das pessoas com hipertensão realizem ao menos uma consulta presencial ou remota com médico ou enfermeiro a cada seis meses.	Percentual de hipertensos que realizaram consulta no semestre. (Hipertensos com consulta registrada ÷ Total de hipertensos na APS) × 100.	75,00	-	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.2.7	Garantir que 80% das pessoas idosas realizem pelo menos uma consulta com profissional médico ou enfermeiro, presencial ou remota, nos últimos doze meses	Percentual de pessoas idosas com ao menos uma consulta no ano. Fórmula: (Nº de idosos com consulta realizada ÷ Nº total de idosos cadastrados) × 100.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2.8	Atingir 80% de cobertura vacinal contra influenza entre os idosos, com registro de ao menos uma dose aplicada nos últimos doze meses	Percentual de idosos vacinados contra influenza no ano. Fórmula: (Nº de idosos vacinados contra influenza ÷ Nº total de idosos cadastrados) × 100.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2.9	Realizar a estratificação de risco para fragilidade de idosos para 80% dos idosos do município.	Porcentagem de idosos estratificados. (Idosos estratificados ÷ idosos.) × 100.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
3.2.10	Realizar ações de rastreamento e orientação sobre câncer de próstata em ao menos 15% dos homens com 50 anos ou mais cadastrados na APS.	Cobertura de ações educativas ou rastreamento de câncer de próstata em homens ≥50 anos. (Nº de homens ≥50 anos com ações registradas ÷ Nº total de homens ≥50 anos cadastrados) × 100.	15,00	2025	Percentual	15,00	Percentual	15,00	15,00	15,00	15,00
OBJETIVO Nº 3.3 - OBJETIVO 3.3: Qualificar a atuação das equipes da APS.											

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.3.1	Realizar capacitações anuais com foco em qualificação da equipe da Atenção Primária.	Nº de capacitações realizadas e % de profissionais participantes.	2	2024	Número	2	Número	2	2	2	2
3.3.2	Promover capacitação para todas as equipes das UBS, com foco na qualificação do atendimento ao usuário (ex.: curso de libras, atendimento humanizado, primeiro socorros, acolhimento e gestão).	Número de Capacitações realizadas	4	2025	Número	12	Número	4	4	4	4

OBJETIVO Nº 3.4 - OBJETIVO 3.4: Melhorar a infraestrutura física, tecnológica e logística da Atenção Primária à Saúde

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.4.1	Renovar ou adquirir, até 2029, equipamentos permanentes essenciais para o funcionamento da Unidade de Saúde da Família do município.	% de aquisição dos equipamentos prioritários previstos no levantamento técnico.	0,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	50,00	70,00	85,00	100,00
3.4.2	Adquirir uma unidade odontológica móvel para atendimento à população que reside na zona rural.	Número de unidade odontológica móvel adquirida	0	-	Número	1	Número	0	1	0	0
3.4.3	Garantir a manutenção bimestral das câmaras refrigeradas e equipamentos essenciais.	Câmaras refrigeradas e equipamentos essenciais com manutenção em dia	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

OBJETIVO Nº 3.5 - Objetivo 3.5 - Ampliar a cobertura de Saúde Bucal como forma de garantia da Integralidade à Assistência a Saúde.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.5.1	Ampliar para 100% a cobertura populacional das Equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária	Percentual de cobertura populacional das Equipes de Saúde Bucal na Atenção Básica	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5.2	Realizar no mínimo uma ação de promoção e prevenção a saúde bucal por quadrimestre.	Número de de promoção e prevenção a saúde bucal realizadas.	3	2025	Número	12	Número	3	3	3	3
3.5.3	Alcançar 5% de primeiras consultas programadas pela equipe de saúde bucal	Percentual de primeiras consultas odontológicas programadas. (Número de pessoas com primeiras consultas odontológicas programadas realizadas ÷ Número total de pessoas vinculadas à equipe de referência) × 100	5,00	2025	Percentual	5,00	Percentual	5,00	5,00	5,00	5,00
3.5.4	Atingir 75% de tratamentos concluídos após a primeira consulta programada	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos. (Número de pessoas com tratamento odontológico concluído ÷ Número de pessoas com a primeira consulta odontológica programada realizada) × 100.	75,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.5.5	Manter em até 8% o número de exodontias realizadas pela equipe de saúde bucal	Percentual de exodontias realizadas. (Número total de exodontias realizadas ÷ Número de total de procedimentos individuais preventivos, curativos e exodontias realizadas) × 100	8,00	2025	Percentual	8,00	Percentual	8,00	8,00	8,00	8,00
3.5.6	Atingir 1% de cobertura da ação coletiva da escovação dental supervisionada em crianças de 6 a 12 anos matriculadas no ensino fundamental	Percentual de cobertura da escovação supervisionada em escolares. (Número de crianças de 6 a 12 anos contempladas na ação coletiva de escovação supervisionada ÷ Número total de pessoas vinculadas à equipe de referência) × 100.	1,00	2025	Percentual	1,00	Percentual	1,00	1,00	1,00	1,00
3.5.7	Alcançar ao menos 85% de procedimentos odontológicos preventivos realizados pelas equipes de Saúde Bucal Percentual de procedimentos preventivos em saúde bucal.	Percentual de procedimentos preventivos em saúde bucal. (Número de procedimentos odontológicos preventivos individuais realizados ÷ Número total de procedimentos odontológicos preventivos individuais e coletivos realizados) × 100.	85,00	2025	Percentual	85,00	Percentual	85,00	85,00	85,00	85,00
3.5.8	Atingir 8% dos procedimentos restauradores realizados como Tratamento Restaurador Atraumático (ART)	Percentual de restaurações realizadas por ART. (Número de atendimentos com procedimentos restauradores atraumáticos (ART) realizados ÷ Número total de atendimentos com procedimentos restauradores realizados) × 100.	8,00	2025	Percentual	8,00	Percentual	8,00	8,00	8,00	8,00

OBJETIVO Nº 3.6 - Objetivo 3.6 Proporcionar o Cuidado Integral à Saúde das Mulheres em todas as fases da vida.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.6.1	Alcançar a proporção de 100 % de gestantes cadastradas nas ESF com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação.	Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.6.2	Garantir que 100% das gestantes cadastradas nas ESF realizem a primeira consulta do pré natal em até 12 semanas de gestação.	Porcentagem de gestantes com consulta realizada. (Gestantes com primeira consulta em até 12 semanas ÷ Gestantes)	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.6.3	Assegurar que 100% das gestantes cadastradas nas ESF realizem testes rápidos ou exames para sífilis, HIV e hepatites B e C no primeiro trimestre de gestação	Porcentagem de gestantes com testes realizados. (Gestante com testes realizados ÷ gestantes) × 100.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

3.6.4	Assegurar que 100% das gestantes cadastradas nas ESF realizem testes rápidos ou exames para sífilis e HIV no terceiro trimestre de gestação Porcentagem de gestantes com testes realizados. (Gestante com testes realizados ÷ gestantes) × 100.	Porcentagem de gestantes com testes realizados. (Gestante com testes realizados ÷ gestantes) × 100.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.6.5	Garantir que 90% das puérperas cadastradas nas ESF recebam ao menos uma visita domiciliar por ACS	Porcentagem de puérperas com visitas realizadas. (Puérperas com visitas realizadas ÷ crianças) × 100.	90,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
3.6.6	Garantir que 90% de gestantes cadastradas nas ESF tenham pelo menos sete registros simultâneos de peso e altura durante a gestação	Porcentagem de gestantes com sete consultas realizadas. (Gestantes com consulta realizada ÷ gestantes) × 100.	100,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
3.6.7	Alcançar 90% das gestantes com pelo menos três visitas domiciliares realizadas por ACS após a primeira consulta de pré-natal	Porcentagem de gestantes com visitas realizadas. (Gestantes com visitas realizadas ÷ crianças) × 100	100,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
3.6.8	Atingir 90% das gestantes vacinadas com uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação Porcentagem de gestantes vacinadas (Gestantes vacinadas ÷ crianças)	Atingir 90% das gestantes vacinadas com uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação Porcentagem de gestantes vacinadas (Gestantes vacinadas ÷ crianças) × 100	90,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
3.6.9	Alcançar 60% de gestantes com pré-natal na Atenção Primária à Saúde que realizaram atendimento odontológico individual com Equipes de Saúde Bucal	Proporção de gestantes com pelo menos 01 atendimento odontológico realizado.	60,00	2025	Percentual	60,00	Percentual	60,00	60,00	60,00	60,00
3.6.10	Garantir que 90% das puérperas recebam ao menos uma visita domiciliar por ACS	Porcentagem de puérperas com visitas realizadas. (Puérperas com visitas realizadas ÷ crianças) × 100.	90,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
3.6.11	Alcançar 48% de mulheres usuárias do SUS na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico de rastreamento realizado nos últimos 3 anos.	Percentual de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico de rastreamento realizado nos últimos 3 anos	48,00	2025	Percentual	48,00	Percentual	48,00	48,00	48,00	48,00
3.6.12	Alcançar 35% de mulheres usuárias do SUS na faixa etária de 50 a 69 anos com realização de mamografias de rastreamento nos últimos 2 anos	Percentual de mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos com realização de mamografias de rastreamento nos últimos 2 anos	35,00	2025	Percentual	35,00	Percentual	35,00	35,00	35,00	35,00
3.6.13	Assegurar que 80% de meninas entre 9 e 14 anos tenham registro de ao menos uma dose da vacina HPV no período de acompanhamento	Percentual de meninas entre 9 e 14 anos vacinadas contra HPV. (Nº de meninas vacinadas ÷ Nº de meninas de 9 a 14) × 100.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
3.6.14	Realizar ações de Promoção de vida saudável as mulheres de 9 a 69 anos	Número de ações realizadas para o público alvo	1	2025	Número	4	Número	1	1	1	1

OBJETIVO Nº 3.7 - Objetivo 3.7 Promover ações de promoção à saúde e prevenção de danos à criança, de forma humanizada, em tempo oportuno e com resolutividade.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.7.1	Garantir que 100% das crianças cadastradas nas ESF realizem a primeira consulta por médico ou enfermeiro em até 30 dias de vida.	Percentual de crianças com consulta realizada até 30 dias de vida. $(\text{Crianças com consulta realizada} \div \text{Crianças até dois anos}) \times 100$.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.7.2	Atingir 75% das crianças cadastradas nas ESF realizam pelo menos nove consultas realizadas por médico ou enfermeiro até dois anos.	Percentual de crianças com nove consultas realizadas até dois anos de vida $\div$ Crianças até dois anos de idade $\times 100$	75,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.7.3	Atingir 75% das crianças cadastradas nas ESF com ao menos nove registros de peso e altura até dois anos de idade.	Percentual de crianças com registro de peso e altura até dois anos de idade. $(\text{Crianças com peso e altura registrado} \div \text{crianças até dois anos de idade}) \times 100$.	75,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.7.4	Alcançar 75% das crianças cadastradas nas ESF com duas visitas domiciliares realizadas por ACS, sendo uma até trinta dias de vida e outra até seis meses.	Porcentagem de crianças com visitas realizadas. $(\text{Crianças com visitas realizadas} \div \text{crianças}) \times 100$.	75,00	2025	Percentual	75,00	Percentual	75,00	75,00	75,00	75,00
3.7.5	Realizar teste do pezinho em 100% dos nascidos vivos.	Percentual de Nascidos vivos com teste realizado nascidos vivos.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
3.7.6	Alcançar 80% da Cobertura da Avaliação do Frênulo Lingual em Recém Nascidos	Alcançar 80% de Cobertura da avaliação do Frênulo Lingual em Recém Nascidos.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
3.7.7	Implantar a Triagem Auditiva Neonatal - TAN	Serviço Triagem Auditiva Neonatal - TAN implantado	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
OBJETIVO Nº 3.8 - Objetivo 3.8:Incorporar a Promoção da Saúde no SUS, através do conceito ampliado de saúde para além dos muros das unidades de saúde, através de práticas multidisciplinares (E-MULTI) e do reconhecimento das demais políticas e tecnologias existentes, visando à qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e riscos à saúde .											

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
3.8.1	Implantar teleconsulta para pacientes com mobilidade reduzida e residentes em áreas rurais, garantindo no mínimo 27 consultas/mês.	Numero de atendimentos realizados	324	2025	Número	1.296	Número	324	324	324	324
3.8.2	Realizar 12 campanhas anuais em comunidades rurais e de difícil acesso para divulgação e orientação sobre os serviços da EMULTI.	Número de campanhas realizadas em comunidades rurais e de difícil acesso	12	2025	Número	48	Número	12	12	12	12
3.8.3	Promover ações junto a comunidade escolar das escolas pactuadas no Programa Saude na escola - PSE e demais escolas do município. Com os temas prioritarios Prevenção da violência e promoção da cultura da paz, Verificação da situação vacinal, Saúde sexual e reprodutiva, Alimentação saudável e Saúde Menta	Numero de ações PSE realizadas	13	2025	Número	52	Número	13	13	13	13
3.8.4	Promover oficinas ou rodas de conversa com familiares/cuidadores sobre os direitos, cuidado e autonomia da pessoa com deficiência ou neurodivergência com foco na sensibilização sobre deficiência e neurodiversidade para a comunidade (ex: Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, Abril Azul).	Numero de ações e campanhas realizadas ao público alvo	3	2025	Número	12	Número	3	3	3	3
3.8.5	Garantir que o acolhimento psicológico reconheça e aborde questões relacionadas a racismo e sofrimento psíquico da população negra.	Taxa de adesão aos atendimentos psicológicos por usuários autodeclarados negros.	15,00	2025	Percentual	60,00	Percentual	15,00	15,00	15,00	15,00
3.8.6	Oferecer ações educativas individuais, ao casal e em grupo, e acesso a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade de modo a organizar o processo de planejamento reprodutivo garantindo acesso a metodos definitivos.	Número de ações educativas realizadas no quadrimestre.	6	2025	Número	24	Número	6	6	6	6
3.8.7	Implantação do Programa Academia da Saúde.	Academia da Saúde Implantada	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
3.8.8	Contratação de mais Educadores físicos para ampliar o horário dos grupos ofertados no município.	Número de Profissionais de Educação Física Contratados	2	2025	Número	2	Número	-	2	-	-
3.8.9	Fomentar a oferta de Práticas Integrativas e Complementares no âmbito da Atenção Primária à Saúde, a fim de ampliar, diversificar e potencializar as ações de cuidado integral e humanizado e satisfação do usuário	Razão entre o Número de modalidades de PICs ofertadas na APS e o Número de atendimentos em PICs realizados/mês.	390	2025	Número	1.320	Número	330	330	330	330
3.8.10	Ampliar oferta de grupos terapêuticos e de artesanato como estratégia de promoção de saúde mental e integração comunitária.	Número de grupos ativos	5,00	2025	Percentual	20,00	Percentual	5,00	5,00	5,00	5,00

DIRETRIZ Nº 4 - Diretriz 4: Promover as Ações de Promoção à Saúde através da Articulação e Integração da Rede de Atenção à Saúde.

OBJETIVO Nº 4.1 - Objetivo 4.1:Redução dos Riscos e Agravos à Saúde da População, por meio das Ações de Promoção e Vigilância em Saúde em todos os Níveis de Atenção.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
4.1.1	Alcançar 95% dos registro de óbito com causa básica definida	Porcentagem do registro de óbitos com causa básica definida.	95,00	2025	Percentual	95,00	Percentual	95,00	95,00	95,00	95,00

4.1.2	Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 5 óbitos ao ano.	Taxa de mortalidade infantil	5	2025	Número	5	Número	5	5	5	5
4.1.3	Alcançar 90% das notificações de óbito materno em até 30 dias da data de ocorrência .	Porcentagens de notificações de óbito materno em até 30 dias da data de ocorrência.	90,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
4.1.4	Alcançar 80% das notificações de óbito infantil em até 30 dias da data de ocorrência.	Porcentagens de notificações de óbito infantil em até 30 dias da data de ocorrência.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
4.1.5	Aumentar para 78% a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação	78,00	2025	Percentual	78,00	Percentual	78,00	78,00	78,00	78,00
4.1.6	Aumentar para 85% a proporção de contatos examinados dos casos novos de tuberculose.	Proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose diagnosticados nos anos das coortes.	85,00	2025	Percentual	85,00	Percentual	85,00	85,00	85,00	85,00
4.1.7	Aumentar para 85% a proporção de contatos examinados dos casos novos de hanseníase	Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85,00	2025	Percentual	85,00	Percentual	85,00	85,00	85,00	85,00
4.1.8	Reduzir para 35% o percentual de casos de sífilis congênita.	Percentual de casos de sífilis congênita	35,00	2025	Percentual	35,00	Percentual	35,00	35,00	35,00	35,00
4.1.9	Realizar vigilância, investigação e análise de 100% dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil	Percentual dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil investigados e analisados.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.10	Encerrar a investigação de pelo menos 90% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI), registrados no SINAN, em até 60 dias.	Percentual de DNCI encerrados em até 60 dias (Casos encerrados em até 60 dias ÷ Total de DNCI) × 100	90,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
4.1.11	Notificar 100% dos casos identificados de violência interpessoal, autoprovocada e violência sexual.	Percentual de casos notificados de violência interpessoal, autoprovocada e sexual. (Casos notificados ÷ Casos identificados) × 100	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.12	Notificar e acompanhar 100% dos casos de sífilis congênita em menores de um ano.	Percentual de casos notificados e acompanhados de sífilis congênita. (Casos notificados e acompanhados ÷ Casos identificados) × 100.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.13	Notificar 100% dos casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho.	Percentual de notificações realizadas de agravos relacionados ao trabalho. (Casos notificados ÷ Casos identificados) × 100	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.14	Investigar 100% dos acidentes de trabalho típicos que resultaram em óbito e amputação, e típicos e de trajeto com crianças e adolescentes.	Percentual de acidentes de trabalho graves investigados (Acidentes investigados ÷ Acidentes identificados) × 100	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.15	Promover no mínimo uma capacitação em Saúde do Trabalhador para os profissionais da atenção primária e vigilância.	Número de capacitações realizadas	2	2025	Número	2	Número	2	2	2	2
4.1.16	Realizar capacitação dos profissionais de saúde da Rede sobre os temas relevantes de Vigilância em Saúde	Número de capacitações realizadas por ano (1 por trimestre).	3	2025	Número	12	Número	3	3	3	3
4.1.17	Atingir no mínimo 80% das ações do VIGIMINAS	Percentual de ações do VIGIMINAS executadas. (Ações realizadas ÷ Ações previstas) × 100.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
4.1.18	Garantir fornecimento de uniformes, EPIs e materiais de trabalho para todos os ACEs	Uniformes, Matérias de trabalho e EPI em quantidade adequada para a execução das atividades da Vigilância Ambiental e Zoonoses	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.19	Alcançar cobertura vacinal de (95%) para 5 vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 1 ano de idade: Penta (DTP + Hep B + Hib), Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Tríplice Viral e Febre Amarela	Percentual de cobertura adequada (95%) das vacinas Penta, Poliomielite, Pneumocócica 10 valente, Tríplice Viral e Febre Amarela em crianças menores de 1 ano de idade	95,00	2025	Percentual	95,00	Percentual	95,00	95,00	95,00	95,00

OBJETIVO Nº 4.2 - Objetivo 4.2:Reduzir os impactos advindos do meio ambiente através da Vigilância Ambiental por meio da identificação e monitoramento dos fatores de risco físicos, químicos e biológicos do meio ambiente que podem afetar a saúde humana.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
4.2.1	Alcançar 100% das ações de vigilância de qualidade da água para consumo humano	Percentual de ações de vigilância da qualidade da água para consumo.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.2	Atingir 85% do número mínimo mensal de análises para os parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, conforme a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e inseridas no Sisagua..	Percentual de análises de água realizadas. (Análises realizadas ÷ Análises mínimas previstas) × 100	85,00	2025	Percentual	85,00	Percentual	85,00	85,00	85,00	85,00
4.2.3	Reduzir, para menos de 1 o número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika) Número de óbitos pelas arboviroses dengue, chikungunya, zika	Número de óbitos pelas arboviroses dengue, chikungunya, zika	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
4.2.4	Realizar levantamento rápido do índice de infestação por Aedes Aegypti – LIR Aa	Número de LIR Aa realizado ao ano	3	2025	Número	3	Número	3	3	3	3
4.2.5	Garantir a quantidade e qualidade dos veículos utilizado nas ações da Vigilância Ambiental e Zoonoses (carro, caminhonete e motos)	Número suficiente de veículos em condições de uso adequados para realização das atividades do setor	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.6	Garantir local de trabalho adequado para análise larvaria – laboratório entomológico	Garantir local de trabalho adequado para análise larvaria – laboratório entomológico Construção do laboratório entomológico	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
4.2.7	Realizar construção de local adequado para guarda e proteção dos veículos de uso do setor de Vigilância Ambiental	Construção finalizada	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
4.2.8	Realizar trabalho educativo nas escolas da rede municipal, estadual e particular sobre Arboviroses e demais segmentos da sociedade	Percentual de trabalho educativo nas escolas da rede municipal, estadual e particular sobre Arboviroses e demais segmentos da sociedade	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.9	Garantir as 100% de visitas domiciliares na área rural e visitas aos PITs-Postos de Informação de Triatomíneos pelos ACEs conforme PCDCH - Programa de Controle da Doença de Chagas	Número de visitas aos PITs – 8 e visitas domiciliares conforme porte do município – mínimo 20% dos imóveis rurais	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.10	Realizar 100% de cobertura de visitas domiciliares pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE) nas residências do município, orientando a população, eliminando criadouros e monitorando possíveis focos de vetores.	Percentual de imóveis visitados pelos ACE.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.11	Garantir monitoramento e combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.nos Pontos Estratégico-PE e imóveis especiais (Abandonados, de difícil acesso, etc)	Número de visitas quinzenais em 80% dos PEs cadastrados e Imóveis especiais conforme demanda.	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
4.2.12	Garantir o efetivo de ACE de acordo com o aumento de imóveis e território do município através de processo seletivo	Número de ACE de acordo com a quantidade de imóveis e lotes do município e demanda de Zoonoses contratados via processo seletivo	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.13	Garantir a vigilância Ambiental em locais de difícil acesso ou que barrem a entrada do ACE através da utilização de Drone,mediante contratação do serviço.	Número de mapeamentos por ano realizados com o auxílio do Drone	3	2025	Número	3	Número	3	3	3	3

4.2.14	Alcançar a cobertura vacinal de 90% antirrábica de cães e gatos estabelecido pelo Ministério da Saúde	Proporção de cães e gatos vacinados nas campanhas	90,00	2025	Percentual	90,00	Percentual	90,00	90,00	90,00	90,00
4.2.15	Investigar 100% dos casos de leishmaniose visceral	Realizar 100% investigação de todos casos humana-LV notificados	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.16	Realizar Senso da População canina e felina nos domicílios	Número total de cães e gatos domiciliados levantados em pelo menos 80% dos domicílios visitados pelos ACE	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00

OBJETIVO Nº 4.3 - Objetivo 4.3: Garantir a a saúde da população através da Ações da Vigilância Sanitária por meio da fiscalização, monitoramento, eliminação e prevenção dos riscos sanitários decorrentes da produção, circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
4.3.1	Realizar análise e inspeção de documentos normativos e registros sanitário.	Percentual de análise e inspeção de documentos normativos atendidas pela VISA	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.2	Realizar a digitação e envio regular de, no mínimo, 5 procedimentos mensais no sistema SIA/SUS.	Número de Procedimentos digitados/mês no SIA/SUS	60	2025	Número	240	Número	60	60	60	60
4.3.3	Garantir quantidade e qualidade dos veículos utilizado nas ações da Vigilância Sanitária	Percentual de veículos com manutenção em dia	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.4	Capacitar a equipe de Vigilância Sanitária para realização do trabalho e para atender às demandas da comunidade	Percentual de Capacitações realizadas conforme demanda.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.5	Realizar 100% das vistorias sanitárias em estabelecimentos sujeitos à fiscalização.	Percentual de vistorias sanitárias realizadas em estabelecimentos sujeitos à fiscalização.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.6	Atender 100%as denúncias recebidas pela VISA	Percentual de denúncias atendidas pela VISA	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

DIRETRIZ Nº 5 - Diretriz Nº 5 : Garantia da Assistência Farmacêutica, no Âmbito do SUS.

OBJETIVO Nº 5.1 - Objetivo 5.1: Promover o acesso à Assistência Farmacêutica nos diversos níveis da Atenção à Saúde, adotando medidas que garantam o acesso aos medicamentos e insumos com segurança, qualidade e menor custo.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
5.1.1	Garantir o atendimento da demanda de medicamentos padronizados pela Relação Municipal de Medicamentos - REMUME	Número de medicamentos disponíveis na APS. (Resolução SES/MG 8.428, 09/11/2022)	80,00	2025	Percentual	80,00	Percentual	80,00	80,00	80,00	80,00
5.1.2	Imóvel para o almoxarifado do Componente Básico da Assistência Farmacêutica	Unidade implantada	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
5.1.3	Abertura de uma unidade regional de dispensação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Hospital Municipal São José.	Unidade implantada.	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
5.1.4	Abertura de mais unidades regionais de dispensação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica nas UBS,tendo como prioridade as UBS Olaria e São Judas.	Unidade implantada	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
5.1.5	Prover recursos financeiros e materiais para execução das ações de educação em saúde	Ação educativa mensal(Resolução SES/MG 8.428, 09/11/2022)	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.6	Contratação de (1) atendente para cada Farmacêutico nas unidades Regionais, para que este consiga executar procedimentos de serviços farmacêuticos clínico-assistenciais,	Profissionais contratados	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.7	Realizar atendimentos farmacêuticos clínico-assistenciais.	40 atendimentos clínico-assistenciais mensais (Resolução SES/MG 8.428, 09/11/2022	240	2025	Número	480	Número	240	360	480	480
5.1.8	Locar o imóvel adequado para funcionamento do serviço do PDCEAF	Unidade do PDCEAF implantada	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
5.1.9	Ampliar a equipe técnica com a inclusão de 01 farmacêutico substituto e mais 01 atendente para implantar a descentralização.	Profissionais contratados	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.10	Adquirir os equipamentos para o funcionamento do setor, conforme o plano de trabalho para execução do PDCEAF (Resolução SES/MG Nº 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021).	Cumprir integralmente o plano de trabalho para execução do PDCEAF	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.11	Qualificação dos processos abertos pelo município descentralizado, com base na ausência de pendências.	Percentual de processos do CEAF registrados pelo município sem pendências por quadrimestre (Resolução SES/MG Nº9.063, DE 18/10/2023)	50,00	2025	Percentual	50,00	Percentual	50,00	50,00	50,00	50,00

DIRETRIZ Nº 6 - Diretriz Nº 6:Garantir a Integralidade a Atenção à Saúde por meio do Fortalecimento da Rede de de Atenção Secundária e Terciaria.

OBJETIVO Nº 6.1 - Objetivo 6.1 Garantir o acesso aos serviços de atenção especializada em tempo oportuno.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
6.1.1	Contratar médicos especializados em áreas prioritárias:cardiologia,psiquiatria,ortopedia,endocrinologia,neurologia,dermatologia,otorrinolaringologia,uropologia para aumentar o número de consultas especialidades.	Percentual de especialidades prioritárias ofertada	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1.2	Contratar exames especializados conforme demanda local	Percentual de exames ofertados	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1.3	Construir o Centro de Fisioterapia,conforme exigência da VISA.	Centro de Fisioterapia construído conforme exigência da VISA.	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
6.1.4	Aquisição de equipamento para atenção especializada	Quantitativo de equipamentos adquiridos para a atenção especializada	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
6.1.5	Otimizar o fluxo de encaminhamentos de exames, consultas e procedimentos conforme protocolo de regulação de acesso.	Exames, consultas e procedimentos encaminhados conforme protocolo de regulação de acesso.	100,00	2025	Percentual	100	Número	100	100	100	100
6.1.6	Disponibilizar exames de biópsias conforme demanda.	Exames de biópsias disponibilizados conforme demanda.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1.7	Garantir transparência à população sobre os serviços prestados na atenção especializada.	Sistema de Transparência em funcionamento	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1.8	Garantir a regulação do acesso a partir de critérios clínicos, mediante avaliação do médico regulador.	Acesso mediante a avaliação do médico regulador	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
OBJETIVO Nº 6.2 - Objetivo 6.2:Garantir o deslocamento seguro e eficiente para o acesso dos usuários aos serviços de saúde referenciados.											

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
6.2.1	Manter o setor de transporte com recursos humanos, motoristas, compatível com demanda	Nº de motorista compatível com a demanda	24	2025	Número	24	Número	24	24	24	24
6.2.2	Manter a frota de veículos suficiente para garantir em tempo hábil o acesso dos usuários aos serviços de saúde referenciados	Nº de veículos compatível com a demanda	22	-	Número	22	Número	22	22	22	22
6.2.3	Garantir o serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota local	Contratação de empresa para prestação dos serviços.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.4	Garantir passagens rodoviárias para os pacientes em tratamento fora de domicílio, quando o mesmo necessita realizar tratamento em outro estado.	Nº de passagens fornecidas conforme demanda	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.5	Garantir o pagamento das diárias dos motoristas	Diárias efetivamente pagas	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.6	Garantir o rastreador veicular para gerenciamento da frota local.	Nº de veículos com rastreador	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.7	Viabilizar o funcionamento das casas de apoio para acolher pacientes e acompanhantes que necessitam de tratamento em outros municípios	Número de Casas de Apoio em Funcionamento.	3	2025	Número	3	Número	3	3	3	3

OBJETIVO Nº 6.3 - Objetivo 6.3:Garantir a Contratualização dos Prestadores de Serviço ,Conforme a Necessidade da População.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
6.3.1	Monitorar as metas assistenciais e qualitativas, garantindo o acesso e a eficiência dos recursos públicos.	Monitoramento realizados	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.2	Apoiar o Funcionamento Ininterrupto da UTI	Funcionamento Ininterrupto da UTI	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00

OBJETIVO Nº 6.4 - Objetivo 6.4:Garantir à população o acesso oportuno e qualificado à rede de Urgência e Emergência de forma Regionalizada.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2026-2029)	Unidade de Medida	Meta Prevista			
			Valor	Ano	Unidade de Medida			2026	2027	2028	2029
6.4.1	Adquirir ambulância para atender as demandas do Pronto atendimento Municipal, garantindo acesso ao serviço de Urgência e Emergência.	Nº de ambulâncias adquiridas.	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
6.4.2	Garantir a operação contínua do Serviço Móvel Urgência e Emergência /SAMU 192	Manter o Vínculo com o CISURG	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.3	Ampliar a cobertura do SAMU 192, incluindo o atendimento da USA (Unidade de Saúde Avançada)	USA Implantada	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
6.4.4	Garantir a população um atendimento de urgência,seguro e com qualidade , através de aquisições de equipamentos médicos/hospitales para Hospital Municipal São José e nova instalação da UPA.	Equipamentos Adquiridos para Atender a UPA	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.5	Garantir a Toda a população acesso a exames laboratoriais com qualidade e em tempo oportuna às demandas da Urgência e Emergência.	Oferta oportuna de Exames Laboratoriais no Serviço de Urgência e Emergência	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.6	Garantir conforto, dignidade e humanização no atendimento, pilares fundamentais da política da atenção hospitalar do SUS.	Contratar empresa especializada para prestação de serviço de hotelaria hospitalar, abrangendo atividades de apoio como gestão de rouparia, serviços de copa/Nutrição, camareira hospitalar e apoio ao paciente	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.7	Assegurar continuidade da assistência em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.	Adquirir gerador de energia elétrica com instalação e manutenção, visando garantir o fornecimento ininterrupto de energia para unidade do HMSJ.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.8	Ampliar e qualificar o acesso da população ao serviços de Urgências e Emergência através da construção da UPA.	Construção da Sede da Nova UPA	25,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
6.4.9	Garantir gestão eficiente dos prontuários e documentos clínicos	Locar um espaço para transferência do arquivo físico do Pronto atendimento Municipal	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.10	Fortalecer a assistência em situações de urgências e emergências sem precisar se deslocar com o paciente	Aquisição TC na UPA	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.11	Aquisição de um veículo utilitário com foco em atender as necessidades operacionais e logística da organização.	Aquisição de Automóvel Utilitário para UPA	1	2025	Número	1	Número	1	1	1	1
6.4.12	Garantir a população um atendimento de urgência ,seguro e com qualidade, através manutenção do quadro RH	Manter honorários dos profissionais em dia e compatível com o mercado.	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.13	Garantir Acesso aos Exames de Radiologia Conforme Demanda.	Exames de RX e Mamografia Executados	100,00	2025	Percentual	100,00	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00